



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JANUARI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi	2
2.2 Misi	2
2.3 Motto	2
2.4 7 Nilai Budi Utama	2
2.5 Struktur Organisasi	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI).....	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan	4
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada	6
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan	15
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik.....	15
3.3.2 Rawat Inap.....	18
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)	27
3.3.4 High Care Unit (HCU)	28
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD).....	29
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO).....	30
3.4 Kinerja Bidang Penunjang	32
3.4.1 Instalasi Farmasi	32
3.4.2 Laboratorium.....	48
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran	52
3.4.4 Radiologi	65
3.4.5 Gizi	70
3.4.6 CSSD - Laundry	73
3.5 Kinerja Umum dan Keuangan	76
3.5.1 SDM	76
3.5.2 MFK dan K3RS	84
3.5.3 Security.....	87
3.5.4 Parkir	90
3.5.5 Humas Marketing	90
3.5.6 Penjaminan	93
3.5.7 PIPP – MOD - MPP.....	93
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	102
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum	103
3.6 Komite dan Tim	104
3.6.1 Komite Mutu.....	104
3.6.2 Komite PPI.....	140
3.6.3 Tim PKRS	151
3.6.4 Tim Prognas.....	154
3.6.5 Tim PPRA	192
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT	198
3.7 Permasalahan Rumah Sakit	199
3.8 Profil SDM	207
Bab IV Kesimpulan dan Saran	210
Bab V Penutup	211
Lampiran	212

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Januari Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



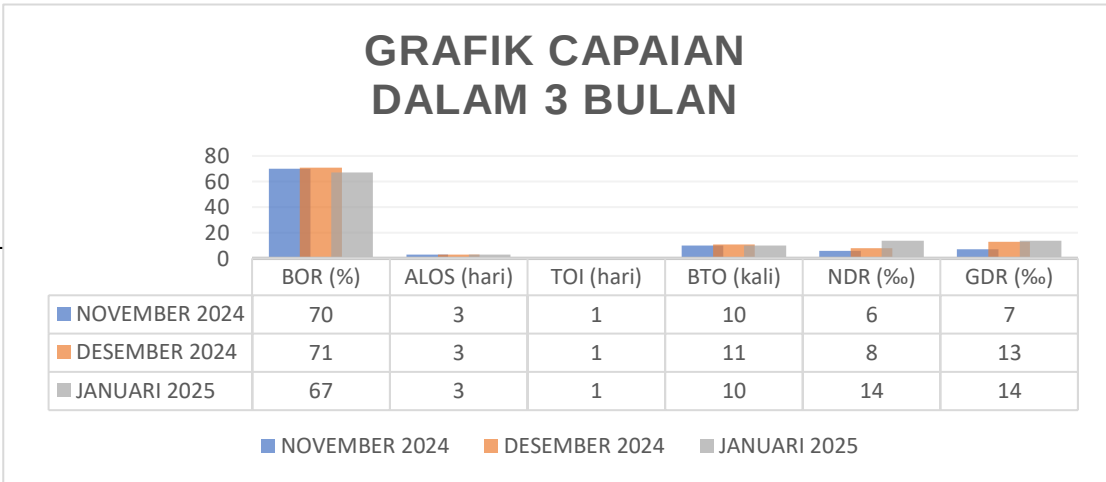
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	BOR	70	71	67
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	1	1
4	BTO	10	11	10

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



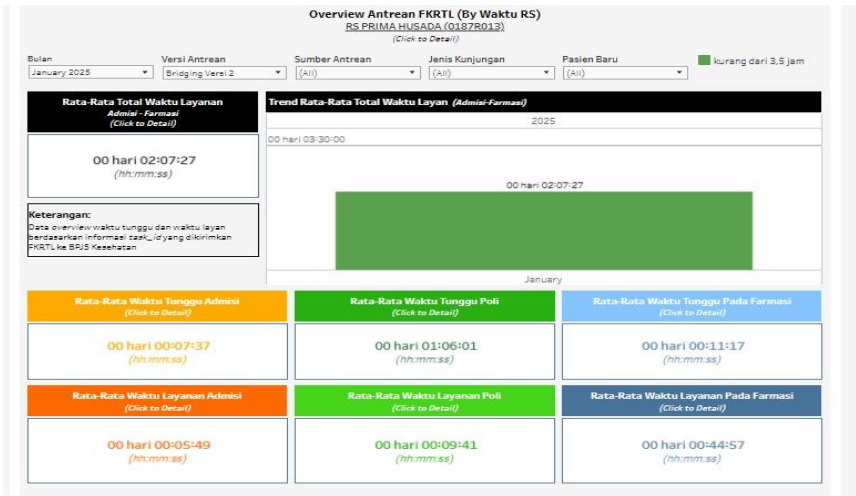
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil perhitungan statistik rumah sakit pada Bulan Januari Tahun 2025, kinerja RSPHM didapatkan hasil nilai indicator :

- BOR sebesar 67% (standar : 60-85%) sesuai standar.
- LOS sebesar 3 hari sesuai dengan standard RSPHM terkait SE dari PT.DPM khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari)
- TOI sebesar 0.50 hari (standar : 1-3 hari)
- BTO sebesar 10 kali (standar : 4-5 kali)

BOR Bulan Januari Tahun 2025 di bandingkan dengan Bulan Desember Tahun 2024 mengalami penurunan, salah satu faktor penurunan BOR karena pasien rawat inap di Bulan Desember mengalami penurunan. Nilai BOR tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan tempat tidur di Bulan Januari sudah standar. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan tempat tidur sudah efisien dari segi ekonomi menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2024)
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2024	Januari
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	02:07:27
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	00:07:37
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	00:05:49
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	01:06:01
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	00:09:41
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	00:11:17
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	00:44:57

Analisis :
 Pada bulan ini jika dibandingkan rata-rata tahun 2024 maka bulan ini masih lebih baik dilihat dari selisih waktu. Yang perlu diperhatikan adalah waktu tunggu poli.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	JENIS	TARGET	JANUARI
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	45,98%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	96,72%

Analisis :
 Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Senam hamil berjalan rutin	-
		Penambahan TT rawat inap, untuk VIP kelas 1 dan kelas 2	Sudah selesai	Fasilitas seperti tv masih belum terpasang
3	IRJA	Poli Eksekutif	Sudah berjalan mulai dari 2024 untuk bulan januari 2025 ada 17 pasien, 16 pasien di dominasi oleh pasien obgyn	Pasien anak menurun karena pasien anak yang ke poli Sakura hanya pasien yang mencari dr Dicky bukan karena tertarik akan layanannya. Pasien dewasa (IPD dan Neuro) tidak tertarik pada poli Sakura karena merasa sudah cukup dengan poli regular dengan jaminan BPJS
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi, sudah terpasang poster di IGD tentang pelayakit yang tidak terkafer bpjs	Sudah terpasang di IGD
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. Website Primantara	2. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23-09-2024 3. Proses penyelesaian oleh Programmer PT.	Dalam antrian programmer.
		2. Jasa pengantaran obat	1. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS.

			serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap. 2. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. 3. Jumlah pasien promo yang melakukan repeat order di bulan selanjutnya ada 145 dari 270 pemesan, yaitu sekitar 53%. 4. Terdapat peningkatan permintaan, Bulan November jumlah pengantaran sebanyak 1253.	
		3. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	1. TTD elektronik untuk pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. 2. TTD elektronik untuk pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien pulang rawat inap masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian programmer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		4. KPO elektronik (e-KPO)	1. Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. Pengajuan ke progamer untuk dibuatkan fitur e-KPO yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. 2. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. 3. Jumlah KPO	Dalam antrian programmer.

			tertinggal : 408.	
		6. Pengadaan LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.	1. Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk melakukan pengajuan proposal ke PT terkait pemindahan ruang LAF, yaitu rencana diajukan di Lantai Maternitas (ex IKO Covid). 2. Proposal pengajuan sudah diterima PT → ACC	Dalam proses renovasi sebagai persiapan AKRE pada akhir Tahun 2026.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	1. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). 2. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. 3. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. 4. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Monitoring dan Evaluasi
		8. Resep Manual IGD	1. Permintaan obat menggunakan resep manual di IGD. 2. Resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan. 3. Perubahan alur untuk meminimalisir selisih SO.	Berjalan awal Tahun 2025. Hasil SO membaik, yaitu +226.818

2	Gudang Farmasi	Scan Barcode	1. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT. 2. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04-10-2024. 3. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer 4. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia 5. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer	Rencana trial menunggu Programmer PT
	Perluasan Gudang Farmasi		1. Mengajukan perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. 2. Penurunan buffer dari lantai 2 menggunakan katrol yang tidak terpakai di Laundry.	Sudah berjalan
	Perbaikan mutasi barang		1. Sudah dilakukan koordinasi dengan petugas IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO. 2. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. 3. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. 4. Sistem stok IKO sudah dikunci. 5. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. 6. Membuat alur dan kesepakatan terkait	Monitoring dan Evaluasi. Supervisi Kabid.

			penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. Menggunakan tabel penggunaan isonest.	
3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	1. Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada Bulan Juni 2025. 2. Melakukan pendataan fitur yang dibutuhkan pada SIMRS, lalu diserahkan kepada Programmer PT.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. Permasalahan E-RM dan layanan Poli yang belum masuk E-RM sudah disampaikan kepada Programmer PT sekaligus flow chart.
		2. Serah terima DRM menggunakan system digital.	Serah terima menggunakan spreadsheet (sudah berjalan).	Monitoring dan Evaluasi.
		3. Permintaan form menggunakan sistem digital.	Permintaan form dari unit menggunakan google form, sudah berjalan mulai Bulan Juni 2024.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Dokumentasi DRM lama	1. Melakukan scanning form kedalam SIMRS. 2. Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. 3. Menunggu programmer membuat fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
		Retensi DRM	1. Data DRM yang akan diretensi menunggu Programmer PT sebelum dilakukan pemilahan dan pemusnahan DRM. 2. Pemusnahan	Follow up Programmer PT.

			terakhir dilakukan pada Tahun 2018.	
		Rekap Data Laporan Dinkes	1. Data yang dibutuhkan tidak semua bisa ditarik oleh system. 2. RM membuat Google Spreadsheet untuk diisi oleh unit-unit terkait setiap harinya. 3. Tujuannya untuk memudahkan Karu RM dalam pelaporan RL ke Dinkes tepat waktu.	Dalam Proses.
4	Pendaftaran	1. Anjungan Pasien Mandiri.	1. Melakukan studi banding atau mencari informasi terkait penggunaan APM di RS lain. 2. Membuat flowchart dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam proses dan diajukan ke Program Kerja Tahun 2025.
		2. Papanisasi	Memasang nama dan foto petugas admisi pada setiap loket dan harus dilakukan update tiap shift setiap hari.	Dalam proses.
		3. Pendaftaran pasien	Reservasi pasien umum dan asuransi melalui web, disertai pembayaran melalui VA.	Proses mengerjakan TOR
4	Radiologi	1. Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
		2. Menambah jam pelayanan supaya pelayanan maksimal.	Melakukan close recruitmen untuk mengisi jam kosong pada siang hari.	Ada Sp.Rad yang akan bergabung pada awal Bulan Januari 2024
		3. Respon Time Radiologi	Kolaborasi dengan perawat untuk melakukan pencatatan di Google Spreadsheet secara real time.	Mulai dijalankan awal Tahun 2024.
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Stok Opname BDRS	BDRS berjalan mulai 29 November 2024.	SO akan dilakukan Pada

				hari Sabtu, 22-02-2025 pukul 13.00 WIB.
		3. Penambahan fitur	1. Penambahan fitur upload hasil laboratorium rujukan dari luar RS. 2. Penambahan fitur centang otomatis hasil pemeriksaan yang abnormal, batas atas dan batas bawah sudah dicatat dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam antrian Programmer PT.
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan.	1. Kolaborasi dengan Humas&Marketing. 2. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
		2. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
		3. Daftar Menu Makanan Penunggu VIP.	Book Menu sudah proses dikerjakan oleh PKRS.	Dalam proses.
		4. Registrasi alat makan	1. Kolaborasi dengan penyaji untuk melakukan pencatatan keluar masuknya sendok di Google Spreadsheet. 2. Perbaiki alur saat mengambil peralatan makan di ruangan, jika ditemukan sendok hilang maka dicatat di Google Spreadsheet dan dioperkan ke perawat ruangan untuk ditagihkan ke saat pasien KRS. 3. Dilakukan stok opname setiap bulan untuk menghitung peralatan makan. 4. Membuat SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS.	Registrasi alat makan sudah berjalan sejak Bulan Januari 2024 Proses dibuatkan SPO kehilangan alat makan, penggantian biaya dilakukan di Kasir, jika tidak tertagihkan maka tanggungjawab unit bersama.
7	Dapur	Perbaiki menu makanan dan plating.	1. Sudah dilakukan supervisi oleh	Monitoring dan Evaluasi.

			Direktur Utama PT DPM pada hari Senin, 18 November 2024. 2. Kebijakan penggunaan alat makan dan SPO plating sudah dibuatkan sebagai pedoman penyaji dalam melakukan pekerjaan.	
		Menu makanan buka puasa senin-kamis.	Program PT berjalan mulai tanggal 09 Desember 2024. Yang sudah disiapkan : 1. Daftar siklus menu makanan. 2. SPO pemesanan makanan buka puasa (+). 3. Link google form untuk pemesanan (+). 4. Kebijakan pemesanan makanan H-1 maksimal pukul 13.00 WIB.	Monitoring dan Evaluasi.
7	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilitor (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
		3. Perbaikan jam kerja	Pelayanan mulai pukul 06.30-21.00 WIB, jika ada alat yang akan disetor diatas jam pelayanan maka dilakukan pre-cleaning di unit masing-masing.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
8	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital	Rencana permintaan	Dalam proses.

		form untuk permintaan linen.	sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. Belum terealisasi.	
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP.	Dalam Proses.
		4. Perbaikan jam kerja	Pelayanan ada 3 shift, shift malam dimulai pukul 22.00-04.00 WIB tanpa jam istirahat, dan memenuhi stok di unit.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
9	Lain-lain	Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan Kabid.	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman pelayanan, pengorganisasian, dan pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : 1. Tanya Jawab 2. Role Play	1. RM dan Pendaftaran Hari : Senin, 17-02-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai. Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom). 2. Farmasi Hari : Selasa, 18-02-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 3. Gizi Hari : Rabu, 19-02-2025 Waktu : 11.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 4. Laboratorium Hari : Kamis, 20-02-2025 Waktu : 13.00

				WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 5. Radiologi Hari : Jum'at, 21-02-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 6. CSSD dan Laundry Hari : Sabtu, 22-02-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Laundry (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom)
--	--	--	--	---

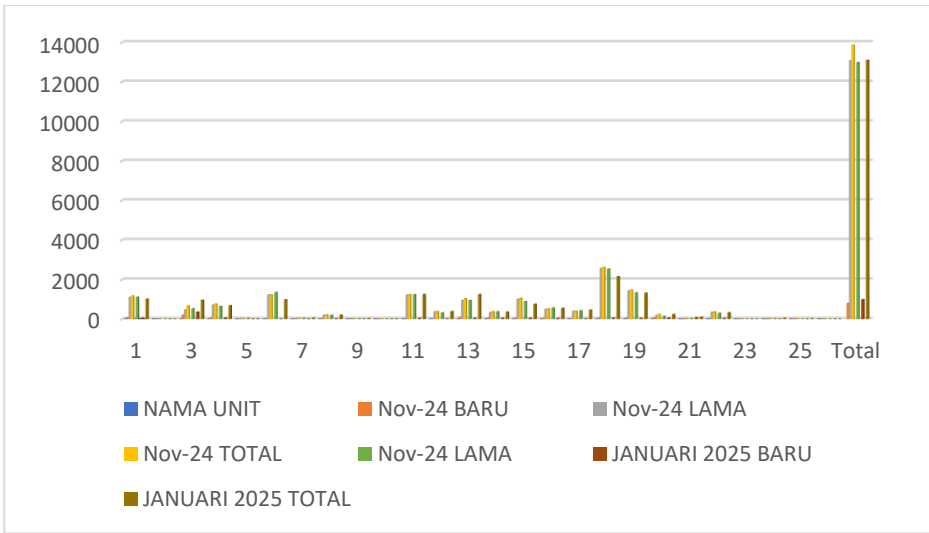
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	NOVEMBER 2024			DESEMBER 2024			JANUARI 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	68	1103	1171	54	1105	1159	49	960	1009
2	Anak sakura	0	1	1	2	3	5	1	0	1
3	IGD	197	467	664	277	524	801	355	600	955
4	Klinik Bedah	51	708	759	60	640	700	58	624	682
5	Klinik Bedah Plastik	1	25	26	1	32	33	2	12	14
6	Klinik Fisioterapi	3	1218	1221	4	1353	1357	5	974	979
7	Klinik Gigi Periodonti	8	29	37	5	40	45	6	40	46
8	Gigi spesialis pedodontis	22	191	213	20	191	211	20	181	201
9	Gigi Ortodonti	3	13	16	3	21	24	3	25	28
10	Klinik Ibu dan Anak	0	8	8	0	8	8	0	16	16
11	Klinik Jantung	21	1214	1235	25	1235	1260	37	1209	1246
12	Klinik Jiwa	10	366	376	15	320	343	9	372	381
13	Klinik Kandungan	94	935	1029	133	945	1078	108	849	957

14	Klinik Kulit dan Kelamin	47	330	377	24	371	395	45	307	352
15	Klinik Mata	56	997	1051	64	884	948	42	713	755
16	Klinik Orthopedi	29	496	527	31	559	590	35	515	550
17	Klinik Paru	10	390	400	15	423	438	15	444	459
18	Klinik Penyakit Dalam	46	2566	2612	52	2531	2583	60	2085	2145
19	Klinik Syaraf	37	1429	1466	47	1324	1371	39	1277	1316
20	Klinik THT	57	185	242	37	133	170	56	178	234
21	Klinik Umum	13	13	26	67	20	87	69	28	97
22	Klinik Urologi	18	350	368	49	295	344	36	286	322
23	Gizi	3	11	14	0	1	1	3	1	4
24	Bedah Saraf	1	19	20	0	22	22	2	38	40
25	Obgyn Sakura	5	9	14	10	0	10	4	12	16
26	Penyakit dalam sakura	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total		795	13077	13859	995	12980	13983	988	12107	13095



Analisis :

1. Kunjungan di bulan januari turun dari bulan sebelumnya,sebanyak 8,4% dari bulan desember 2024. Analisnya karena DPJP jarang ada yang cuti panjang dan banyaknya tanggal merah di bulan januari ,dan karena ada BA dari bpjs dengan peraturan rujuk internal sehingga dari FKT juga membatasi kunjungan ke FKTRL
2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2145 pasien. Kunjungan tersebut menurun dari bulan sebelumnya sebanyak 438 pasien,
3. Kunjungan poli gigi ortodonti masih sedikit, sebesar 28 pasien, karena hanya menerima pasien umum saja, dan tidak bisa melayani pemasangan behel atau kawat gigi. Sehingga hanya menangani kasus poli gigi non spesialis pada umumnya
4. Untuk poli pedodonti anak meningkat tiap bulannya sejak HFIS pelayanan kedokteran gigi anak di acc, bulan januari, kunjungan poli gigi anak menurun 4,3% dibanding bulan sebelumnya karena membatasi pasien karena ada pendingan dan juga karena jadwal HFIS nya tidak panjang
5. Kunjungan poli eksekutif adalah 18 kunjungan. Kunjungan terbanyak adalah dari Obgyn sakura 16 pasien, Anak sakura : 1 pasien, Klinik IPD dr Zoraida, SpPD, dr Dewi, SpS dan dr Syahrir, SpN masih belum ada kunjungan bulan ini.

Rencana Tindak Lanjut :

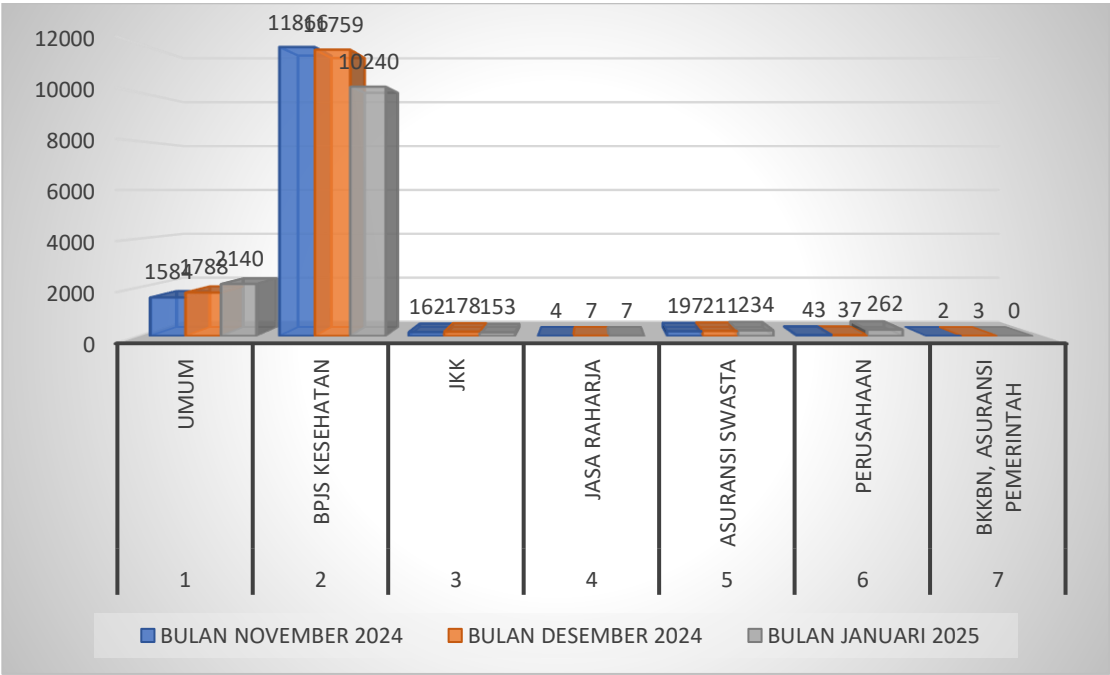
1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli sakura
3. Menambah jam HFIS untuk poli pedodonti sehingga akan menambah jumlah pasien

- 4. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- 5. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- 6. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 7. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 8. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.
- 9. Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupu prolanis klinis MS,bahwa dokter gigi ortodonti (perawat gigi) dan poli sakura
- 10. Sosialisasi pada perusahaan dan stakeholder bahwa ada poli sakura yang menyediakan layanan one stop service
- 11. Mengajukan pelayanan baru otho,bedah,uro dan kulit di Poli Sakura

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN NOVEMBER 2024	%	BULAN DESEMBER 2024	%	BULAN JANUARI 2025	%
1	Umum	1584	11,43%	1788	12,79%	2140	16,72%
2	BPJS Kesehatan	11866	85,63%	11759	84,09%	10240	79.99%
3	JKK	162	1,17%	178	1,27%	153	1,20%
4	Jasa raharja	4	0,03%	7	0,05%	7	0,05%
5	Asuransi swasta	197	1,42%	211	1,51%	234	1,83%
6	Perusahaan	43	0,31%	37	0,26%	262	2,05%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	2	0,01%	3	0,02%	0	0%
	Total	13858	100%	13983	100%	12802	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien bulan Januari 2025 berdasarkan cara pembayaran menurun 8,4% dari bulan desember 2024 . Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 84,09%. Kunjungan bpjs menurun di dibandingkan bulan desember 2024 dikarenakan banyaknya rujukan menurun dan banyaknya tanggal merah di bulan januari

Kunjungan terendah berdasarkan cara pembayaran kunjungan asuransi pemerintah dengan 0% karena sudah bisa di lakukan di faskes pertama

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional.

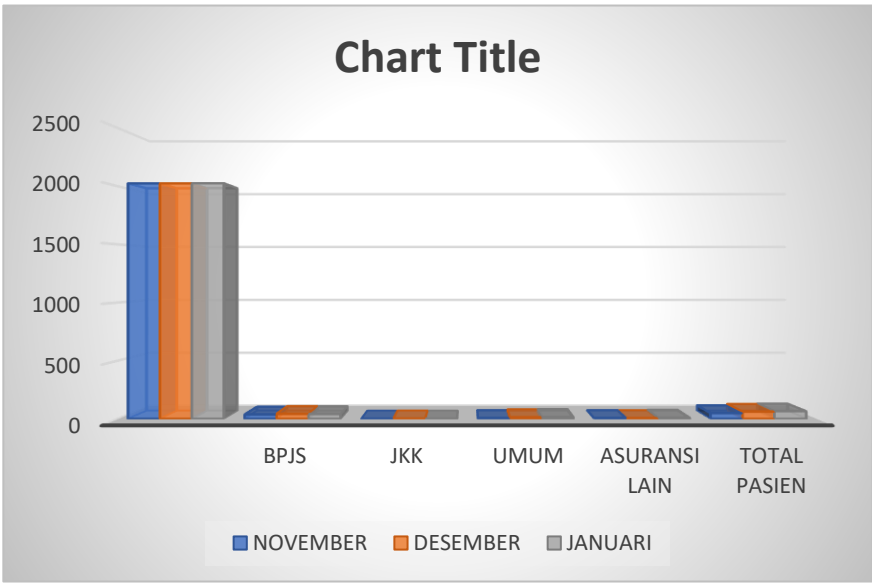
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024- Januari 2025)

NO	HAL	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	38	43	42	↓ 2,3%
2	JKK	0	1	0	↓ 100%
3	Umum	6	13	15	↑ 15,38%
4	Asuransi Lain	6	5	9	↑ 80%
Total Pasien		50	62	66	↑ 6,45%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (November 2024- Januari 2025)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Januari 2024	42	15	0	9	66
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan januari	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan ,untuk bulan januari 2025 mengalami	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari tidak ada	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari mengalami peningkatan 80%	Total pasien bulan januari 2025 meningkat 6,45 % dari bulan desember 2024

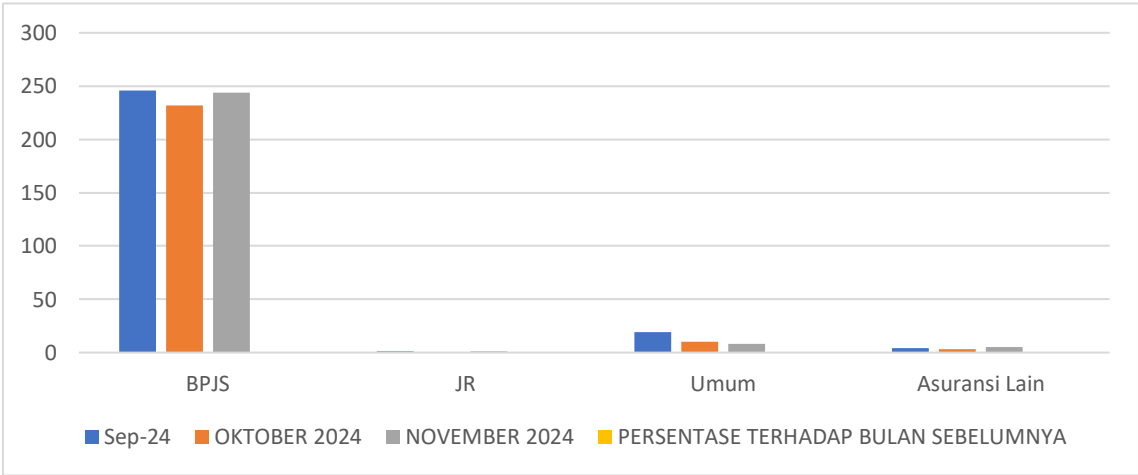
		mengalam i penurunan dari bulan sebelumnya 2,3%	peningkatan 15,38% karena banyak pasien yang membutuhkan ruangan vip	peningkat an		
	RTL	1. Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran 2. Rencana penambahan VVIP 1 TT 3. Memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP 4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap 5. Bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama perusahaan perusahaan yang baru 6. Meningkatkan pelayanan yang lebih ekstra kepada pasien 7. Mempromosikan ruangan vip/vvip lewat sosial media				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (November 2024-Januari 2025)

NO	HAL	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	244	297	253	↓ 17,3%
2	JR	1	0	2	↑100%
3	Umum	8	17	19	↑ 10,5%
4	Asuransi Lain	5	2	1	↓100%
Total Pasien		258	316	275	↓15%

3.1.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024-Januari 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

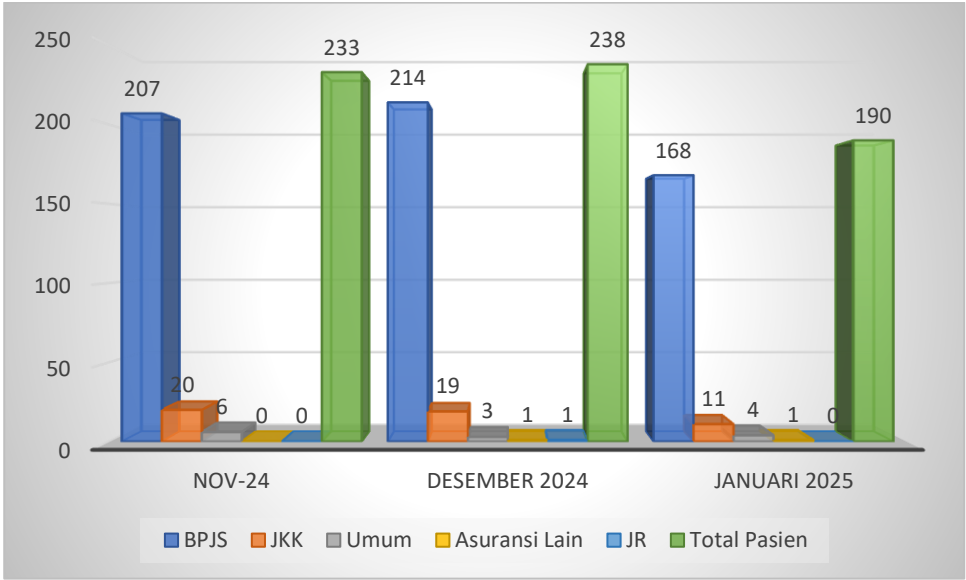
NO.	BULAN JANUARI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIENT
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 17,3 % dari bulan sebelumnya disebabkan banyaknya kunjungan di IGD untuk pasien anak menurun	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan, untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 10,5% dari bulan sebelumnya disebabkan dengan adanya terpasangan nya 144 poster yang ada dari BPJS sehingga pasien umum meningkat	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 100%	Total keseluruhan bulan januari mengalami penurunan 15% dari bulan desember 2024 (41 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya 2. Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG 4. Program taman anak-anak harus di terealisasikan di irna anak untuk tahun ini 5. Berkoordinasi dengan Marketing untuk kunjungan ke TK atau paud tentang pelayanan gigi anak baru				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024- Januari 2025)

NO	HAL	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	207	214	168	↓21,49%
2	JKK	20	19	11	↓ 21,05%
3	Umum	6	3	4	↑25%
4	Asuransi Lain	0	1	1	0%
5	JR	0	1	0	↓ 100%
Total Pasien		233	238	190	↓20,16%

3.1.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024-Januari 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

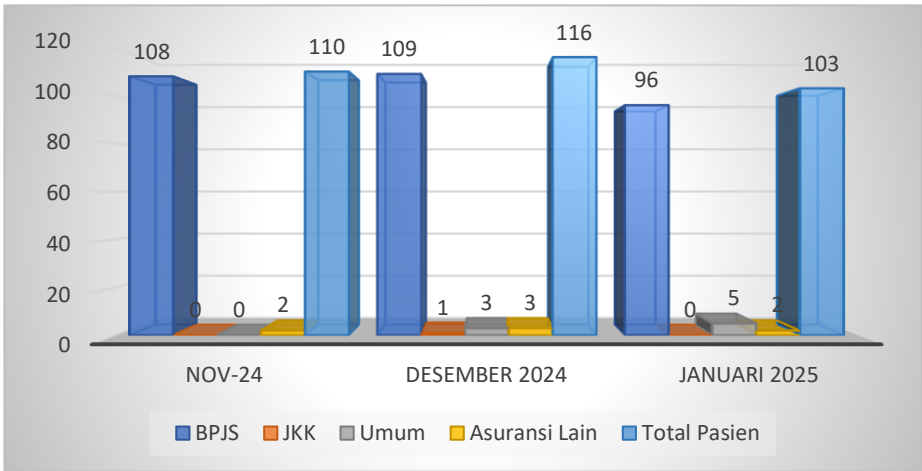
NO.	BULAN JANUARI	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian januari 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari mengalami penurunan 21,49% dari bulan desember 2024 disebabkan kunjungan di IGD untuk pasien yang rawat inap juga menurun dan pasien lodingan dari irja juga menurun	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir kunjungan pasien umum belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 25% dengan adanya skrining yang tepat di IGD dan di tutupnya rumah sakit persada	Pasien JKK 3 dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan kunjungan untuk bulan januari 2024 mengalami penurunan 21,05% dari bulan sebelumnya	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir stagnan	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengalami penurunan 20,16% (48 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Pemberian edukasi yang baik 7. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.1.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2024-Januari 2025)

NO	HAL	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	108	109	96	↓ 13,50%
2	JKK	0	1	0	↓ 100%
3	Umum	0	3	5	↑ 40%
4	Asuransi Lain	2	3	2	↓ 50%
Total Pasien		110	116	103	↓ 12,62%

3.1.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2024-Januari 2025)



3.1.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

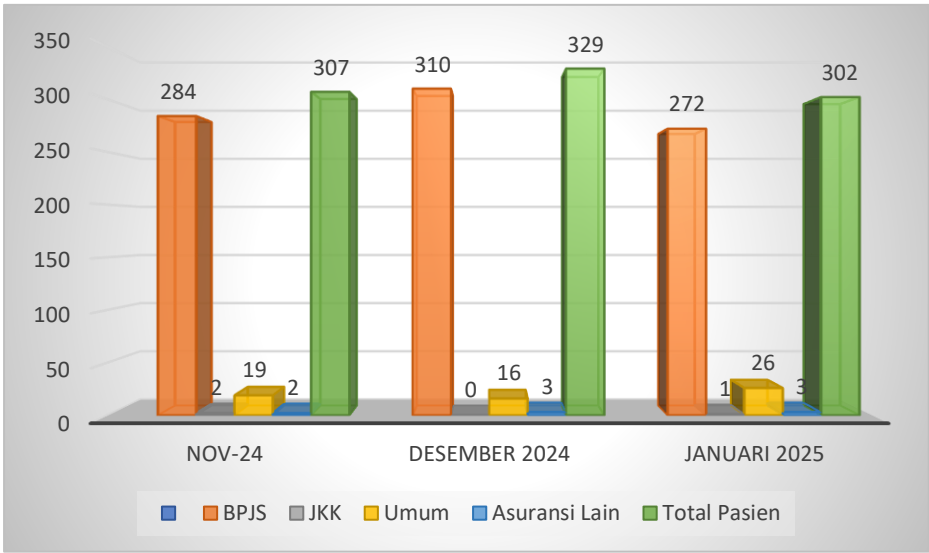
NO.	BULAN JANUARI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 13,5% dari bulan sebelumnya	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan januari 2025 40% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir ada di bulan desember untuk bulan januari 2025 tidak ada pasien	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 50% dari bulan sebelumnya	Pada bulan januari 2025 total pasien mengalami penurunan 12,62 % 13 pasien di bandingkan bulan desember 2024
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.1.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024-Januari 2025)

NO	Penjamin	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	284	310	272	↓12,25%
2	JKK	2	0	1	↑ 100
3	Umum	19	16	26	↑ 28%
4	Asuransi Lain	2	3	3	0%
Total Pasien		307	329	302	↓ 7,16%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024- Januari 2025)



3.1.1.3.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JANUARI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 12,25% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjunga di IGD juga menurun dengan adanya BA dari BPJS yang 144 pasien bisa dilakukan di faskes pertama dan juga lodingan yang ada di rawat jalan juga menurun	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan dari bulan desember 2024 28%	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan desember 2024	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan mengalami peningkatan untuk bulan januari 2025 total pasien 3	Total semua pasien mengalami penurunan pasien 7,16%
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

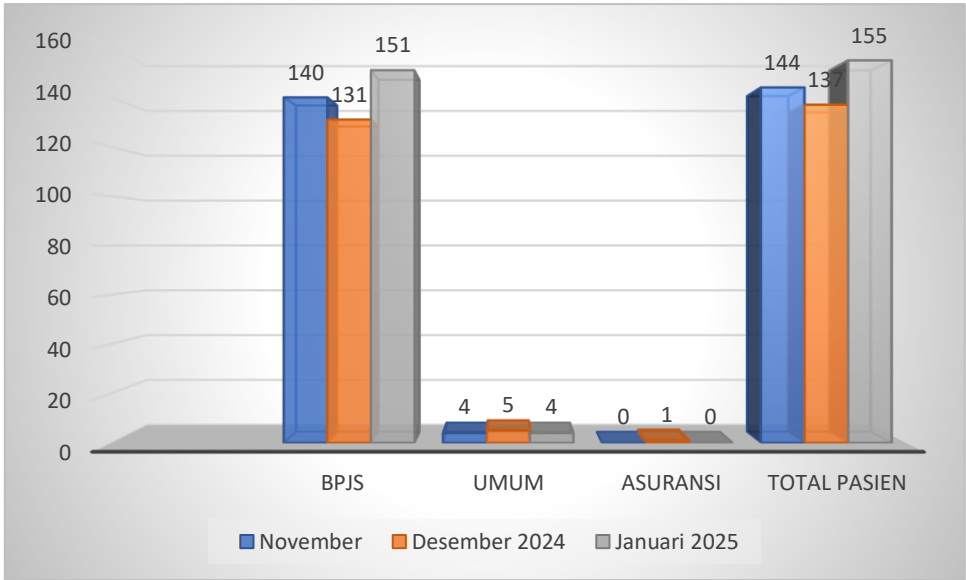
		2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD	
--	--	--	--

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.1.4 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024-Januari 2025)

NO	HAL	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	140	131	151	↑ 13,2%
2	Umum	4	5	4	↓ 20%
3	Asuransi	0	1	0	↓100%
Total Pasien		144	137	155	↑ 11,6%

3.1.1.1.3 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024- Januari 2025)



3.1.1.4.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

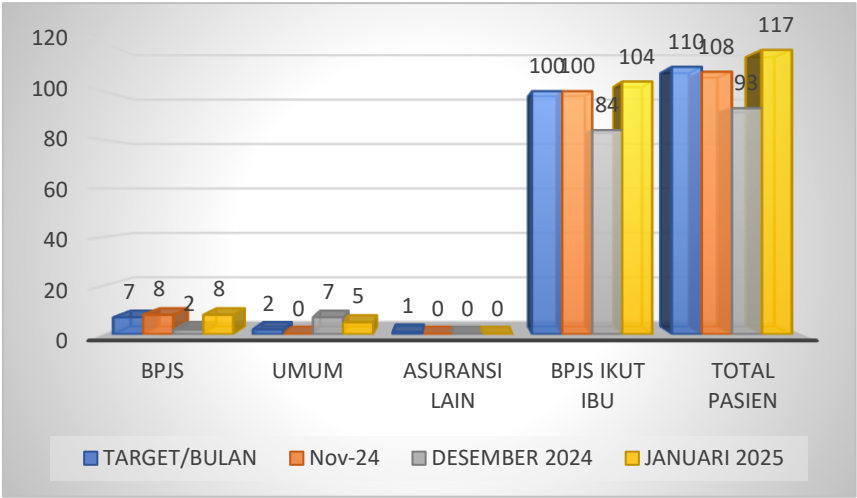
NO	BULAN	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian November 2024-Januari 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 13,2% disebabkan kunjungan pasien melahirkan dan rujukan bidan meningkat di IGD	Pasien umum dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 20% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 100%	Total pasien bulan Januari 2025 mengalami peningkatan 11,6%
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing terutama untuk kunjungan ke bidan bidan praktek yang mempunyai BPJS	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan di maternitas	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (September- November 2024)

NO	HAL	TARGET/BULAN	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	8	2	8	↑ 42,8%
2	Umum	2	0	7	5	↓ 100%
3	Asuransi Lain	1	0	0	0	100%
4	BPJS IKUT IBU	100	100	84	104	↑ 18,7%
Total Pasien		110	108	93	117	↑ 23,4%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024- Januari 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

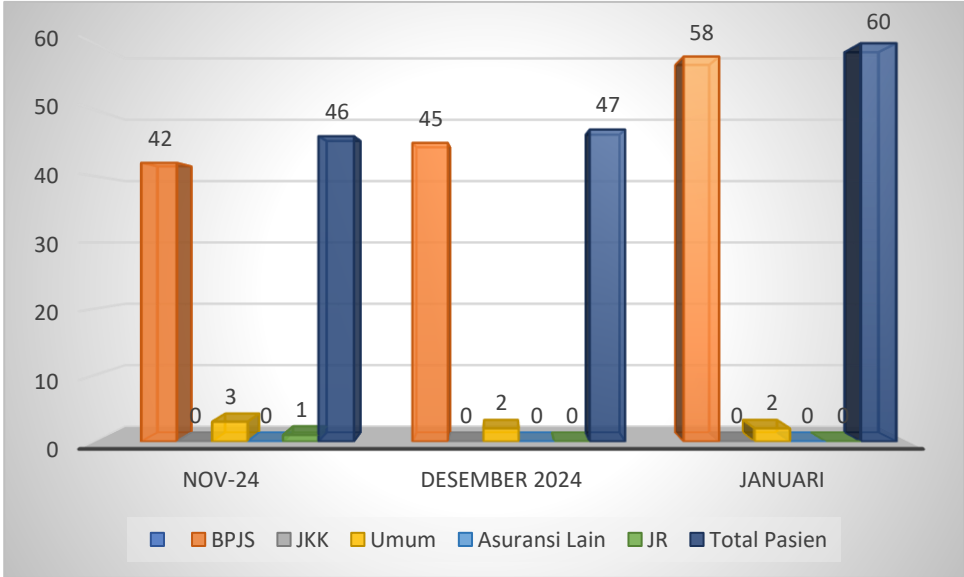
NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Januari 2025	8	5	0	104	117
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan januari 2025 penurunan 4,27 % dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 tidak ada pasien sama sekali	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 20,5% dari bulan sebelumnya	Total pasien dalam bulan januari 2025 mengalami
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing, membuat program foto bayi dari unit neo

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2024-Januari 2025)

NO	PENJAMIN	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	42	45	58	↑ 28,8%
2	JKK	0	0	0	tetap
3	Umum	3	2	2	tetap
4	Asuransi Lain	0	0	0	tetap
5	JR	1	0	0	tetap
Total Pasien		46	47	60	↑ 27,65%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2024-Januari 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

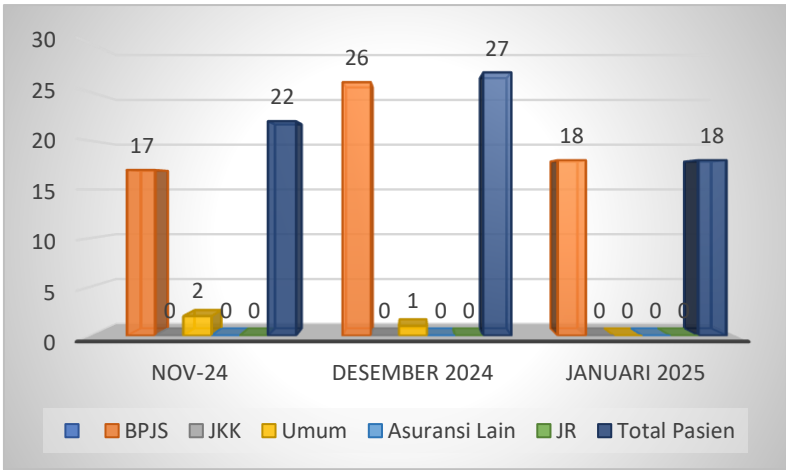
NO.	BULAN JANUARI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan januari 2025 meningkat 28,8% dari bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 jumlah kunjungan icu sama tetap dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien meningkat 27,65% dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.1.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2024-Januari 2025)

NO	HAL	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	17	26	18	↓30,76%
2	JKK	0	0	0	tetap
3	Umum	2	1	0	↓ 100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		22	27	18	↓ 33,3%

3.1.1.3 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(November 2024-Januari 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JANUARI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 30,76% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan januari 2025 mengalami penurunan 100% di bandingkan bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien bulan januari 2025 mengalami penurunan 33,33%

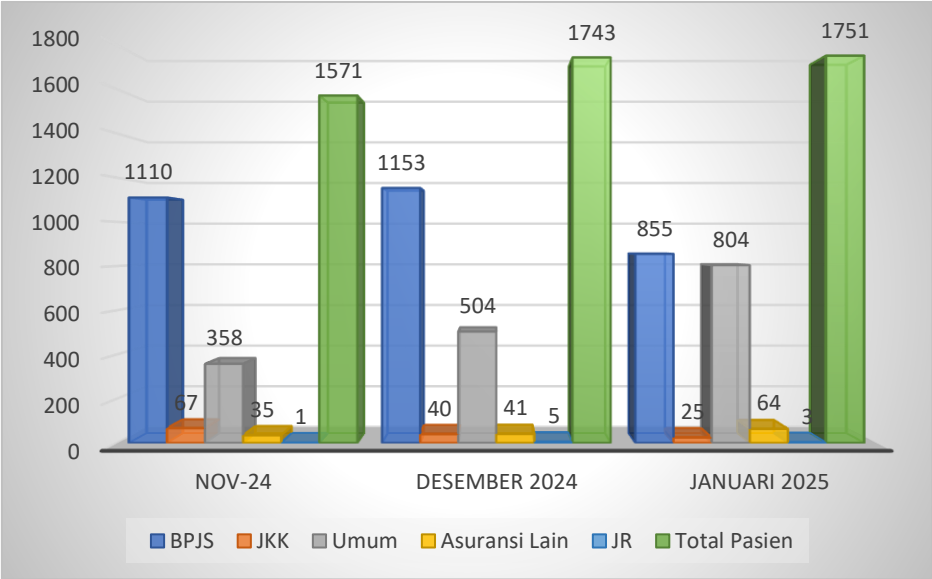
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.1.4 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024- Januari 2025)

NO	HAL	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1110	1153	855	↓25,8%
2	JKK	67	40	25	↓60%
3	Umum	358	504	804	↑37%
4	Asuransi Lain	35	41	64	↑35%
5	JR	1	5	3	↓ 40%
Total Pasien		1571	1743	1751	↑0,45%

3.1.1.5 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (November 2024- Januari 2025)



3.1.3.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JANUARI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANS I	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025	Kunjungan pasien dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir mengalami penurunan 60% dari bulan	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk	Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan bulan januari 2025

		mengalami penurunan 25,8% dari bulan sebelumnya di sebabkan oleh dengan peraturan bpjs 144 penyakit yang tidak di cover bpjs sehingga di IGD skrining lebih ketat untuk false emergencyn ya	untuk bulan januari 2025 mengalami kenaikan 37% dari bulan sebelumnya disebabkan denga BA peraturan BPJS	sebelumnya	bulan januari 2025 mengalami penurunan 40% dari bulan sebelumnya	mengalami peningkatan 0,4% dari bulan sebelumnya
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan dan mengurangi komplain serta bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

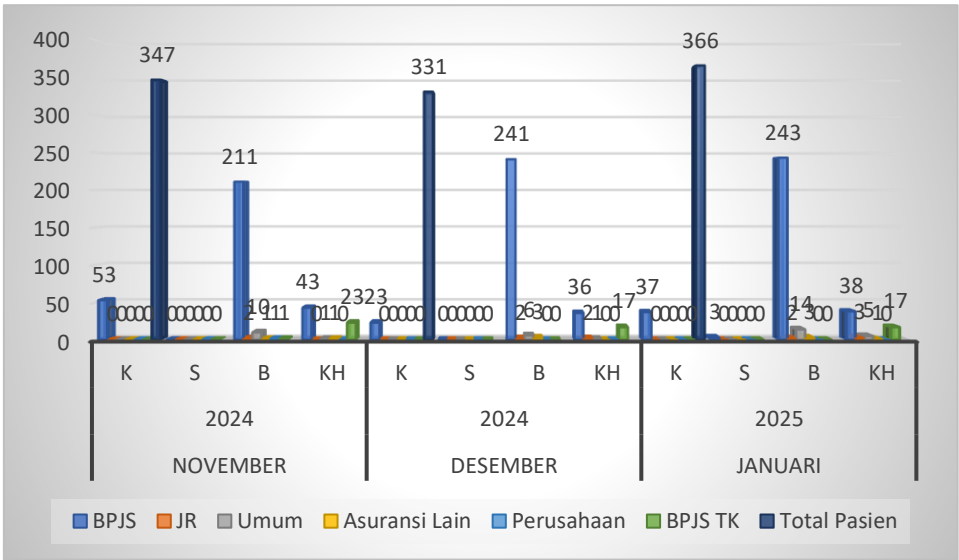
3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.1.6 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (November 2024-Januari 2025)

NO	HAL	NOVEMBER 2024				DESEMBER 2024				JANUARI 2025				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	53	0	211	43	23	0	241	36	37	3	243	38	Peningkatan 9,5%
2	JR	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	2	3	
3	Umum	0	0	10	1	0	0	6	1	0	0	14	5	
4	Asuransi Lain	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	3	1	
5	Perusahaan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BPJS TK	0	0	1	23	0	0	0	17	0	0	0	17	
	Total Pasien	347				331				366				

3.1.1.7 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin

3.1.1.8 (November 2024-Januari 2025)



3.1.4.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN NOVEMBER	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir pasien operasi yang menggunakan BPJS meningkat untuk bulan januari 2025 meningkat 6,5% dari bulan sebelumnya	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan operasi menggunakan bpjs TK menurun untuk bulan januari 2025 tetap angka operasi yang ada di iko di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 63,1 % dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan januari 2025 belum ada pasien operasi dengan jaminan perusahaan	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan januari 2025 mengalami peningkatan 22,2 % di bandingkan bulan sebelumnya	Total pasien untuk bulan januari 2025 meningkat 9,5%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2. Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vinyl 3. Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4. Berkoordinasi dengan humas marketing,terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5. mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6. Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi					

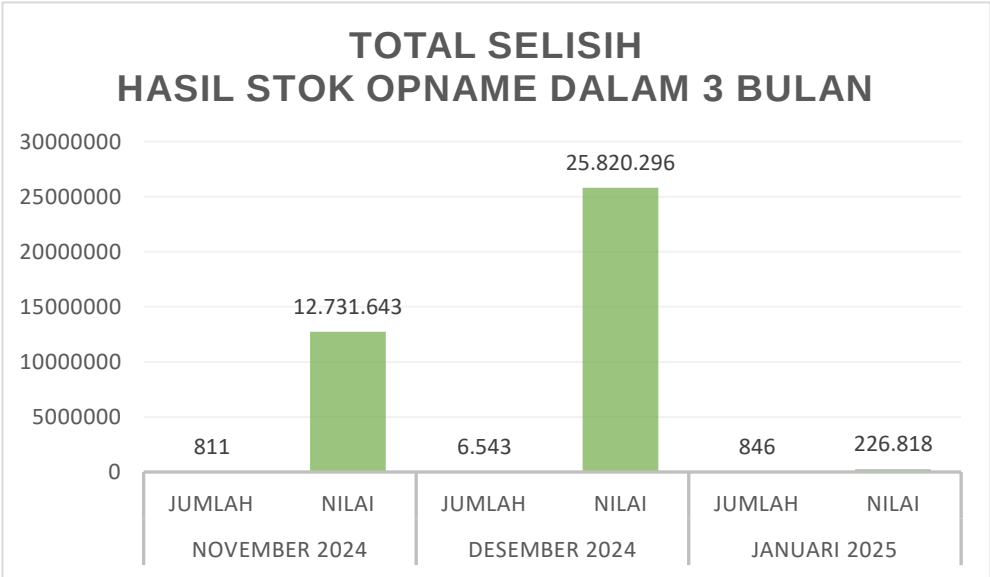
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan November 2024 – Januari 2025

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN					
		NOVEMBER 2024		DESEMBER 2024		JANUARI 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	FISIK	717.819	1.984.154.958	717.819	1.984.154.958	987.821	1.975.733.953
	SISTEM	717.782	1.984.197.437	717.782	1.984.197.437	987.822	1.975.808.953
	SELISIH	37	-42.479	37	-42.479	1	-75.000
DEPO FARMASI	FISIK	142.908	492.912.632	142.908	492.912.632	154.951	485.480.619
	SISTEM	142.238	486.169.397	142.238	486.169.397	154.207	485.122.849
	SELISIH	670	+6.743.243	670	+6.743.243	745	+357.772
IKO	FISIK	2.455	99.561.444	2.455	99.561.444	2.031	81.909.892
	SISTEM	2.351	93.530.564	2.351	93.530.564	1.929	81.965.847
	SELISIH	104	+6.030.879	104	+6.030.879	102	-55.954
GUDANG RETURE	FISIK	0	0	0	0	0	0
	SISTEM	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0
TOTAL SELISIH		811	+12.731.643	6.543	+25.820.296	846	+226.818

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan November 2024 – Januari 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

Hasil stok opname pada Bulan Januari 2025 sudah mendekati target (0), analisisnya sebagai berikut :		
NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
GUDANG FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar - Rp 75.000, hal ini disebabkan karena :		
1.	B3 Kode F02963 One scrub 4 % galon 5 ltr di master terdapat di Rak B3 tetapi tidak ada di kertas kerja.	Petugas lebih teliti dalam memverifikasi ulang kertas kerja sebelum diserahkan kepada Auditor.
2.	ALKES Kode F02847 Tatakan kapsul no.1 terdapat selisih 1pcs dikarenakan tidak melakukan pengeluaran barang di SIMRS, di master barang tertera Lokasi rak hanya di Gudang Farmasi.	Pengadaan dengan Programmer koordinasi untuk penambahan Lokasi rak Depo Farmasi agar dapat melakukan permintaan barang ke Gudang.
3.	OBAT ORAL GENERIK	Penulisan nama dan data barang pada

	Mecobalamin Caps 500 mcg – OGB Nulab tertukar pengisian di lembar kerja dengan Mecobalamin Caps 500 mcg - OGB Novell	Kartu Stock lebih detail.
DEPO FARMASI Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar + Rp 357.772, hal ini disebabkan karena :		
1.	KULKAS Kesalahan penginputan pada penerimaan barang Kode F00588 Oxytocin inj 10 iu/1 ml pada system merk OGB Novell tetapi barang fisik merk Ethica. Hasil telusur ditemukan bahwa Oxytocin inj 10 iu/1 ml yang tersedia merk OGB Novell (PT. ethercon pharma).	Penyesuaian stock pada saat Stok Opname.
2.	SUPPOSITORIA Kode F00406 Kaltrofen supp 100 mg terdapat salah perhitungan, yang seharusnya 1 box isi 10 tetapi dihitung 5 dan kartu stock tidak berjalan.	Meningkatkan ketelitian pada SDM sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan stock.
3.	OBAT ORAL GENERIK Kode F00661 Ranitidine tab 150 mg dan kode F00261 Domperidone tab 10 mg terdapat selisih koma dikarenakan salah penginputan pada saat meresepi obat dan tidak dikoreksi kembali oleh Apoteker.	Programmer menerapkan fitur kuantitas dengan nilai di belakang koma hanya berlaku untuk barang farmasi yang sharing dose untuk menghindari kesalahan inputan barang farmasi non sharing dose.
4.	CAIRAN Petugas shift malam salah hitung Cairan NS 0.9% 500 ml – otsuka sehingga selisih – 49 flash	Meningkatkan ketelitian petugas saat verifikasi hitung ulang.
5.	ALKES Petugas salah release Benang T-Vio 1 V15 – Triton ke IKO sehingga selisih + 20 pcs karena yang direlease Benang T-Vio 1 V16 – Triton.	Meningkatkan ketelitian petugas saat penyiapan dan release barang FS IKO.
FLOORSTOK IKO Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar - Rp 55.954, hal ini disebabkan karena :		
1.	ALKES 1. Kesalahan input kode F03298 Ett cuff no 7.0 merk Prodevice tetapi fisik merk Work sehingga menyebabkan selisih. 2. Kesalahan input kode F01362 Ett non king no 6.5 merk Work tetapi fisik merk Prodevice sehingga menyebabkan selisih.	Pengadaan PT melakukan penyesuaian master barang dan produsen pada sistem.
2.	INJEKSI Kode F00632 Primperan Inj. terdapat fisik barang tetapi tidak ditambahkan rak IKO pada master barang sehingga tidak muncul pada kertas kerja dan barang tidak ter SO.	Pengadaan PT koordinasi dengan Keuangan PT untuk penambahan rak agar barang dapat muncul di kertas kerja IKO.
GUDANG RETUR Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah sesuai dengan target (0).		
1.	Tidak terdapat rak Gudang Retur	Sentralisasi master barang PT. DPM dan mengajukan gudang retur kembali dimunculkan.

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan Februari 2025- Juli 2025)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tanggal Expired	No Batch	Jumlah Fisik Baik (BULAN)			Total Harga	Laporan Penjualan 1 Tahun Terakhir
							Nov 2024	Des 2024	Jan 2025		
1.	F00951	Benang T-Plain 4-0 p119 - Triton	Pcs	60.500	28/02/2025	200202AG	25	25	2	121.000	27
2.	F00170	Cendo Conver MDS - Cendo	Pcs	3.225	28/02/2025	2CV60222	60	60	60	193.500	0

3.	F00607	Phenobarbital tab 30 mg - Kimia Farma	Tab	200	28/02/2025	B30325N	200	200	200	40.000	0
4.	F01348	Ett Cuff no 4.5 - Work	Pcs	36.500	30/03/2025	200321	12	12	12	483.000	1
5.	F00320	Fludis Inf 100 ml - Bernofarm	Flash	165.000	30/03/2025	EID19350	17	17	17	2.805.000	3
6.	F02025	Suction Cath no. 16	Pcs	7.000	30/03/2025	2022806	5	5	2	14.000	10
7.	F03261	Koni e caps 400 - Konime x	Caps	4.000	30/04/2025	23ADI	202	202	202	808.000	91
8.	F00687	S-omevell Inj 40 mg - Novell	Vial	143.000	30/04/2025	250138	2	2	2	286.000	7
9.	F00812	Vaksin Vaxigrip Tetra - Sanofi	Vial	169.575	31/04/2025	Y3D471V	2	5	1	169.575	50
10.	F00963	Benang T-Vio 0 v11 - Triton	Pcs	93.500	30/05/2025	220507OM	69	69	64	5.984.000	45
11.	F01393	Foley Cath no 8 - Rusch	Pcs	61.765	30/05/2025	20F28	5	5	4	247.060	20
12.	F00385	Inviclot Inj 5000 iu 5 ml - Fahrenheit	Vial	66.000	30/05/2025	3HB578	10	10	10	660.000	0
13.	F00506	Morfina Inj 10 mg/ml - Kimia Farma	Amp	30.955	30/05/2025	E41230J	20	10	3	92.864	126
14.	F00546	Nutrisi Lactogen Lactose Free 400 g - Nestle	Kaleng	116.036	30/05/2025	L33120346AB	2	1	1	116.036	2
15.	F00582	Ostovel I Caps 0.25 mcg - Novell	Caps	6.500	30/05/2025	25K327	314	314	310	2.015.000	357
16.	F00914	Benang advalene blue 3-0/70 cm single 25 mm 3/8 circle cutting	Pcs	47.415	30/06/2025	V20198	27	27	27	2.560.410	19
17.	F01374	Feeding Tube Fr no 5/100 -	Pcs	19.250	30/06/2025	220729B	2	2	1	19.250	45

		Terumo									
18.	F00455	Lovenox 60 mg/06 ml - Sanofi	Amp	120.000	30/06/2025	4HS495FB	40	46	37	4.440.000	243
19.	F00550	Nuvision tab - Guardian	Tab	5.800	30/06/2025	2306083	600	450	450	2.610.000	1.619
20.	F00599	Pehacain inj 2 ml - Phapros	Amp	3.106	30/06/2025	66052076	13	10	9	27.952	638
21.	F00972	Benang T-Vio 5-0 v38 - Triton	Pcs	85.000	30/07/2025	220712BZ	37	37	32	2.720.000	22
22.	F00276	Epexol Syr 120 ml - Sanbe	Btl	18.200	30/07/2025	DG9786	24	24	24	436.800	9
23.	F00542	Ntg Inj 1 mg/ml - Ferron	Vial	65.000	30/07/2025	BN4832412A	7	7	17	1.105.000	30
24.	F00580	Oselta mivir caps 75 mg (hibah dinkes) - indofarma	Caps	10.010	30/07/2025	210V2062	1.100	1.100	1.100	11.011.000	0
25.	F00638	Prohepar Kaps - Yarindo	Caps	5.500	30/07/2025	CO210664	1.066	1.037	994	5.467.000	767
26.	F00701	Sequest Susp 40 g - Novell	Sach	19.250	30/07/2025	25G263	12	11	8	154.000	30
Total										44.586.447	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Februari 2025 - Juli 2025)

ANALISIS	TINDAK LANJUT
Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Februari 2025 - Juli 2025) karena obat dan alkes slow moving : 1. Benang T-Plain 4-0 p119-TRITON, digunakan untuk operasi. Penggunaan alkes death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 01/09/2022 dari distributor sejumlah 24 pcs. Proses retur. 2. Cendo Conver MDS-Cendo, digunakan untuk mengobati konjungtivitis alergi dan vernal keratokonjungtivitis. Penggunaan obat death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 20/12/2022 dari distributor sejumlah 60 pcs. 3. Phenobarbital tab 30 mg-Kimia Farma, digunakan untuk mengobati atau mencegah kejang. Peresepan terakhir tanggal 01/04/2023 penggunaan obat death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 26/07/2023 dari distributor sejumlah 100 tab. 4. Ett Cuff no 4.5-Work, dimasukkan ke dalam trakea untuk memastikan tidak tertutupnya trakea sebagai saluran pernapasan dan udara pernapasan dapat masuk kedalam paru-paru. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/07/2024 dari distributor sejumlah 8 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 5. Fludis Inf 100 ml-Bernofarm, pengobatan infeksi non-sistemik oleh jamur candida pada vagina, tenggorokan, dan mulut. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/08/2021 dari distributor sejumlah 15 flash. 6. Suction Cath no. 16, digunakan untuk mengeluarkan sekresi tubuh. Penggunaan slow moving, faktur pembelian terakhir tanggal 09/07/2022 dari distributor sejumlah 10 pcs. 7. Koni e caps 400-Konimex digunakan untuk suplemen memelihara kesehatan kulit. Penggunaan slow moving, faktur pembelian terakhir tanggal 31/10/2023 dari distributor sejumlah 90 kapsul. 8. S-Omevell Inj 40 mg-Novell, digunakan untuk GERD, Helicobacter Pylori Eradication, Gastric Ulcer, Zollinger-Ellison Syndrome. Faktur pembelian terakhir tanggal 31/08/2024 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 2 vial. 9. Vaksin Vaxigrip Tetra-Sanofi, digunakan untuk melindungi tubuh dari penyakit akibat virus influenza. Faktur pembelian terakhir tanggal 31/01/2025 dari distributor sejumlah 11 vial karena adanya program harga promo dari PT. Sanofi dan penyediaan stok di RS untuk paket vaksin dengan harga promo. 10. Benang T-Vio 0 v11-TRITON, digunakan untuk operasi. Penggunaan alkes death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 31/07/2023 dari distributor sejumlah 12 pcs. Proses retur. 11. Foley Cath no 8-RUSCH, dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 09/12/2021 dari distributor sejumlah 30 pcs.	1. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed, obat paten diberikan kepada pasien umum, asuransi swasta dan jasaraharja. 3. Kolaborasi dengan Ketua Komite Medik dr Heru, Sp.An. 4. Koordinasi dengan Karu Pelayanan untuk menggunakan alkes yang near ed. 5. Koordinasi dengan Pengadaan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 6. Koordinasi dengan DPJP obat yang death moving di stop order dan dikeluarkan dari Formularium RS. 7. Kolaborasi dengan Ketua Case Mix untuk membantu menyarankan penggunaan obat near ED kepada pelayanan yang membutuhkan.

12. Inviscot Inj 5000 iu 5 ml-Fahrenheit, digunakan untuk antikoagulan. Penggunaan obat death moving faktur pembelian terakhir tanggal 23/09/2023 dari distributor sejumlah 10 vial.
13. Morfina Inj 10 mg/ml-Kimia Farma, digunakan untuk nyeri berat, termasuk obat slow moving namun stok harus ada, faktur pembelian terakhir tanggal 02/01/2025 dari distributor sejumlah 10 amp, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.
14. Nutrisi Lactogen Lactose Free 400 g-Nestle merupakan susu formula bayi yang tidak mengandung laktosa dan digunakan pada bayi usia 0-12 bulan yang mengalami intoleransi terhadap laktosa dan diare. Faktur pembelian terakhir tanggal 18/04/2024 dari distributor sejumlah 3 kaleng.
15. Ostovell Caps 0.25 mcg-Novell, digunakan untuk antikoagulan. Penggunaan obat death moving faktur pembelian terakhir tanggal 30/09/2023 dari distributor sejumlah 240 caps.
16. Benang advalene blue 3-0/70 cm single 25 mm 3/8 circle cutting, digunakan untuk operasi. Penggunaan alkes death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 27/03/2023 dari distributor sejumlah 12 pcs.
17. Feeding Tube Fr no 5/100-Terumo, tubing untuk memasukkan cairan nutrisi (selang NGT) dari hidung untuk pasien yang mengalami kesulitan makan lewat oral. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/07/2023 dari distributor sejumlah 45 pcs.
18. Lovenox 60 mg/06 ml-Sanofi, digunakan sebagai antikoagulan. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/12/2024 dari distributor sejumlah 30 amp, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.
19. Nuvision tab-Guardian, digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk memelihara kesehatan mata. Faktur pembelian terakhir tanggal 23/10/2023 dari distributor sejumlah 1980 tab.
20. Pehacain Inj 2 ml-Phapros, digunakan untuk anestesi lokal dan regional, blok saraf, serta anestesi epidural dan kaudal. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/06/2024 dari distributor sejumlah 500 amp.
21. Benang T-Vio 5-0 v38-TRITON, digunakan untuk operasi. Penggunaan alkes death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 29/11/2022 dari distributor sejumlah 24 pcs. **Proses retur.**
22. Epexol syr 120 ml-Sanbe, sebagi sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya untuk eksaserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik serta asma bronkial. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/09/2023 dari distributor sejumlah 15 botol.
23. Ntg Inj 1 mg/ml-Ferron, indikasi untuk mengontrol hipertensi dengan cepat selama pembedahan jantung, Menurunkan tekanan darah dan menjaga hipotensi yang terkontrol selama prosedur pembedahan, Mengontrol iskemia miokard selama dan setelah pembedahan, Gagal jantung kongestif yang tidak responsif karena infark miokard akut, Angina tidak stabil yang sulit disembuhkan dengan beta blocker dan nitrat sublingual. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/06/2024 dari distributor sejumlah 10 amp.

24. Oseltamivir Caps 75 mg (hibah dinkes)-Indofarma, untuk mengatasi infeksi virus influenza tipe A atau B. Penggunaan obat death moving. Penerimaan obat dari dinas kesehatan tanggal 06/08/2021 sejumlah 700 tablet untuk pengobatan covid-19. 25. Prohepar kaps-Yarindo, digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh, memelihara kesehatan fungsi hati. Faktur pembelian terakhir tanggal 28/12/2023 dari distributor sejumlah 1500 tablet. Peresepan terakhir pada tanggal 23/07/2024, penggunaan obat slow moving. 26. Sequest Susp 40 g-Novell, untuk kadar kolesterol pada pasien hiperkolesterolemia primer yang tidak menunjukkan respon terhadap makanan. Faktur pembelian terakhir tanggal 30/09/2023 dari distributor sejumlah 40 sachet. Penggunaan obat slow moving.	
--	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

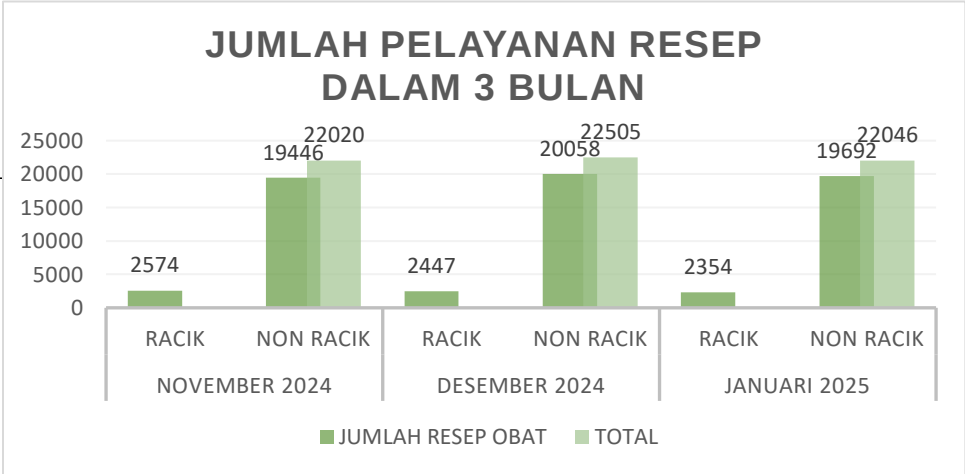
No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah TTK/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

5	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
6	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
9	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan November 2024 - Januari 2025

UNIT	JUMLAH RESEP					
	NOVEMBER 2024		DESEMBER 2024		JANUARI 2025	
	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
IRNA	263	7918	253	8481	216	8639
IRJA	2204	8879	2073	8797	2005	7929
IKO	0	825	0	810	0	899
IGD	107	1824	121	1970	133	2225
TOTAL	2574	19446	2447	20058	2354	19692
JUMLAH RESEP OBAT	22.020		22.505		22.046	

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan November 2024 - Januari 2025



Analisis :

Secara keseluruhan total resep pada bulan Januari 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan kunjungan pasien rawat jalan mengalami penurunan karena target PRB rawat jalan dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil dan retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien, rawat inap mengalami penurunan karena batasan diagnosa yang tidak bisa di layani di FKRTL, namun IKO dan IGD mengalami peningkatan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- 2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- 3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriksi yang ditentukan.
- 4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
- 5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.
- 6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
- 7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024 - Januari 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			November 2024	Desember 2024	Januari 2025	
1.	Pengkajian Resep	100%	99.46%	99.33%	99.42%	Jumlah pengkajian resep, yaitu : November 2024 = 22.020 Desember 2024 = 22.505 Januari 2025 = 22.046 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep, yaitu : November 2024 = 119 Desember 2024 = 151 Januari 2025 = 128
2.	Dispensing sediaan steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di Ruang Pencampuran Obat Steril (LAF).
3.	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4.	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Tidak ada kejadian pelaporan efek samping obat.
5.	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep obat yang ditandatangani oleh penerima obat.
6.	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di Lembar Edukasi (pasien rawat inap) dan tanda-tangan penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
7.	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8.	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
9.	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh

						Apoteker di RM.
10.	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape.
11.	Obat tidak bertuan	0	0	0	0	Tidak ada obat tidak bertuan.
12.	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	47	126	50	Obat tertinggal dikirimkan menggunakan PRIMANTARA, untuk pasien yang tidak merespon obatnya dilakukan penerimaan hibah lainnya ke gudang retur.
13.	Penempelan label obat rawat inap	100%	100%	100%	100%	Tidak ada laporan penempelan label obat rawat inap yang tidak ada dan tidak ada laporan IKP kejadian kesalahan penulisan etiket obat.

3.2.1.10 Tabel Analisa dan Tindaklanjut Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan November 2024 - Januari 2025

Analisa	Tindak Lanjut
Pengkajian Resep Penulisan resep yang lengkap mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2024, dengan total resep yang tidak lengkap yaitu : Bulan Desember 2024 sebanyak 151 dan Bulan Januari 2025 sebanyak 128. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : - Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS. - Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. - Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh Apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh Apoteker.	- Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS. - Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). - Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.
Kejadian Efek Samping Obat - Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Januari 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak

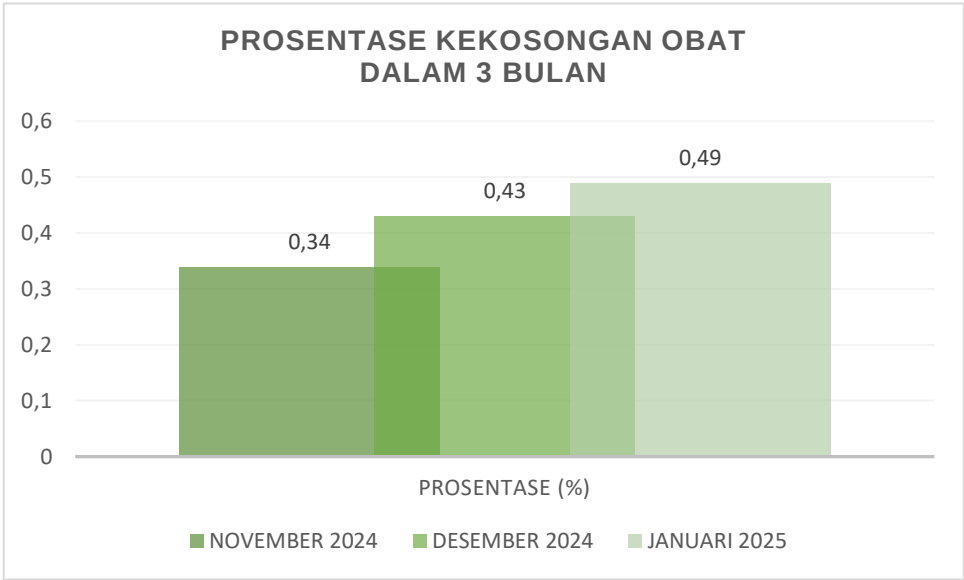
	dikehendaki (ESO). 4. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. 5. Menganalisa laporan ESO. 6. Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). 7. Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga 1. Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/keluarga di form edukasi. 2. Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO) PPA dapat megakses Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape di Nurse Station atau di Poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di Unit Pelayanan
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Desember 2024, dengan total resep yang di retur yaitu : Bulan Desember 2024 sebanyak 126 dan Bulan Januari 2025 sebanyak 50. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam dan keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama.	Terdapat program pengantaran obat gratis melalui Primantara sehingga mengurangi jumlah obat tertinggal.

3.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada
November 2024 - Januari 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
NOVEMBER 2024					
1.	1/11/2024 – 30/11/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
2.	1/11/2024 – 30/11/2024	Spironolakton tab 25 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Subtitusi dengan Spirola 25 mg
3.	1/11/2024 – 30/11/2024	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4.	1/11/2024 – 30/11/2024	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
Total Prosentase November 2024 = 0.34%					
DESEMBER 2024					
1	1/12/2024 – 31/12/2024	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
2	1/12/2024 – 31/12/2024	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg

3	1/12/2024 – 31/12/2024	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/12/2024- 23/12/2024	Spironolakton tab 25 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
5	6/12/2024- 29/12/2024	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
Total Prosentase Desember 2024 = 0.43%					
JANUARI 2025					
1	1/1/2025- 31/1/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
2	1/1/2025- 31/1/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3	1/1/2025- 31/1/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/1/2025- 31/1/2025	Spironolakton tab 25 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
5	1/1/2025- 31/1/2025	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
6	4/1/2025- 15/1/2025	Gliquidone tab 30 mg	Antidiabetes	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi dengan golongan Antidiabetes Oral lain
Total Prosentase Januari 2025 = 0.49%					

3.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada
 Bulan November 2024 - Januari 2025



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Haloperidol tab 5 mg – Yarindo dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi

apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.

- 2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- 4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- 5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

3.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Januari 2025

NO	KEGIATAN	NAMA OBAT/ BMHP/ ALAT KESEHATAN	JUMLAH	ALASAN	KETERANGAN
1.	Pemusnahan	Pil KB Lynestrenol	2516 tab	Obat hibah dari BKKBN ED 12/2024, No. batch : 0146038	Pemusnahan obat dilakukan pada tanggal 02 Desember 2024 di Depo Farmasi. Sudah dibuatkan berita acara pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai kedaluwarsa/ rusak.
2.	BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	Urine Bag Model T – Ocean Medika	1 pcs	Bocor di bagian bawah	Form keluhan alat kesehatan substandard dari ruangan Maternitas dilaporkan tanggal 04/01/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. DPM namun belum ada tindak lanjut penggantian produk.
		Urine Bag Model T – Ocean Medika	1 pcs	Sering menetes meski sudah ditutup	Form keluhan alat kesehatan substandard dari ruangan 2C dilaporkan tanggal 06/01/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. DPM namun belum ada tindak lanjut penggantian produk.
		Urine Bag Model T – Ocean Medika	1 pcs	Urine tetap menetes pada kunci meskipun sudah ditutup	Form keluhan alat kesehatan substandard dari ruangan 7A dilaporkan tanggal 17/01/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. DPM namun belum ada tindak lanjut penggantian produk.
		IV Canulla no. 20 - Hospitech	1 pcs	Indikator insersi lambat, sehingga menyulitkan perawat, dan jarumnya gampang jatuh jika ditarik sedikit langsung jatuh sehingga dikhawatirkan tertusuk ke kaki perawat	Form keluhan alat kesehatan substandard dari IGD dilaporkan tanggal 20/01/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. DPM namun belum ada tindak lanjut penggantian produk.
		IV Canulla no. 24 - Hospitech	1 pcs	Jarumnya trouble sehingga gagal 6x	
3.	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Januari 2025

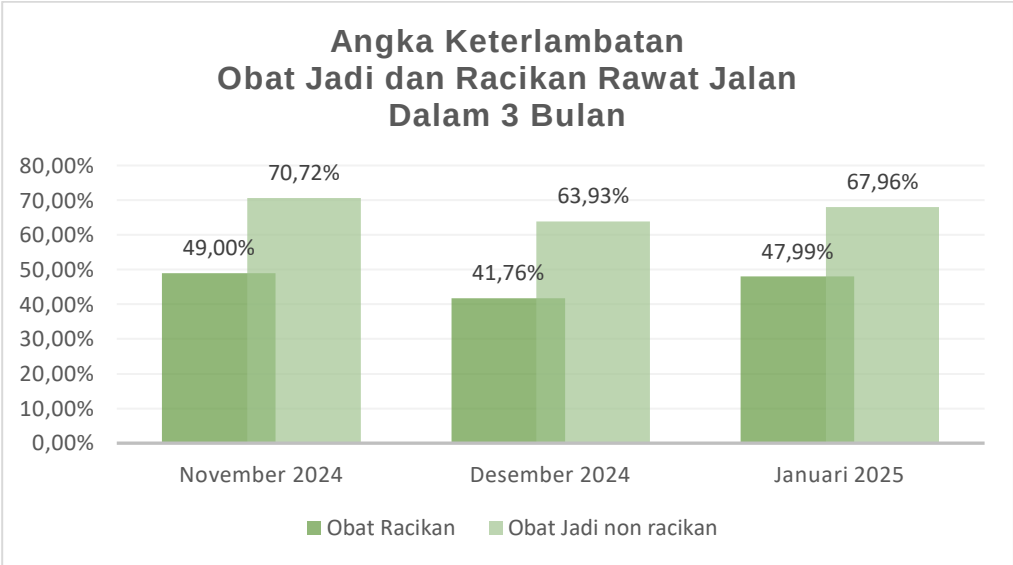
NO	MONITORING DAN EVALUASI	HASIL	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian, repacking dan donasi/ hibah. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP di Gudang Farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP Farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP Farmasi.	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di Gudang Farmasi.
2.	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor.	Tersedia PKS dengan distributor. Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian, yakni : a. Sediaan farmasi – Nomor Ijin Edar dari BPOM b. Alkes – Nomor Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP – Nomor Ijin Edar dari Binfar d. B3 – MSDS; Kunjungan ke distributor, Surat Pesanan obat, ALKES, dan BMHP di Tandatangani oleh APJ.	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.
3.	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin.	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di Depo Farmasi dan Gudang Farmasi oleh Apoteker setiap hari.
4.	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi.	Bedah box triwulan 1 pada Bulan Januari 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh, yaitu : - Lantai 1 (Dexamethasone Injeksi, ED 08/2025 → 06/2026), (Valisanbe Injeksi, ED 08/2025 → 07/2026). - Lantai 2 (Tidak ada obat Near ED <6bulan). - Trolley Emergency IGD (Dobutamine Injeksi, ED 07/2025 → 09/2027), (Gelafusal Infus, ED 05/2025 → 03/2027), (Manitol Infus, ED 05/2025 → 01/2026), (Phenytoin Injeksi, ED 07/2025 → 03/2027). - Box emergency infant Ponok IGD (Gelafusal Infus, ED 05/2025 → 03/2027). - Box HPP - Eklamsi (Tidak ada obat Near ED <6bulan). - Kit emergency IGD (Infusion Set Dewasa, ED 06/2025 → 10/2029), (Dexamethason Injeksi, ED 05/2025 → 05/2026). - Box emergency ambulance 1 (Amiodarone Injeksi, ED 05/2025 → 06/2026), (Dexamethasone Injeksi, ED 06/2025 → 06/2026), (Miniaspi, ED 05/2025 → 03/2027), (Phinev Injeksi, ED 07/2025 → 07/2027), (Cairan NS 0.9 500 ml, ED 06/2025 → 10/2026). - Box emergency ambulance 2 (Cairan NS 0.9% 500 ml, ED 06/2025 → 10/2026), (Infusion Set Dewasa, ED 05/2025 → 10/2029), (IV Canul 20, ED 06/2025 → 06/2029), (IV Canul 22, ED 06/2025 →	Dilakukan supervisi oleh Apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.

		06/2028).	
5.	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 72% di Depo Farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di Gudang Farmasi.	a) Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok. b) Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan. Terjadi kekosongan reagen yaitu CKMB 2x20 ml.	Surat edaran pemberitahuan reagen yang tersedia yaitu Vidas HS Troponin I.
7	Penyimpanan produk steril di unit	Masih ditemukan poli melakukan penyimpanan NS 0.9% 500 ml sisa untuk rawat luka dan digunakan kembali besok hari (1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam.
8	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	Bulan Januari 2025 farmasi dan perawat sudah rutin melakukan double check obat high alert dengan mengisi daftar tilik serah terima obat farmasi - rawat inap dan daftar pemberian obat (DPO) sehingga tidak ditemukan kejadian IKP.	Supervisi berkala.

3.2.1.15 Tabel Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan November 2024 – Januari 2025

INDIKATOR	BULAN		
	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
Penyiapan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 menit	49%	41.76%	47.99%
Penyiapan Obat Racikan > 60 menit	70.72%	63.93%	67.96%

3.2.1.16 Grafik Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Bulan November 2024 – Januari 2025



Analisis :
Waktu tunggu obat rawat jalan pada Bulan Januari 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Bulan Desember 2024 dikarenakan libur tanggal merah dan poli tutup sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari aktif, kunjungan pasien yang tidak dibatasi sehingga terjadi penumpukan resep di jam-jam tertentu.

- Rencana Tindak Lanjut:**
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.

- 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
- 3. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
- 4. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh TTK, resep iter dan PRB oleh Apoteker.

3.2.2 Laboratorium

3.2.2.11Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar November 2024 – Januari 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
Dilakukan di Rumah Sakit				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4821	4673	4910
	Hematologi	2572	2058	2825
	Serologi dan Molekuler	650	540	666
	Urine	397	403	415
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	8	18	9
Total		8448	7692	8825
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	4	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
Total		0	4	0
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	43	51	50
	Narkoba	14	19	8
	Covid-19	6	8	7
Total		63	78	65
Dilakukan di Luar Rumah Sakit (Dirujuk)				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	2	1	0
	Hematologi	1	0	4
	Serologi dan Molekuler	10	4	15
	Urine	0	0	0
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	0	0	0
Total		13	5	19
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	5	4	8
	Pemeriksaan Histopatologi	70	79	88
Total		75	83	96
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	6	13	9
	PCR	0	0	0
	Tumor Marker	2	0	1
	Cholinesterase	0	0	0
Total		8	13	10

3.2.2.12 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit Bulan November 2024 – Januari 2025



Analisis :

- 1. Permintaan pemeriksaan laboratorium pada Bulan Januari 2025 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8825 pemeriksaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kenaikan jumlah kunjungan laboratorium, salah satunya adalah pasien MCU, baik dari perusahaan maupun datang sendiri.
- 2. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :
 - a) Patologi Anatomi = 254 sampel
 - b) Patologi Klinik = 37 sampel
 - c) Lain-lain = 31 sampel
- 3. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada dalam 3 bulan terakhir mencapai 254 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan penunjang (PA) untuk kebutuhan klaim.
- 4. Hasil pemeriksaan PA masih mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena adanya tindakan potong ulang dan banyaknya tanggal merah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 2. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- 3. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
- 4. Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
- 5. Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
- 6. Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.

3.2.2.13 Pelaporan Nilai Kritis

NO	BULAN	JUMLAH NILAI KRITIS	PROSENTASE YANG DILAPORKAN	PROSENTASE YANG TIDAK DILAPORKAN
1.	November 2024	233	98%	2%
2.	Desember 2024	247	99%	1%
3.	Januari 2025	258	96,9%	3,1%

3.2.2.14 Grafik Pelaporan Nilai Kritis



Analisis :

Pelaporan nilai kritis pada Bulan Januari 2025 mencapai 96.9%, prosentase yang tidak dilaporkan meningkat sebesar 3,1%. Hal ini disebabkan oleh kelalaian petugas saat malam hari, pelaporan nilai kritis memang dilakukan <5menit tetapi petugas tidak melakukan dokumentasi pada buku pelaporan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Supervisi berkala dilakukan oleh Karu dan Kabid Penunjang Medis
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan dan Kabid Pelayanan Medis terkait pelaporan complain DPJP terhadap keterlambatan pelaporan nilai kritis.
- 3. Kolaborasi dengan SDM terkait kedisiplinan petugas dalam melakukan pekerjaan.

3.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Januari 2025

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
1.	Durasid	205115	02/01/2025	IGD	DL Clothing
2.	Mori	224882	01/01/2025	IGD	DL Clothing
3.	Ervan W	161868	01/01/2025	IRNA 4A	SE Rusak
4.	Christian	161417	08/01/2025	IGD	DL Clothing
5.	By Ny Nuri	225528	13/01/2025	Neonatologi	Sampel Kurang
6.	Eritri	208429	13/01/2025	IRNA 6A	DL Clothing
7.	Olga S	149217	17/01/2025	IGD	DL Clothing
8.	Setiani	213248	22/01/2025	ICU	Lisis
9.	Atim	064323	22/01/2023	IRNA 6A	DL Clothing

Analisis :

Masih ditemukan sampel rusak ketika diterima oleh petugas laboratorium pada Bulan Januari 2025 sebanyak 9 sampel. Hal ini bisa disebabkan ketidakpahaman petugas saat melakukan sampling darah, kebutuhan dan prosedur penyimpanan sampai dengan pengiriman sampel ke laboratorium.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Konfirmasi petugas untuk melakukan sampling ulang.
- 2. Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
- 3. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
- 4. Supervisi ED reagen.

3.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan November 2024 – Januari 2025

BULAN	PERMINTAAN LABU DARAH				TOTAL	RETURN LABU DARAH				TOTAL
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
November 2024	7	6	31	30	74					
Desember 2024	13	9	21	21	64					
Januari 2025	24	1	31	25	81	-	3	-	9	12

3.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Januari 2025

NO	NAMA PASIEN	JUMLAH PASIEN DAN PERMINTAAN LABU DARAH INCOMPATIBLE				TOTAL PERMINTAAN LABU DARAH
		A	AB	O	B	
1.	Ayu Rahmalia	√				1 Labu
2.	Dursaid				√	2 Labu
3.	Pi'i			√		2 Labu

Analisis :

- 1. Terjadi peningkatan permintaan labu darah pada Bulan Januari 2025.
- 2. Masih ditemukan return labu darah ke PMI sebanyak 12 labu.
- 3. Masih ditemukan hasil incompatible pada crossmatch pada Bulan Januari 2025 sebanyak 3 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengurangi stok maksimum labu darah dengan permintaan jarang.
- 2. Mengirimkan analis untuk magang di PMI selama 2 minggu secara bergantian, biaya free.
- 3. Melakukan penertiban penulisan kartu stok labu darah secara real time, pelaksanaan SO dilakukan setiap akhir bulan.
- 4. Sampel darah dikirim ke UTD terdekat, karena UTD yang bisa mengeluarkan surat keterangan hasil crossmatch incompatible ke DPJP.

3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Januari 2025

Indikator	Rumus	Data	Standar Depkes	Bulan	Unit												Total
					2C	3A	3C	4Ab	5C	6A	7A	8A	MTS	NICU	HCU	ICU	
BOR (Bed Occupancy Rate) “Prosesntase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu”	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60-80 %	November 2024	53	53	74	63	62	68	69	61	43	6	21	21	70%
				Desember 2024	70	54	82	60	56	69	70	64	43	2	25	25	71%
				Januari 2025	62	57	71	50	53	68	65	53	70	32	27	42	67%
ALOS (Average Length of Stay) “Rata-rata lama rawat seorang pasien”	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	Jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6-9 hari	November 2024	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	0	2	3hari
				Desember 2024	4	2	3	3	3	4	3	3	3	2	0	2	3hari
				Januari 2025	4	3	3	3	4	4	4	1	3	3	2	2	3hari
TOI (Turn Over Interval) “Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati”	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1-3 hari	November 2024	2	2	1	1	1	1	1	1	2	21	0	5	1hari
				Desember 2024	1	2	1	1	2	1	1	1	2	92	0	4	1hari
				Januari 2025	2	2	1	2	2	1	1	2	1	4	3	2	1hari
BTO (Bed Turn Over) “Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien, Jumlah TT	4-5 kali (dalam hitungan bulan)	November 2024	7	8	11	10	8	9	9	8	8	1	0	5	10kali
				Desember 2024	8	9	13	9	8	10	10	9	8	0	0	5	11kali
				Januari 2025	8	8	10	8	7	9	9	8	12	6	8	8	10kali

periode”																	
NDR (Net Death Rate) “Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ Mati} > 48 \text{ jam}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jam, jumlah pasien keluar	<25 ‰	November 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	6‰
				Desember 2024	0	0	0	0	0	17	0	9	0	0	0	95	8‰
				Januari 2025	0	0	0	16	29	0	10	11	0	0	0	179	14‰
GDR (Gross Death Rate) “Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	November 2024	0	0	0	0	10	0	9	0	0	200	0	62	7‰
				Desember 2024	0	0	0	0	0	17	8	9	0	0	0	176	13‰
				Januari 2025	0	0	0	16	29	0	10	11	0	0	0	179	14‰

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Januari 2025



Analisis :

Berdasarkan hasil perhitungan statistik rumah sakit pada Bulan Januari Tahun 2025, kinerja RS Prima Husada Malang didapatkan hasil nilai indikator :

1. BOR sebesar 67% (standar : 60-85%) sesuai standar.
2. LOS sebesar 3 hari sesuai dengan standard RSPHM terkait SE dari PT.DPM khusus pasien BPJS (standar pasien umum : 6-12 hari)
3. TOI sebesar 0.50 hari (standar : 1-3 hari)
4. BTO sebesar 10 kali (standar : 4-5 kali)

BOR Bulan Januari Tahun 2025 di bandingkan dengan Bulan Desember Tahun 2024 mengalami penurunan, salah satu faktor penurunan BOR karena pasien rawat inap di Bulan Desember mengalami penurunan. Nilai BOR tersebut menjadi bukti bahwa penggunaan tempat tidur di Bulan Januari sudah standar. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan tempat tidur sudah efisien dari segi ekonomi menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit.

Masalah :

Indikator TOI, LOS dan BTO belum memenuhi standar, terkait TOI sebesar 0.50 hari menandakan bahwa waktu tempat tidur tidak tersisa sangat pendek, ini bisa menjadi salah satu faktor nosocomial, begitupun dengan beban kerja perawat yang cukup tinggi. Terkait LOS yang belum memenuhi standar (standard lama belum berubah tidak sesuai peraturan baru). Standard saat ini sesuai dengan ketentuan BPJS yang mengacu juga pada PPK-CP masing-masing kasus/penyakit. Hal ini menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang baik serta adanya kendali mutu dan kendali biaya sehingga lama perawatan pasien lebih cepat. Sedangkan BTO standar tersebut digunakan untuk satu tahun penuh, angka 10 mencerminkan bahwa 1 tempat tidur bisa digunakan 10 kali perawatan dalam sebulan.

Rencana Tindak Lanjut :

Meningkatkan kualitas pelayanan di rawat inap dan menjalankan sasaran keselamatan pasien agar mutu pelayanan tetap sesuai standar

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Bulan Januari 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	460
2.	I51.9	Decomp Cordis/Heart Disease, unspecified	395
3.	I25	Chronic ischemic heart disease	368
4.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	304
5.	I69.3	Sequelae of cerebral infarction	279
6.	R50.9	Febris / Fever, unspecified (Observasi Febris)	226
7.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	219
8.	R10.4	Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain	180
9.	E11.4	With neurological complications	176
10.	M17.9	Gonarthrosis, unspecified	169

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Januari 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever (TF)	301
2.	P24.9	Neonatus Cukup Bulan	103
3.	A90	Dengue Fever	42
4.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident	32
5.	J18.9	Pneumonia	29
6.	E14.9	Diabetes Mellitus Hyperglikemia	28
7.	E11.9	Diabetes Mellitus Type 2	13
8.	N40.0	Benign Prostate	13
9.	I20.0	Unstable Angina Pectoris	12
10.	J96.0	Acute Respiratory Failure	11

Analisis :

1. Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan adalah DM tanpa komplikasi sebesar 460 kasus, sedangkan diagnose terbanyak di Rawat Inap adalah Typhoid Fever sebesar 301 kasus.
2. Tarikan data diagnose rawat inap diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang, yaitu pada diagnose utama yang ditulis oleh DPJP. Sedangkan tarikan data diagnose rawat jalan diambil dari SIMRS.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Januari 2025

UNIT	No RM	DPJP				PERAWAT								GIZI		APOTEKER	
		RINGKASAN KELUAR MASUK	PENGKAJIAN AWAL	CPPT	RINGKASAN PULANG	PENGKAJIAN KEPERAWATAN	CPPT	ASKEP	OBS TTV	NYERI	RISIKO JATUH	RESUME KEPERAWATAN	FORM TRANSFER	PENGKAJIAN AWAL GIZI	CPPT	REKONSILIASI OBAT	CPPT
3C	224747	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEO	224738	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEO	224837	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEO	224818	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
ICU	113959	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224817	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
4A	128282	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	091420	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3A	224590	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	203901	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224815	L	TL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
3C	088782	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	115150	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3A	056851	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	68642	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	224827	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

8A	223723	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224849	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
MATERNITAS	214301	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224874	L	TL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
2C	201461	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
IGD	224869	L	TL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	TL	TL
8A	194251	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	L
5C	224997	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3A	070544	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	224803	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
8A	224762	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	69043	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	224775	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5C	81658	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
7A	224844	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	218680	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	118543	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
2C	099470	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

2C		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	215392	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	216894	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4A	121582	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224856	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEONATOLOGI	224871	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEONATOLOGI	224868	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEONATOLOGI	224859	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
3C	224861	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	123009	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	224884	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	204258	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4A	155419	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	105515	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
7A	176702	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

NEONATOLOGI	224854	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
6A	224847	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	117688	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	135342	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	224315	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	224872	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	207592	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	224261	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5C	224928	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	223659	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224944	L	TL	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL
3C	224925	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
8A	194596	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
2C		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4A	208005	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
8A	210115	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	224751	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	224761	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5C	120705	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
7A		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	224834	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

MATERNITAS	221163	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3A	64451	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	066794	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	222942	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	126377	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	222705	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	215011	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	198506	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	106126	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	211241	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4A	158351	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
HCU	224864	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5C	066231	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
7A	146565	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4A	207863	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224943	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEONATOLOGI	224942	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL

NEONATOLOGI	224892	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEONATOLOGI	224893	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEONATOLOGI	224898	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEONATOLOGI	224894	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
NEONATOLOGI	224891	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
3C	174726	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	205228	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	169463	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3A	222655	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	203446	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5C	224921	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
MATERNITAS	188625	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224938	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL

MATERNITAS	224281	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	224939	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL	TL	L	TL
4A	224886	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4A	224941	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
8A	223835	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
4A	224592	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5C	185089	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	224951	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5C	224504	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
ICU	200703	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
7A	221518	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
NEONATOLOGI	223763	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	TL
7A	224882	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
7A	220134	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
5C	087632	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	222744	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
6A	112013	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
ICU	120841	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
3C	224923	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
8A	205115	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
7A	224887	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

Analisis :

Kelengkapan Keseluruhan :

1. Kelengkapan DPJP

- a. Ringkasan Keluar Masuk
- c) Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- d) Jumlah Tidak Lengkap : 0 = 0%
- b. Pengkajian Awal Medis (**Tidak tertera jam pada lembar pengkajian awal medis**)
- e) Jumlah Lengkap : 1001 = 98%
- f) Jumlah Tidak Lengkap : 25 = 2%
- c. CPPT
- g) Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- h) Jumlah Tidak Lengkap : 0 = 0%
- d. Ringkasan Pulang
- i) Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- j) Jumlah Tidak Lengkap : 0 = 0%

2. Kelengkapan Perawat (**Perawat melakukan serah terima DRM dengan petugas RM dan dicek saat itu juga**)

a. Pengkajian Keperawatan

- Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- Jumlah Tidak Lengkap : 100 = 0%

b. CPPT

- Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- Jumlah Tidak Lengkap : 100 = 0%

c. Asuhan Keperawatan

- Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- Jumlah Tidak Lengkap : 100 = 0%

d. Observasi TTV

- Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- Jumlah Tidak Lengkap : 100 = 0%

e. Pengkajian Ulang Nyeri

- Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- Jumlah Tidak Lengkap : 100 = 0%

f. Pengkajian Risiko Jatuh

- Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- Jumlah Tidak Lengkap : 100 = 0%

g. Resume Keperawatan

- Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- Jumlah Tidak Lengkap : 100 = 0%

h. Form Transfer Antar Unit

- Jumlah Lengkap : 1026 = 100%
- Jumlah Tidak Lengkap : 100 = 0%

3. Kelengkapan Ahli Gizi

a. Pengkajian Awal Gizi

- Jumlah Lengkap : 944 = 92%
- Jumlah Tidak Lengkap : 82 = 8%

- b. CPPT
 - Jumlah Lengkap : 944 = 92%
 - Jumlah Tidak Lengkap : 82 = 8%

- 4. Kelengkapan Apoteker
 - a. Rekonsiliasi Obat
 - Jumlah Lengkap : 1010 = 98%
 - Jumlah Tidak Lengkap : 16 = 2%
 - b. CPPT
 - Jumlah Lengkap : 912 = 89%
 - Jumlah Tidak Lengkap : 114 = 11%

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
2. Melakukan supervise secara berkala.
3. Membuat raport ketidaklengkapan dan kolaborasi dengan Kabid Keperawatan.

3.1.1.6 Tabel Dokumen Rekam Medis Elektronik Oleh Perawat Rawat Jalan Bulan Januari 2025

NO	NAMA PERAWAT	Σ DRM	PENGKAJIAN KEPERAWATAN				KELENGKAPAN			
			L	TL	V	TV	%L	NILAI	%V	NILAI
1.	Sistha Ghea Aprilia, Amd. Kep	50	45	5	90%	10%	90%	45	10%	5
2.	Ns. Betdi Prasetyo, S.Kep	30	24	6	80%	20%	80%	24	20%	6
3.	Wibowo Krisdianto, Amd. Kep	43	37	6	86%	14%	86%	37	14%	6
4.	Hana Hamimah, Amd.Keb	72	68	4	94%	6%	94%	68	6%	4
5.	Rosi Slamet Saputri, S.Kep,Ns	54	47	7	87%	13%	87%	47	13%	7
6.	Bdn. Nurul Azizah Jihad Fisabilillah, S.Tr.Keb	85	80	5	94%	6%	94%	80	6%	5
7.	Leny Puji Rahayu, Amd. Keb	94	91	3	97%	3%	97%	91	3%	3
8.	Tuti Dwi jayati, Amd.Keb,SE	70	65	5	93%	7%	93%	65	7%	5
9.	Oktavia Amelia Sari AMd. Kep	52	46	6	88%	12%	88%	46	12%	6
10.	Ns. Tika Aryuni, S.Kep	33	29	4	88%	12%	88%	29	12%	4
11.	Ria Christiasari, Amd.Kep	34	24	10	71%	29%	71%	24	29%	10
12.	Khairun Nisa, A.Md.Kep	39	33	6	85%	15%	85%	33	15%	6
13.	Adelia May Adetry, Amd.Kep	36	32	4	89%	11%	89%	32	11%	4
14.	Raysa Rosadila, Amd. Kep	41	34	7	83%	17%	83%	34	17%	7
15.	Dyah Kusuma W, Amd.Kep	32	27	5	84%	16%	84%	27	16%	5
16.	Maulidya Sari, Amd.Kep	45	40	5	89%	11%	89%	40	11%	5
17.	Ns.Isa Ariyanti, S.Kep	40	34	6	85%	15%	85%	34	15%	6
18.	Ns. Winda Lestari, S.Kep	45	37	8	82%	18%	82%	37	18%	8
19.	Ns. Andraina Wulandari Oktavia, S. Kep	41	36	5	88%	12%	88%	36	12%	5
20.	Reyna Oktavia Kristianti, Amd.Kep	38	34	4	89%	11%	89%	34	11%	4
21.	Ns. Cyntia Sapta Anggraeni, S.Kep	26	22	4	85%	15%	85%	22	15%	4
22.	Ns. Anggun Tria Istiqomah, S.Kep	24	20	4	83%	17%	83%	20	17%	4
23.	Ajeng Ika Octavianna, SST	18	10	8	56%	44%	56%	10	44%	8
24.	Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns	9	9	0	100%	0%	100%	9	0%	0
25.	Yuni Novita, Amd. Kep	48	45	3	94%	6%	94%	45	6%	3
26.	Ns. Rara Ayu Dewanti, S.Kep	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0
27.	Devi Kartika Sari, Amd.Kep	32	26	6	81%	19%	81%	26	19%	6
28.	Fisioterapis	73	58	15	79%	21%	79%	58	21%	15
TOTAL		1204	1053	151	83%	14%	83%	1053	14%	151

Analisis :

- 1. Dari table diatas, dapat diketahui hanya terdapat 1 perawat dengan kelengkapan 100% dari 28 perawat.
- 2. Ada 1 perawat gigi dengan ketidaklengkapan dibawah 60%.

Masalah :

Hanya 3.5% dari total keseluruhan jumlah perawat yang kelengkapan DRM nya 100%.

Rencana Tindak Lanjut :

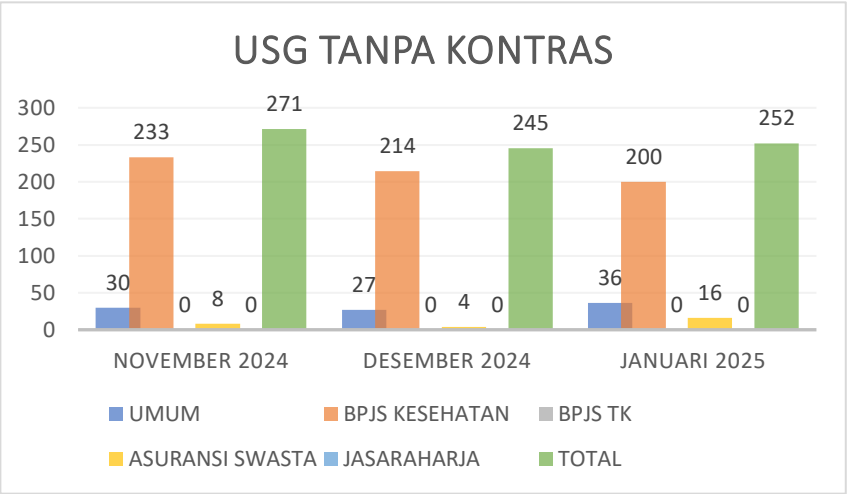
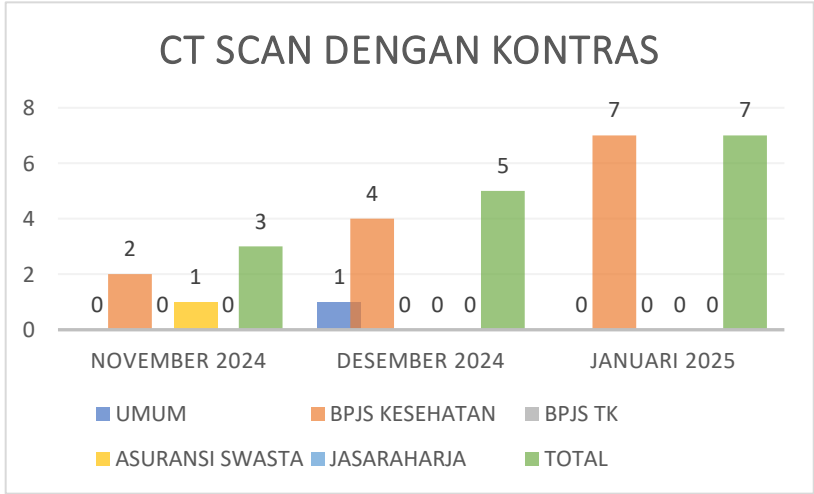
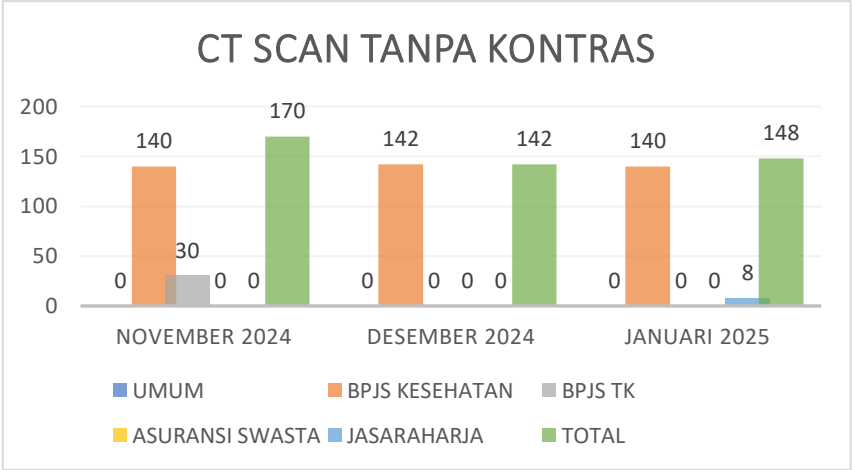
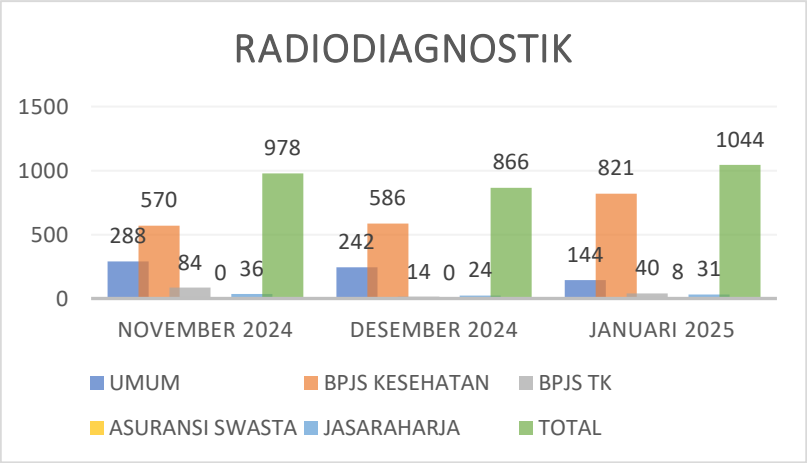
- 1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Ruang.
- 2. Melakukan teguran terhadap petugas yang mempunyai PR kelengkapan RM.
- 3. Melakukan telusur dan perbaikan.
- 4. Koordinasi dengan Programmer.

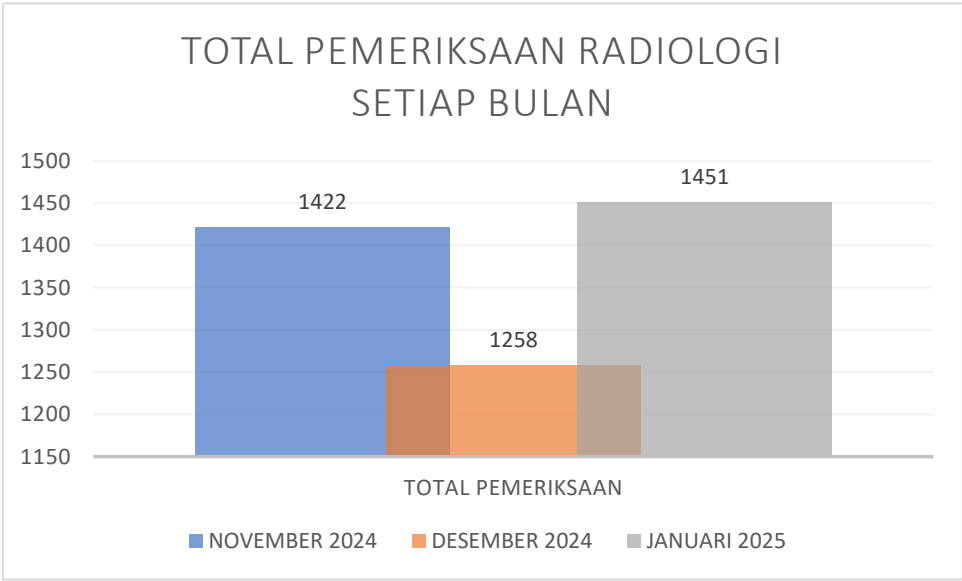
3.2.4 Radiologi

3.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi November 2024 – Januari 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	288	242	144
		BPJS KESEHATAN	570	586	821
		BPJS TK	84	14	40
		ASURANSI SWASTA	0	0	8
		JASARAHARJA	36	24	31
	TOTAL		978	866	1044
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	0	0	0
		BPJS KESEHATAN	140	142	140
		BPJS TK	30	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	8
	TOTAL		170	142	148
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	1	0
		BPJS KESEHATAN	2	4	7
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	1	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		3	5	7
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	30	27	36
		BPJS KESEHATAN	233	214	200
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	8	4	16
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		271	245	252
TOTAL KESELURUHAN			1422	1258	1451

3.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi November 2024 – Januari 2025





Analisis :

1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Januari 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.

Selama Tahun 2024 pemeriksaan terbanyak, yaitu :

- a. Radiodiagnostik : 1044
 - b. USG Tanpa Kontras : 252
 - c. CT Scan Tanpa Kontras : 155
2. Produktivitas pemeriksaan radiodiagnostik mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya tambahan pasien MCU haji dan MCU Perusahaan/mandiri.
 3. DPJP Radiologi tidak ada ijin praktik selama Bulan Januari 2025.
 4. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Januari 2025 adalah sebanyak 1451 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - 1) Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - 2) Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
3. Melakukan review tarif tindakan yang dibutuhkan DPJP atau bisa dilakukan di RS, namun belum ada di Billing. Contoh : CTA Cardiac.
4. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

3.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan November 2024 – Januari 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan November 2024					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Desember 2024					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Januari 2025					

1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0

Analisis :
 Dalam 3 bulan terakhir tidak ada permintaan pembacaan ulang oleh DPJP terkait hasil pemeriksaan radiologi yang tidak sesuai dengan klinis. Pembacaan 100% sesuai.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

3.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	3	25	3	1440
2.	Ro Vertebrae	-	-	4	1440
3.	Ro Abdomen	-	-	10	1440
4.	Ro Extremitas	-	-	2	1440
5.	Ro Skull	-	-	2	1440
6.	USG Abdomen	8	3	8	3
7.	CT Scan Non Kontras	5	1440	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	15	1440	-	-
9.	Radiologi CITO	-	-	-	-

- Analisa :**
1. Rata-rata pemeriksaan radiologi adalah 3 menit dengan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit untuk dr Agung, Sp.Rad (K), hal ini disebabkan karena hasil rontgen dapat dikonsultasikan via pesan whatsapp. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam).
 2. Rata-rata pembacaan radiologi oleh dr Yudho, Sp.Rad adalah 1440menit/24 jam, tidak sesuai dengan target standar RS. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian jobdesk konsulan, dr Yudho, Sp.Rad tidak berkenan dikonsuli via pesan whatsapp dan dibacakan saat praktik keesokan harinya.
 3. Pembacaan elektif dilakukan oleh dr Yudho, Sp.Rad saat praktik. (Semua foto Vertebrae, Ekstremitas, Abdomen, dan Skull).
 4. Tidak terdapat pemeriksaan CITO dan kasus kritis selama bulan Januari 2025.
 5. Semua pemeriksaan CT Sacan dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad (K).
 6. Terdapat kekosongan jam pelayanan radiologi pada siang hari.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
 2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari.
 3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
 4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

3.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada Bulan Januari 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :
 Pada Bulan Januari tidak ada complain DPJP dan Dokter Umum karena keterlambatan hasil pembacaan radiologi.
 Hal ini disebabkan, selain waktu tunggu cito tidak melebihi standar, bisa disebabkan ketidakpahaman petugas pelayanan dalam melaporkan complain sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
 Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

3.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

4.4.5 Gizi

4.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Tahun 2024

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025	
1.	Diabetes Melitus	379	401	373	93
2.	Rendah Garam	700	627	526	84
3.	Jantung	252	319	265	83
4.	Rendah serat	373	427	369	86
5.	TKTP	1074	995	1099	110
6.	Makanan biasa	10	26	9	35
7.	Makanan Lunak	0	0	0	0
8.	Rendah Lemak	238	189	199	105
9.	Rendah Protein	112	190	149	78
10.	Bubur Halus	128	139	140	101
11.	Cair	62	74	73	99
12.	Rendah Purin	239	162	251	155
13.	Tinggi Protein	38	51	28	55
14.	Blender	4	17	8	47
15.	Tinggi serat	5	3	0	0
16.	Tinggi Kalium	60	102	62	61
17.	Rendah Kalium	21	39	42	108
18.	Rendah Sisa	7	6	11	183
TOTAL		3702	3767	3604	96

4.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Bulan Januari 2025



Analisis :

1. Jumlah pemberian diit pasien rawat inap pada Bulan Januari mengalami penurunan, hal ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
2. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemesanan diit terbanyak selama Bulan Januari 2025 adalah TKTP sebanyak 1099, berbanding lurus dengan diagnose terbanyak di rawat inap yaitu Thypoid Fever dengan kebutuhan diit TKTP.
3. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
- 2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
- 3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.
- 4. Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
- 5. Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media.

4.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi

No	Indikasi	Jumlah Pasien		
		November 2024	Desember 2024	Januari 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	1069	1164	1049
2.	Konsultasi Rawat Jalan	14	14	4

4.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis :

Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan Januari 2025 menurun mengikuti jumlah pasien yang rawat inap. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan Bulan Januari 2025 juga menurun dikarenakan pasien dan keluarga minta di edukasi ulang terkait gizi sebelum KRS selain itu tidak ada rujukan dari DPJP untuk pasiennya konsultasi ke Poli Gizi Rawat Jalan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
- 2. Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
- 3. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Gizi.

4.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Januari 2025

No	Jenis Komplain	Nama Pasien	Analisis	Rencana Tindak Lanjut	Total Komplain
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	-	-	-	0
2.	OB / pasien yang tidak mendapatkan makanan	-	-	-	0

4.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan)

4.4.5.8 Lampiran Rekap Dara Kehilangan Alat Makan

No	Tanggal	Nama Pasien	Ruangan	Nama Alat	Bukti Kuitansi	Dokumentasi	Keterangan
Januari 2025							
1.	19/01/2025	Suratman	D7A-9	Sendok			Kasir salah nama
2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri Widodo	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran

Analisis :
Dari table diatas dapat diketahui bahwa ada 4 pasien yang menghilangkan/memecahkan alat makan, hal ini disebabkan kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga, tidak ada peraturan yang tertulis, sehingga alat makan dianggap sebagai barang yang tidak memiliki nilai.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti.
 - 2. Membuat “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan , CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

4.4.7 Laundry

4.4.7.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry selama Tahun 2024

NO	HAL	BULAN
		JANUARI 2025
BHP		
1.	CHEMICAL CLAX BUIT LITE (DIRIGEN)	2
2.	CHEMICAL CLAX 100 OB (DIRIGEN)	1.5
3.	CHEMICAL CLAX SONRIL ULTRA (DIRIGEN)	1.5
4.	CHEMICAL CLAX ANTI CHLOR (DIRIGEN)	1
5.	PEWANGI KISPRAY 300ML (PCS)	22
6.	PEMUTIH BAYCLEAN (LITER)	10
7.	SOFTENER (LITER)	18
8.	LIQUID MATIC (LITER)	9
9.	TABUNG LPG 12 KG (TABUNG)	20
TOTAL		85
LINEN (KG)		
1.	LINEN INFEKSIUS	2473
2.	LINEN NON INFEKSIUS	1806
3.	IRNA 2,3,4 A	280
4.	IRNA 6,7,8 A	630
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	316
6.	IRNA 4C	299
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	350
8.	IRNA 5C	310
9.	IKO	1847
10.	IRJA	70
11.	IGD	160
12.	LABORATORIUM	5

13.	RADIOLOGI	3
14.	DAPUR/GIZI	4
15.	CSSD	5
TOTAL		4279

4.4.7.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Januari 2025



Analisis :

1. Data diatas adalah jumlah pencucian linen pada Bulan Januari sebanyak 4279kg, ada perbaikan pengambilan dan penginputan data secara real time sehingga belum bisa dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
2. Jumlah linen infeksius sebesar 2473kg, sebagian besar berasal dari IKO. Hal ini disebabkan produktivitas IKO pada Bulan Januari 2025 meningkat.
3. Perbandingan bisa dilakukan 3 bulan selanjutnya.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

4.4.7.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Januari 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	JANUARI 2025
1.	Sprei	195
2.	Sarung bantal	290
3.	Selimut	225
4.	Baju tim IKO	118
5.	Baju ganti pasien	44
6.	Skort	162
7.	Perlak	21

8.	Baju ganti laundry	15
9.	Duk lubang besar	23
10.	Duk pembungkus	59
11.	Duk kecil 1 meter	58
12.	Duk ortho	20
13.	Duk lubang kecil	18
14.	Duk kaki	11
15.	Meja mayo	21
16.	Skort IKO	50
17.	Waslap	60
18.	Handuk CSSD	10

4.4.7.4 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Januari 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	JANUARI 2025
1.	Sprei	25
2.	Sarung bantal	24
3.	Selimut	14
4.	Baju tim IKO	9
5.	Baju ganti pasien	5
6.	Skort	0
7.	Perlak	6
8.	Baju ganti laundry	0
9.	Duk lubang besar	0
10.	Duk pembungkus	0
11.	Duk kecil 1 meter	0
12.	Duk ortho	0
13.	Duk lubang kecil	0
14.	Duk kaki	0
15.	Meja mayo	4
16.	Skort IKO	0
17.	Waslap	2
18.	Handuk CSSD	0
19.	Kerudung	1
20.	Bantal	12
Pemusnahan (+)		Tanggal 27/01/2025

Analisis :
Petugas melakukan sortir setiap hari, linen tidak layak dijadikan satu dan diajukan untuk dilakukan pemusnahan, BA sudah dikirim ke PT sebagai lampiran untuk penambahan linen pengganti.

Rencana Tindak Lanjut :
Follow up Pengadaan PT

4.4.7.5 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Januari 2025

NO	NAMA BENDA	JUMLAH
1.	Masker IKO	6
2.	Tissue	1
3.	Jarum	0
4.	Bumbu Dapur	0
5.	Uang	0
6.	Alat Tulis	1
7.	Benda lainnya	0

Analisis :
1. Masih ditemukan benda asing tercampur dengan linen, karena pemilahan seharusnya dilakukan di Unit sebelum linen dimasukkan kedalam tong linen kotor.

2. Ketidakterdisplinan paling banyak dari Unit IKO.
3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4.7.6 Tabel Permintaan Linen Cito/Tidak Sesuai Jadwal Pada Bulan Januari 2025

UNIT	TANGGAL	JENIS LINEN	JUMLAH	ALASAN
-	-	-	-	-

Analisis :

Tidak ada permintaan linen cito dari unit, hal ini dikarenakan laundry memiliki jadwal permintaan linen sehari 2 kali, dan laundry standby 24 jam.

Rencana Tindak Lanjut : -

4.5 Kinerja Umum dan Keuangan

4.5.7 SDM

4.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Bidan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	1	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	0	0	0	0	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	41	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		20	12	8	0
		SMK		2	1	1	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		D3 Farmasi		0	0	0	0
		SMK		1	0	1	0
		SMA		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	5	3	2	1	0
		D4 Fisioterapi		1	0	1	0
		S1 Profesi Fisioterapi		1	0	1	0
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0

		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	25	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
19	IRJA	Profesi Ners	25	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		13	12	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		8	5	3	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0

		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	16	8	8	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
40	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
48	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
51	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
52	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
53	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
54	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0

56	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			455				

Keterangan : Pada bulan Januari 2025 terdapat penambahan 1 dokter spesialis mata baru.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	dr. Isrotul Anisa	Dokter Umum	01 Januari 2025	SIP Baru
2	drg. Ega Lucida Chandra Kumala, Sp.Perio	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	08 Januari 2025	SIP Perpanjangan
3	dr. Latifah, Sp.M	Dokter Spesialis Mata	13 Januari 2025	SIP Baru

Keterangan : Pada bulan Januari 2025 terdapat 3 SIP baru untuk profesi dokter.

3.5.1.2 Rekrutmen

No	Profesi	Jumlah yang Dibutuhkan	Terpenuhi	Kekurangan	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

No	Tanggal	Jenis Orientasi	Nama Staf	Pendidikan	Profesi	SPMJ (Tanggal Masuk)	Keterangan
1	1 November 2024	Orientasi Khusus	Dimas Guntur Sujud	SMK	Cleaning Service	1 November 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
2	25 November 2024	Orientasi Khusus	Mokhamad Nadhif Darmawan	SMK	Security	25 November 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
3	28 November 2024	Orientasi Khusus	Niken Nurul Arafah., A.Md. Bns., S.Ak	S1 Akuntansi	Kasir	28 November 2024	Bulan ke-3 orientasi khusus
4	5 Desember 2024	Orientasi Khusus	Renaldi Salsabila, A.Md.Rad	D3 Radiologi	Radiografer	5 Desember 2024	Bulan ke-2 orientasi khusus
5	16 Desember 2024	Orientasi Khusus	Miftakhul Khoiriyah, S.Ft	Profesi Fisioterapi	Fisioterapis	16 Desember 2024	Bulan ke-2 orientasi khusus
6	28 Desember 2024	Orientasi Khusus	dr. Isrotul Anisa	Profesi Kedokteran	Dokter Umum	28 Desember 2024	Orientasi khusus 1 bulan

Keterangan :

Pada bulan Januari 2025 terdapat 3 staf yang menjalani orientasi khusus dibulan ke-3, 2 staf yang menjalani orientasi khusus dibulan ke-2, dan 1 staf yang menjalani orientais khusus selama 1 bulan

3.5.1.4 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

Pada bulan Januari 2024 tidak ada pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

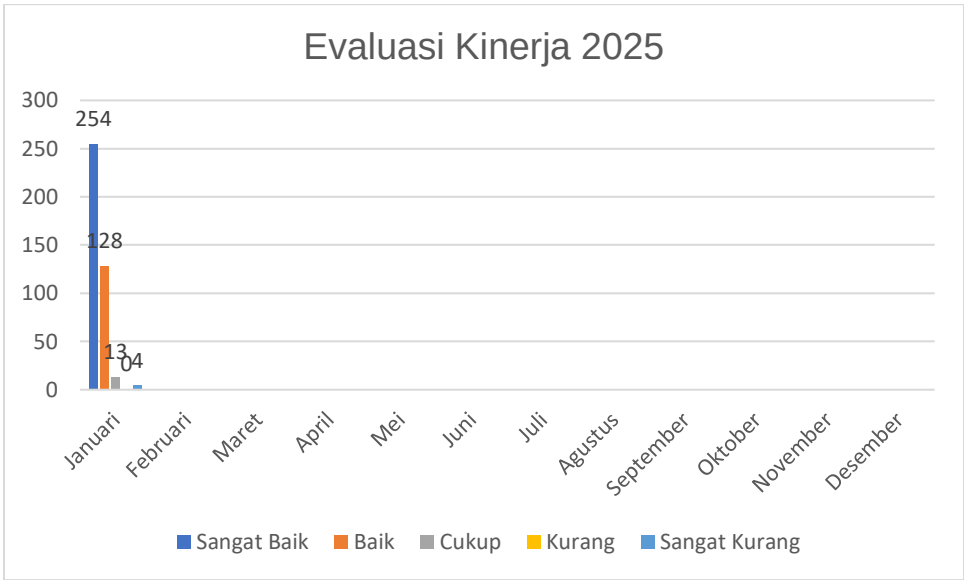
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
1	Manajemen	Umum	13 staf	0 staf	11	2	0	0	Unit Manajemen RS Prima Husada secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Asuransi Center	Umum	10 staf	0 staf	7	3	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	IRNA 2C	Umum	8 staf	0 staf	7	1	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
4	IRNA 3C Anak	Umum	15 staf	0 staf	13	2	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	IRNA 234A	Umum	18 staf	0 staf	12	6	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
									catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	IRNA 5C	Umum	9 staf	0 staf	8	1	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	IRNA 678A	Umum	25 staf	0 staf	16	7	1	1	Unit IRNA 678A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
8	Maternitas	Umum	12 staf	0 staf	11	1	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	Neonatologi	Umum	8 staf	0 staf	7	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	IGD	Umum	25 staf	0 staf	0	21	4	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	ICU dan HCU	Umum	12 Staf	0 staf	10	2	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	IKO	Umum	12 staf	0 staf	12	0	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	Gizi	Umum	17 staf	0 staf	16	1	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	Farmasi	Umum	41 staf	0 staf	22	17	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	Laboratorium	Umum	10 staf	0 staf	10	0	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	Radiologi	Umum	7 staf	0 staf	4	3	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	Rekam Medis	Umum	9 staf	0 staf	9	0	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	Pendaftaran	Umum	18 staf	0 staf	10	7	1	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			BAIK	JELEK	SB	B	C	K	
18	CSSD dan Laundry	Umum	9 staf	0 staf	8	1	0	0	Unit CSSD & Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	Keuangan dan Akuntansi	Umum	10 staf	0 staf	6	4	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	PIPP	Umum	5 staf	0 staf	3	1	0	1	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
21	Cleaning Service	Umum	45 staf	0 staf	38	7	0	0	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IT SIMRS	Umum	3 staf	0 staf	1	2	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	IPSRS	Umum	6 staf	0 staf	5	1	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Gudang Umum	Umum	2 staf	0 staf	0	1	1	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Driver	Umum	5 staf	0 staf	5	0	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Security	Umum	12 staf	0 staf	0	12	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	IRJA	Umum	31 staf	0 staf	28	3	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis : Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Januari 2025.

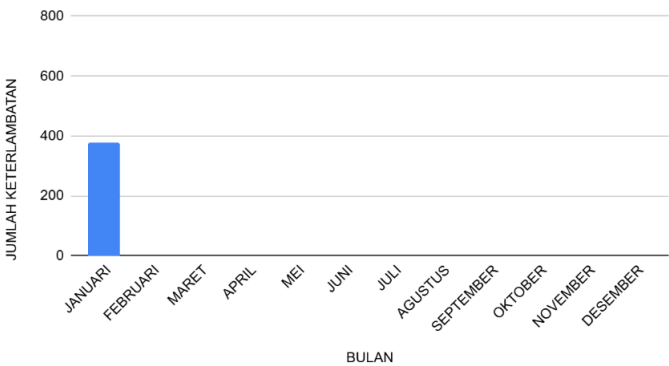
3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Analisis :

Terdapat 4 orang kategori sangat kurang karena 4 orang tersebut cuti.

JUMLAH KETERLAMBATAN 2025



Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Konseling	0										

Analisis :

Tidak ada konseling di bulan Januari

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.2 MFK dan K3RS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61											

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21

Analisa :
Pada bulan ini, capaian maintenance berjumlah 57.46%
Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis klinik Mutiara sehat

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	95	35	37%	Belum Mencapai Target

Analisa :
Pada awal januari digunakan metode baru pencatatan kinerja terutama terkait system pencatatan dan target perbulan. Sudah dilakukan maintenance dengan capaian sebesar 37%

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 3x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervisi, petugas sudah berkeliling dan melakukan dokumentasi.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Januari 2025							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/01/2025	2367	2076	291	MMHG			MMHG
02/01/2025	2076	1830	246	MMHG			MMHG
03/01/2025	1830	1570	260	MMHG			MMHG
04/01/2025	1570	1300	270	MMHG			MMHG
05/01/2025	1300	1025	275	MMHG			MMHG
06/01/2025	1025	794	231	MMHG	sebelum pengisian		MMHG
06/01/2025	794	3453			sesudah pengisian	2659	
07/01/2025	3453	3245	208	MMHG			MMHG
08/01/2025	3245	2986	259	MMHG			MMHG
09/01/2025	2986	2713	273	MMHG			MMHG
10/01/2025	2713	2365	348	MMHG			MMHG
11/01/2025	2365	2190	175	MMHG			MMHG
12/01/2025	2190	1855	335	MMHG			MMHG
13/01/2025	1855	1676	179	MMHG	sebelum pengisian		MMHG
13/01/2025	1676	3389			sesudah pengisian	1713	
14/01/2025	3389	3177	212	MMHG			MMHG
15/01/2025	3177	2892	285	MMHG			MMHG
16/01/2025	2892	2565	327	MMHG			MMHG
17/01/2025	2565	2275	290	MMHG			MMHG
18/01/2025	2275	2172	103	MMHG			MMHG
19/01/2025	2172	1866	306	MMHG			MMHG
20/01/2025	1866	1655	211	MMHG			MMHG
21/01/2025	1655	1445	210	MMHG			MMHG
22/01/2025	1445	1246	199	MMHG	sebelum pengisian		MMHG
22/01/2025	1246	3509			sesudah pengisian	2283	
23/01/2025	3509	3240	269	MMHG			MMHG
24/01/2025	3240	3035	205	MMHG			MMHG
25/01/2025	3035	2803	232	MMHG			MMHG
26/01/2025	2803	2588	215	MMHG			MMHG
27/01/2025	2588	2345	243	MMHG			MMHG
28/01/2025	2345	2050	295	MMHG			MMHG
29/01/2025	2050	1734	316	MMHG			MMHG
30/01/2025	1734	1512	222	MMHG			MMHG
31/01/2025	1512	1053	459	MMHG			MMHG
31/01/2025	1053	3446				2583	
			0	MMHG			MMHG
			0	MMHG			MMHG
			0	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			7658	MMHG			
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						9028	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			483,9310345	MMHG			
Rata-rata pengisian liquid per bulan ini						3611,2	MMHG

Analisis :
Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

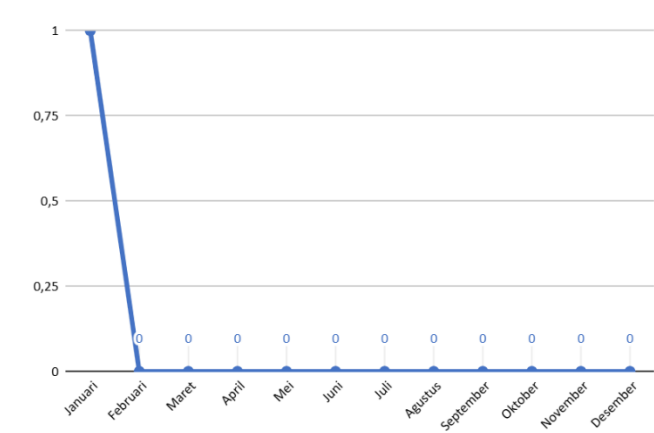
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang

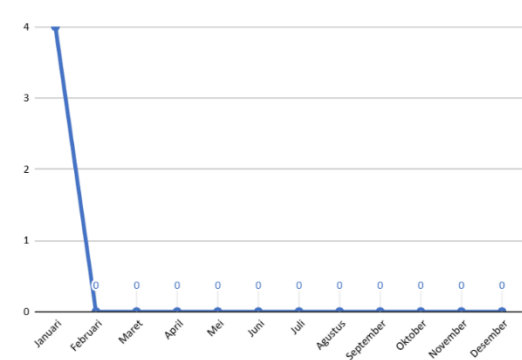


ANGKA KEJADIAN KEHILANGAN BARANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
03 – 01 – 2025	telah ditemukan uang sejumlah 150rb oleh petugas pendaftaran mbk susan di area Gedung poli spesialis , diamankan di pos IGD	Masih di pos security IGD

3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	1	0	0	0	0	1	3	5	1	2

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
06 – 01 - 2025	Telah ditemukan tas warna pulkadot di ruang tunggu farmasi diamankan di pos IGD	Telah diambil pemilik
07 – 01 – 2025	Laporan kehilangan barang pribadi berupa dompet oleh pengunjung di area masjid rsph a/n IMRON	Setelah dilakukan telusur cctv dompet diketahui telah diamankan oleh imam masjid pak margo selanjutnya diamankan oleh mas alif dan diserahkan ke security untuk dilakukan pengamanan barang bukti Barang bukti telah di ambil oleh pemilik
13 – 01 – 2025	telah ditemukan berkas a/n SALIM diamankan di pos IGD	Dokumen telah di ambil pemilik
15 – 01 – 2025	Telah ditemukan hp pengunjung di area taman depan farmasi diamankan di pos igd	Telah diambil pemilik a/n SUHARLI

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

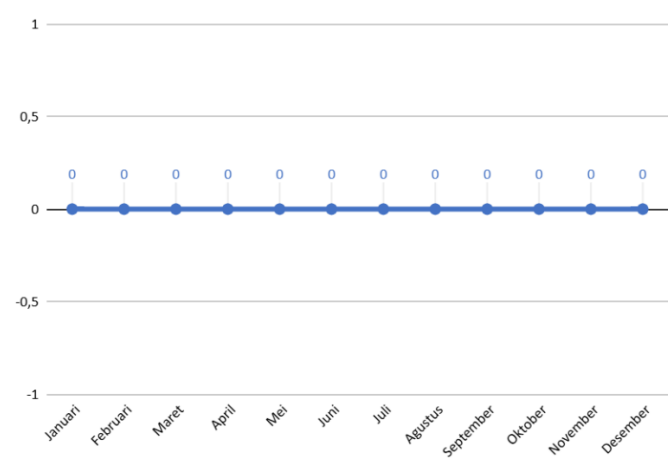
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

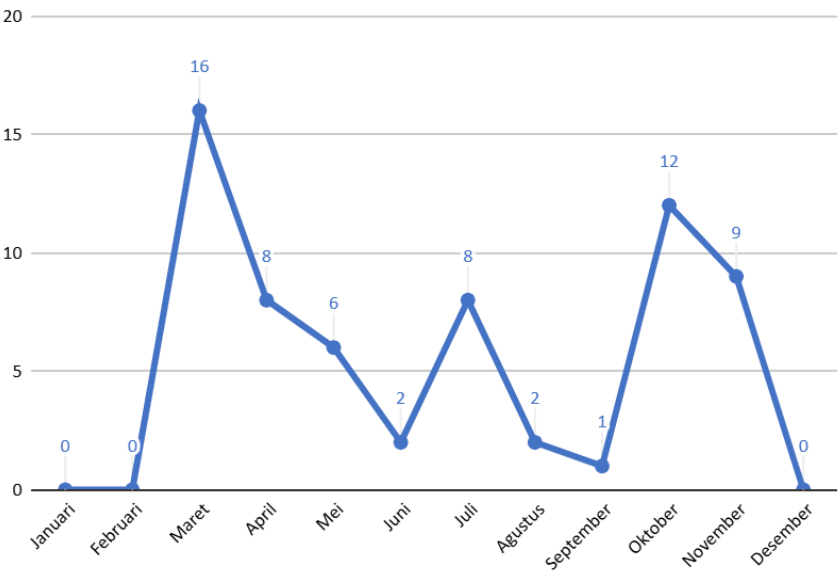


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusuhan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3											

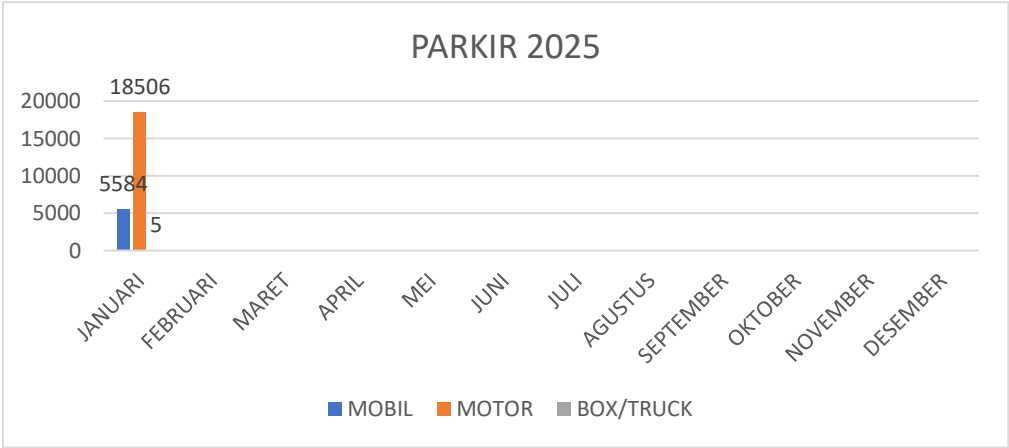


Analisis :
Angka ini relative kecil. Belum sepenuhnya tercatat. Yang tercatat adalah laporan security saat keliling saja.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
Progres parkir bulan januari masih fluktuatif. Akan dilihat pada progress bulan Februari 2025

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

No	Bulan	Target	Jumlah					Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	2 (review pihak kedua) 1 (progres evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	1
Analisis ; 1. Pada bulan Januari 2025, PKS Expired dengan instansi lain masih dalam progres Rencana Tindak Lanjut : 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua 2. Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RSPHM								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Januari 2025

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Kimberly Clark	Proses Pengiriman Draft	PIC berganti
2	PT. Malang Intermedia Pers	Proses Pengiriman Draft	PIC berganti
3	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Ada beberapa notice terkait kesepakatan
4	BPJS Kesehatan	Sudah Perpanjang	-
5	BPJS Ketenagakerjaan	Sudah Perpanjang	-
6	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Perbedaan template draft PKS
7	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Ada beberapa notice terkait kesepakatan
8	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD Pihak Kedua	-
9	BKKBN	Sudah Perpanjang	-

3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU

NO	BULAN	JUMLAH PASIEN	REVIEW
1	November 2024	25 37 (PT Citra Karya Dinamika) 13 (PT KTG)	Analisis : Berdasarkan data bulan Januari, pasien Medical Check Up dari Perusahaan masih belum terlaksana..
2	Desember 2024	79 PT Indonusa Algaemas Prima) 16 (PT Sinergi Pangan Gemilang) 50 (PT Indonesian Tobacco)	Review hasil kunjungan dengan PDSA Plan 1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan 2. Mempromosikan program MCU dan Vaksin 3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan secara berkala
3	Januari 2025	95	Do 1. Mempromosikan program MCU dan Vaksin setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain Study 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU. 2. Perusahaan memilih harga MCU paling murah diantara vendor. 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan. Action 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5										

Analisa :
 Kunjungan eksternal mulai dilakukan Kembali untuk sosialisasi kebijakan yang berhubungan dengan rujukan pasien dan pengenalan staf baru.

ANALISA :
 Kunjungan eksternal mulai dilakukan Kembali untuk sosialisasi kebijakan yang berhubungan dengan rujukan pasien dan pengenalan staf baru.

RTL :
 Monitoring dan evaluasi berkala.
 Monitoring dan evaluasi berkala.

3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Tabel Follower Media Sosial yang Dikelola RS Prima Husada Malang

Bulan	Follower			Unfollow		
	Instagram	Youtube	Tiktok	Instagram	Youtube	Tiktok
Januari 2025	17235	282	184	108	0	0
Analisis : - Digital marketing untuk mengelola Youtube belum ada masih menjadi satu di PT. - Follower Instagram meningkat karena tim PKRS aktif melakukan upload dan promosi di media sosial. - Akun baru Tiktok RSPH membantu dalam digital marketing						

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER INSTAGRAM	496	-17,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER TIKTOK	16	-182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG																
PERIODE 2025																
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
											Y	Z	AA	AB	AC	
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f=g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
PERIODE JANUARI 2024 :																
	Asuransi	293.604.489	76.844.798	2.082.312	124.677.359	222.634.032	34.991.526	1.425.358	186.217.148	319.894.507	237.611.490	27.896.108	22.864.884	21.900.964	982.148	319.894.507
	Perusahaan	267.299.964	109.418.709		157.879.254	80.107.698	5.912.000		84.195.698	242.065.952	161.882.962	2.832.348	17.789.291	33.905.194	26.676.156	242.065.952
	Mandiri Inhealth	83.667.153	55.329.576	946.619	27.330.958	43.875.009			43.875.009	71.205.967	70.833.938				372.039	71.205.967
	Jasa Raharja	120.917.190	119.996.274	1	920.917	81.120.474			81.120.474	82.041.391	81.120.474			809.917		82.041.391
	BPJS Ketenagakerjaan	745.739.611			745.739.611	428.693.014			428.693.014	1.174.432.625	1.167.949.088	2.315.100		497.635	3.710.742	1.174.432.625
									Total Saldo	1.880.640.443	1.719.297.952	33.182.607	41.515.073	50.303.734	30.341.078	1.880.640.443

Keterangan :
Cut Off Piutang per 31 Januari 2025 saldo akhir Rp 1,880,640,443

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Pelayanan pasien Rawat inap di rujuk di hari yang sama saat pasien di IGD	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Indikasi Pasien rawat inap untuk kasus	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Diagnosa pneumonia anak diminta menggunakan score CURP	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Pasien Buried penis diminta menggunakan circumsisi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
5	Pasien meninggal di IGD diminta klaim Rawat Jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

3.5.6 PIPP – MOD – MPP

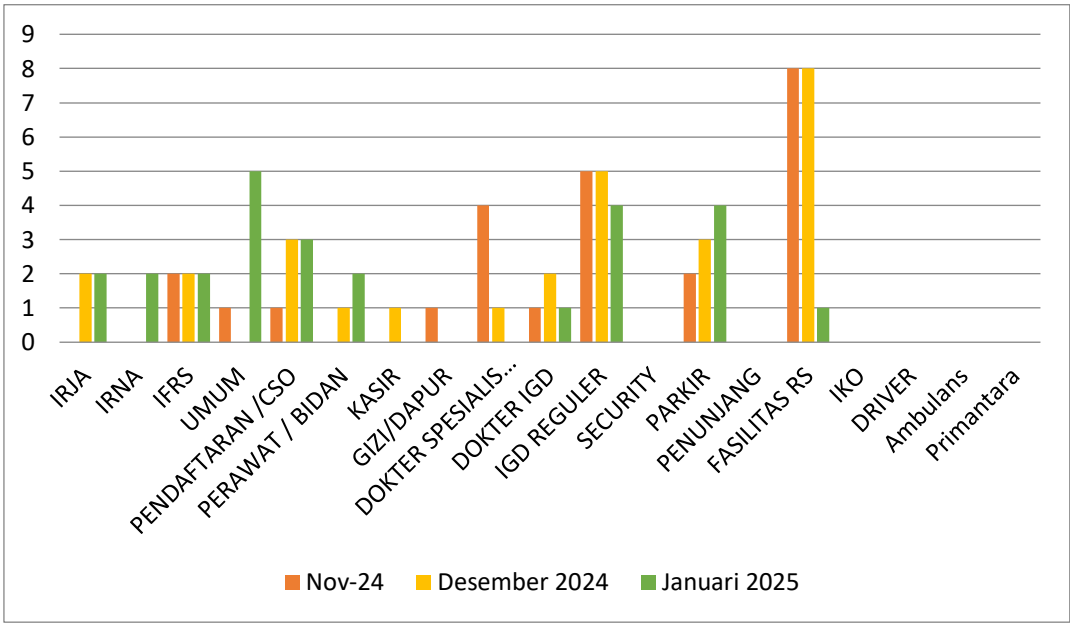
3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Januari 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1.	IRJA	0	2	2
2.	IRNA	0	0	2
3.	IFRS	2	2	2
4.	UMUM	1	0	5
5.	PENDAFTARAN /CSO	1	3	3
6.	PERAWAT / BIDAN	0	1	2
7.	KASIR	0	1	0
8.	GIZI/DAPUR	1	0	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	4	1	0
10.	DOKTER IGD	1	2	1
11.	IGD REGULER	5	5	4
12.	SECURITY	0	0	0
13.	PARKIR	2	3	4
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	8	8	1

16	IKO	0	0	0
17	DRIVER	0	0	0
18	Ambulans	0	0	0
19	Primantara	0	0	0
Total		25	28	26

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Januari 2025



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Januari 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan Januari 2025 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan November 2024 25 kasus, pada bulan desember 2024 naik menjadi 28 kasus complain Sedangkan pada Januari 2025 turun menjadi 26 kasus komplain
2. Komplain terbanyak pada bulan Januari 2025 yaitu dari bagian UMUM sebanyak 5 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 8 kasus complain dengan rincian :
 - 1) Fasilitas RS sebanyak 1 kasus yaitu terkait penempatan ruangan pasien kurang luas
 - 2) Bagian UMUM sebanyak 3 kasus yaitu terkait penunggu pasien masih banyak yang tidak patuh jam berkunjung, masih ditemukan pengunjung merokok di kamar mandi rawat inap
 - 3) Parkir sebanyak 4 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap, permintaan area parkir sepeda motor diberikan kanopi agar tidak kepanasan

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan November 2024

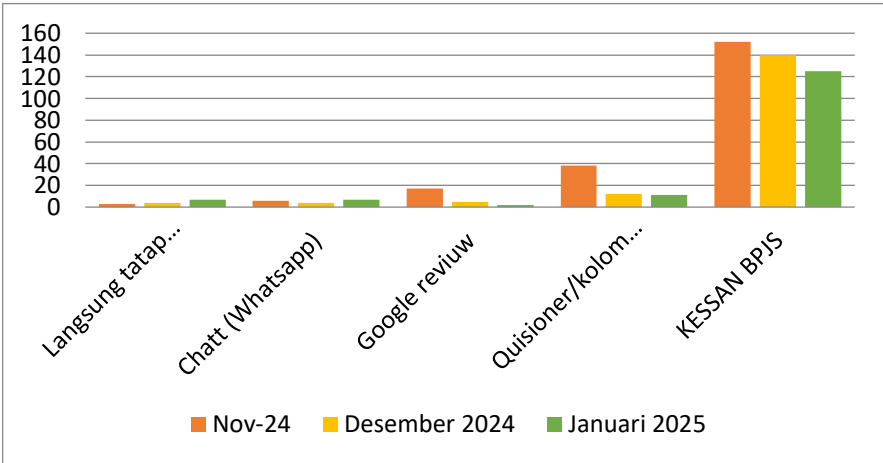
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1.	Langsung tatap muka	3	4	7
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	6	4	7
	b. Google review	8	5	2
3.	Quisioner/kolom kritik saran	17	12	11
4.	KESSAN BPJS	152	140	125

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	1	0	2	23	99

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Januari 2025



Analisis :

Pada bulan Januari 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 11 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari tatap muka dan WA sebanyak 7 kasus, dari google reviuw sebanyak 2 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Januari 2025

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 ‘	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 ‘	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	0	0	0
					100%		
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	0	0	0
					100%		
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	3	1	0
					98%	2%	
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	11	7	0
					83%	17%	
5.	KESSAN	100%	0	100%	125	0	0
					100%		

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Januari 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 83% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 8 kasus complain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 1 kasus yaitu terkait penempatan ruangan pasien kurang luas
- 2) Bagian UMUM sebanyak 3 kasus yaitu terkait penunggu pasien masih banyak yang tidak patuh jam berkunjung, masih ditemukan pengunjung merokok di kamar mandi rawat inap
- 3) Parkir sebanyak 4 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap, permintaan area parkir sepeda motor diberikan kanopi agar tidak kepanasan

Rencana Tindak Lanjut :

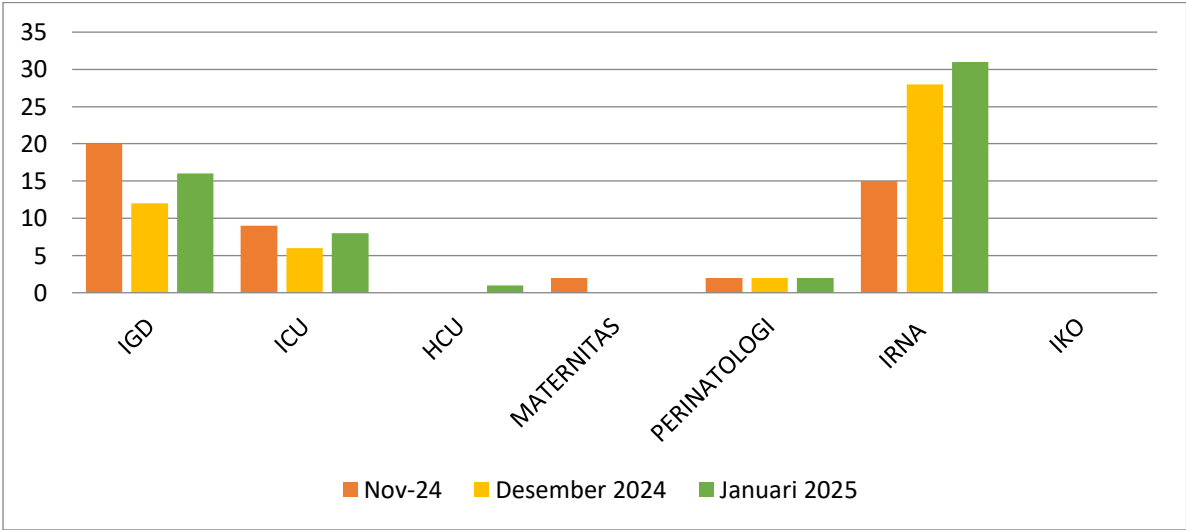
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Januari 2025

NO	UNIT PERUJUK	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1.	IGD	20	12	16
2.	ICU	9	6	8
3.	HCU	0	0	1

4.	MATERNITAS	2	0	0
5.	NEONATOLOGI	2	2	2
6	IRNA	15	28	31
7	IKO	0	0	0
Total		48	46	58

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Januari 2025



3.5.7.5.3 Tabel Rincian Pasien Rujuk Januari 2025

NO	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	Ny. Yunaini Ningsih	HCU	Susp. Endokarditis infeksiosa	dr. Mira Sp. JP	RS Karsa Husada	penatalaksanaan lebih lanjut	3	Plavon : 3.353.000 Tarif rs : 7.005.489 Minus : 3.652.489
2	TN. M TAUFIK AGUNG YULIANTO	IRNA	DoC dt Extracranial, Encephalopati Uremicum	dr. ardhany sp.pd	RS Karsa Husada	pro HD	3	Tidak
3	Ny. JUMIK	IGD	Open fraktur distal fibula et tibia D	dr Oka, Sp.OT	RSSA	Pro C-ARM	2	Tidak
4	Tn. Muntarib	IRNA	Pneumoni,CKD st V	dr. Elvi Sp.P Konsul dr. Ardhany Sp.PD	RSSA	Pro HD	1	Tidak
5	Ny. Ratini	ICU	CVA Emboli+HF+PAC+Hemiplegi dextra	dr. Syahrir Sp.S	RS Karsa Husada Batu	Perawatan Stroke Unit	4	Tidak
6	An. Yehezkiel Andreas Irawan	IRNA	TF, DF, Hemaptoe dengan trakesotomi	dr. Dicky Sp. A	RSSA	penatalaksanaan lebih lanjut	5	Tarif rs : 3.711.891 Plavon : 2.826.800 Minus : 885.091
7	Ny. Ngatini	IRNA	DM Hipoglikemia, CHF, ACKD, Leukositosis	dr. Ardhany Sp. PD	RSJ Lawang	Penanganan lebih lanjut	2	Tidak
8	Ny. Juni Misnati	IGD	DOC dt Susp. Stroke Hemoragic dd Infark, HT Krisis, Obs. Konvulsi	dr. Farid Sp. N	RSSA	Pro Stroke Unit	2	Tidak
9	Ny. Ayu Rahmalia	IRNA	Evan Syndrome dd ALL MDS	dr. Heri Sp. PD	RSSA	Pro Perawatan Lebih Lanjut	2	Tidak
10	Ny. Sri Rahayu	IRNA	Susp. Ca Caput Pankreas,	dr. Ardhany	RSSA	Pro perawatan	2	Tidak

	Purwantini		Metastase Liver	Sp. PD		lebih lanjut Perawatan Sp. KD - KGEH		
11	Ny. Tarmini	IRNA	Post Hipoglikemia, ACKD, CHF	dr. Ard hany Sp. PD	RSJ Lawang	Pro perawatan lebih lanjut Perawatan Sp. KD - KGEH	3	Tidak
12	Ny. YUNIARTI	IGD	DOC dd Hydrocephalus dt CVA Infark	dr. Farid Sp.N c/ dr. Ira Sp.JP c/ dr. Andi Sp.P	RS Lavalette	Pro stroke unit	1	Tidak
13	Tn. Suwarno	IRNA	Susp. atelektosis paru sinistra	dr Anton Sp.B	RSSA	Pro BTKV	2	Tidak
14	Tn. KARSONO	IRNA	DSS, PPOK	dr Ardhi, Sp.PD	RSJ Lawang	Pro penatalaksanaan lebih lanjut	5	Tarif rs : 3.318.820 Plavon : 2.465.000 Minus : 853.820
15	Tn. Rukiyadi	IRNA	ACKD, Nefrolithiasis, Anuria	dr. Ard hany Sp. PD	RS. Karsa Husada Batu	Pro HD	3	Tidak
16	Tn. Sujitno	IGD	STEMI Infero poster lateral	dr. Mira Sp. JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
17	Ny. Sukati	IGD	CVA ICH, HT Emergency, DM Tipe 2	dr. Dewi Sp. S	RS Lavalette	Pro Stroke Unit	2	Tidak
18	Tn. Muhammad Fahrudin	IRNA	Anemia Gravis	dr. Ard hany Sp. PD	RSSA	Pro Endoskopi Sp. PD. KGEH	3	Tidak
19	Ny. Nur Istiqomah	IRNA	DM, HT, Hipokalamia, Imobilisasi	dr. Ard hany Sp. PD	RSJ Lawang	Pri Unit Freatic	2	Tidak
20	Ny. Sisca Wulansari	ICU	P2002AB0 dng late HPP + Sub Involutio Uteri + Syok Hemoragic	dr. Humairah Sp. OG	RSSA	Pro Histerektomy dan transfusi	1	Tidak
21	Tn. Abdul Maliq	ICU	NSTEMI, Shock Cardiogenic, Dilated Cardiomippaty, MR, TR	dr. Mira Sp. JP	RS. UMM	Pro PCI	4	Tidak
22	Tn. Yuniar Ardiansyah	HCU	DSS, Ensefalitis Dengue	dr. Ard hany Sp. PD	RSSA	Pro Perawatan Sp. PD KPTI	6	Tarif rs : 5.880.605 Plavon : 3.446.400 Minus : 2.434.205
23	Ny. Solikah	IRNA	CKD st 5	dr. Ard hany Sp. PD	RSUB	Pro HD	3	Tidak
24	Ny. Ngasiami	IGD	ADHF, AKI ST 2-3	dr. Ira Sp. PD Raber dr Ardhi Sp. PD	RSSA	Pro HD	1	Tidak
25	Ny. Tunik	ICU	ACKD, Sepsis, Diare, Geriatric Sindrom	dr. Ardhani Sp. PD	RSJ Lawang	Pro Perawatan Lanjutan Geriatric Sindrome	3	Tidak
26	Tn. Sujiono	HCU	NSTEMI, ALO Cardiogenic, Syock Cardiogenic, PVC	dr. Mira Sp. JP	RSSA	Pro PCI	3	Tidak
27	Tn. HARYONO	IGD	Susp. CVA Infark dd ICH	dr. Farid Sp, N	RS Lavalete	Pro Stroke Unite	1	Tidak
28	Tn. Kabul	IRNA	CKD st 5	dr. Heri, Sp.PD	RSSA	Pro HD	3	Tidak
29	Ny. Murthosimah	IGD	Obs. Dypsnea dd Efusi Pleura Masif dd Susp. Tu Mediastinum	dr. Andy.SP.P	RS Karsa Husada	Pro HD	1	Tidak
30	Ny. NGATMINI	IRNA	LUXURY PERFUSION DD SAH	dr. Farid Sp, N	RSSA	PRO DSA + COILING/CLIPING	3	Tidak
31	Ny. Neni Puspitasari	HCU	SOP Cerebri Supratentorial dt susp. Toxoplasmosis cerebri, post status general motor onset clonic seizure, B20	dr. Fahima Sp. S	RS Lavalete	Perawatan lanjutan tatalaksana Tu Cerebri dan HIV	3	Tarif rs : 5.627.382 Plavon : 2.738.300 Minus : 2.889.082
32	Tn. Nicolas Dwi Hendratmoko	IRNA	TU Cerebellum + Hydrocephalus Post op vp shunt. Post vpshunt. Hematemesis	dr. Fachriy Sp. Bs Raber dr Syahrir Sp. S konsul dr Ira Sp. Jp konsul dr	RS Karsa Husada	Pro MRI dan Excisi Tumor	6	Tarif rs : 28.909.992 Plavon : 20.269.100 Minus : 8.640.892

				Ardhany Sp. PD				
33	Ny. Paini	IRNA	Ileus obstruktive dt susp. Gallstone ileus, Joundiace, Susp. Sepsis, Trombositopenia	dr. Zaki Sp. B	RSSA	Pro Explorasi CBD	2	Tidak
34	By. Ny. Nurul Khoiriyah	NEO	NP-BBLSR	dr. Ratih, Sp. A	RSUD SAIFUL ANWAR MALANG	atalaksana subspesialistik neonatologi (tatalaksana apneu of prematurity+feeding difficult), pro NIPPV (sesuai indikasi)	7	Tidak
35	TN. FRANSISCUSH NASIPAN	IRNA	CKD stage 5	dr. Ardhany, Sp.PD-KGH	RS Lavalete	Pro HD	2	Tidak
36	Ny. Astika	IGD	CKD	dr. Heri, Sp.PD	RS Lavalete	Pro HD	2	Tidak
37	Tn. Khoirul Anam	IRNA	Syok Septic + Oliguria	dr. Pradana, Sp. U	RSSA	Pro HD	3	Tidak
38	BY Ny siti zakiyatul	NEO	RDS + Neonatal Pnemonia + TTNB + Makrocephal	dr. Fiona SpA	RST	Pro Ventilator	3	Tidak
39	Ny. Yulia mardiana	IRNA	Susp. Autoimun Disease	dr. Ardhany, Sp.PD-KGH	RSSA	Penanganan dengan dr. Sp. PD.KR	5	Tarif rs : 3.007.232 Plavon : 2.269.000 Minus : 738.232
40	Tn. Subari	ICU	Syock Condition dd syock hipovolemic	dr. Heri, Sp.PD	RSSA	curiga keganasan	2	Tidak
41	Tn. ALI MUSTOFA	IGD	Susp Ileus Obatraktif dd massa intraabdomen	drAnton, Sp.B	RSSA	Pro Diagnosis Lanjutan	1	Tidak
42	Ny Maru'ah	IRNA	CKD STG V, Edema Paru, HT Emergency, Hiperkalemi	dr. Ardhany Sp. PD	RSUD Kanjuruan	Pro HD	5	Tidak
43	Sdr Yasiman Yanuarius Jepang	IRNA	CKD st 5, Post Ht Emergency, CHF, Pneumonia, Anemia, Sindrome uremikum	dr. Ardhany Sp. PD	RSSA	Pro HD	4	Tidak
44	Ny Asminarti	IRNA	TB Paru dd PCP, GEA, B20	dr Elvi Sp P	RS Lavalete	penatalaksanaan TB+HIV	2	tidak
45	Tn Awin Ashar	IRNA	batu ureter sinistra post URS, peritonitis susp perforasi organ berongga	dr Edi Sp U	RSSA	Pro C-ARM	4	tidak
46	sdr RENDY FEBRIANTO	IRNA	susp ITP ddx MDS + hematokezia profuse	dr. Ardhi Sp.PD	RSSA	PRO PENANGAN LEBIH LANJUT	2	Tidak
47	NY. SITI ROKAYAH	IRNA	Emboli Stroke	dr. Farid Sp.S konsul dr. Eko Sp.KFR, Konsul dr Ira Sp.JP	RSSA	PRO unit stroke	3	Tidak
48	TN. ARDI	IGD	Syok cardiogenic	DR. YOGA, SP.JP	RS KARSA HUSADA	PRO ICU	1	Tidak
49	TN. SULIONO	IGD	CKR + Vull App nasal	DR. Fachri Sp.BS	RSSA	PRO PENANGAN LEBIH LANJUT	1	Tidak
50	TN. SAMI'UN	IGD	COR, ICH temporoparietal D	DR. Fachri Sp.BS	RST	PRO PENANGAN LEBIH LANJUT	2	Tidak
51	Ny. Rumayah	IGD	Hiperlekositosis, Anemia Susp. Acute Leukemia	dr. Ardhi Sp. PD	RSSA	PRO PENANGAN LEBIH LANJUT	1	Tidak
52	Tn. Agus Trianto	IGD	COS, SDH, SAH, Edema Cerebri	dr. Fachriy Sp. Bs	RSSA	Pro Tatalaksana lebih lanjut	2	Tidak
53	Nn. Nifa Atin	IRNA	Autoimun Susp SLE, Hiponatremia	dr. Farid Sp. N	RSSA	Pro Penatalaksanaan Autoimun lebu h lanjut	3	Tidak
54	Tn. Thoha Barokah		COPD AE, ARDS, Hemaptoe, Hi[on]atremia	dr. Andy Sp. P	RSSA	Pro HCU Isolasi	3	Tidak
55	Tn. Supeno	IRNA	CVA Infark, Hipoalbumin, ARDS, Sepsis	dr. Farid Sp. N	RSSA	Pro Stroke Unit	9	Tidak
56	Ny. Fathilah Wasiati	ICU	CVA Emboli, CAD	dr. Farid Sp. N konsul dr Virginia Sp. KFR Konsul	RSSA	Pro Stroke Unit	4	Tidak

				dr Yoga Sp. Jp				
57	Tn. Johan Dwi Swandana	IRNA	Multiple fraktur, Cr Femur dex, Cf costae II-V Dex, Cf Costae II, IV Sin, Cf clavicula dex, Cf Body Scapulae sin, Susp Internal Bleeding	dr. Oka Sp. OT konsul dr Anton Sp. B	RSUD Soertomo	Pro Multidisipliner (Ortho, bedah, urologi_)	2	Tidak
58	Ny. Mira Agustina	IGD	Fraktur Compresi Lumbal 1	dr. Fachriy Sp. Bs	RSSA	Pro Pedical Scrow	4	Tidak

Analisis :

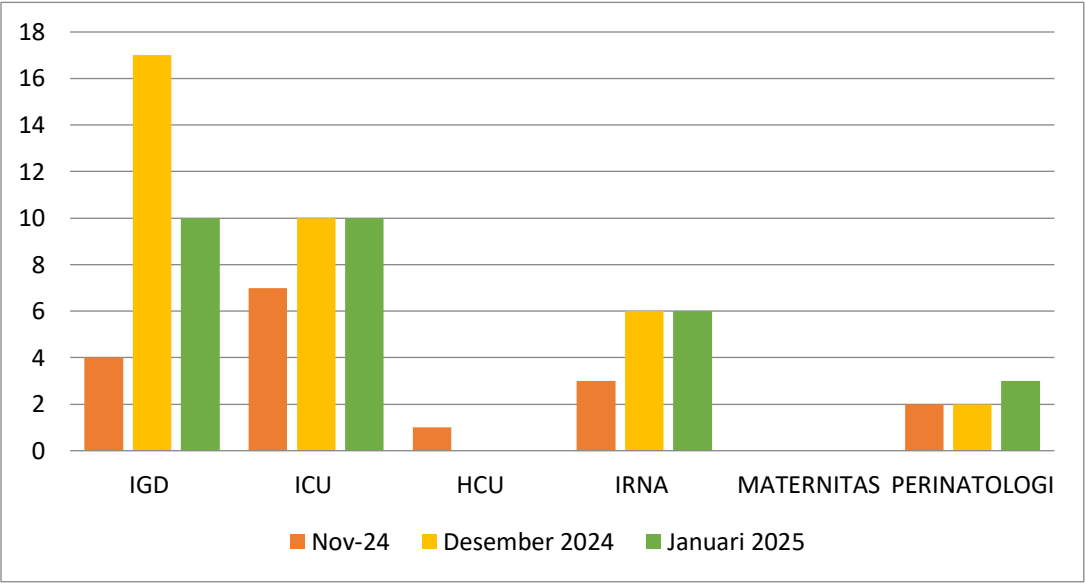
1. Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Januari 2025, pada bulan November 2024 sebanyak 48 pasien, pada bulan desember 2024 sebanyak 46 pasien Sedangkan pada bulan januari 2025 sebanyak 58 pasien
2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - a) Pro PCI
 - b) Pro CVCU
 - c) Pro stroke unit
 - d) Pro HD
 - e) Pro Bedah digestif
 - f) MRI
 - g) Pro bedah saraf lanjutan
 - h) Membutuhkan alat khusus
 - i) Membutuhkan pengobatan ARV
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya bulan Desember 2024 sebanyak 5 pasien dengan jumlah total minus Rp.14.703.095 Sedangkan pada bulan Januari 2025 sebanyak 7 pasien dengan total minus Rp. 20.093.811.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Januari 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1.	IGD	4	17	10
2.	ICU	7	10	10
3	HCU	1	0	0
4.	IRNA	3	6	6
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	2	2	3
Total		17	35	29



NO	Nama Pasien	UNIT	Diagnosis	DPJP
1	Ny Nasri	IRNA	cholelitisias, kista renal, tu paru	dr Heri, Sp.PD
2	Tn. Sugiono	ICU	SAH, Hidrocefalus	dr. Fachriy Sp. Bs. Raber dr Farid Sp. N Raber dr. Heru Sp. An
3	Tn. Rudy Lukmanto	ICU	CVA Infark, DM , Hypernatremia	dr. Farid Sp. N
4	Ny. Kasmi	ICU	Memingioma, Status epileptikus	dr. Dewi Sp. S
5	TN Masruri	IGD	STEMI	dr Mira, Sp.JP
6	NY SITI MASKINATIN	IGD	ALO, Syok Cardiogenik, Efusi Pleira	dr Ira, Sp JP
7	Ny. Tuminah	IGD	CVA ICH	dr. Fahima Sp. S
8	BY NY LUTFIATUL	NEO	IUFD	dr Aida, Sp.OG
9	Ny. TJOA LAM ING NIO	ICU	pnumonia aspirasi, respiratory failure,	dr Farid, Sp.N
10	TN. M SOLKAN	IGD	Respiratory Failure dd ARDS	DR. ELVI, SP.P
11	TN. PUGUH MUKDIARNO	IGD	Pneumothorax Dextra ec TB Paru Far Advance on Tx + Sepsis	DR. ELVI, SP.P
12	Tn. Cucu Kusnadi	IRNA	Hidrouretronefrosis Bilateral	dr. Heri Sp. PD
13	Ny. Mudjiwarti	IGD	DOC Ec Stroke dd Sepsis	dr. Naufal
14	Ny. Sri Rahayu	IRNA	ARDS+ LUNG TB INAKTIF DD AKTIF	DR. ANDY SP.P
15	Tn. H. Syamsuri	ICU	DOC, DM HIPERGLIKEMIA, CKD, KAD, Susp. CVA	dr. Farid Sp. N
16	Ny. Dasi'ati	ICU	Destroyed lung e.c pneumonia dd TB Paru, Sepsis, ARDS	dr. Elvi Sp. P
17	Ny. Suliana	ICU	Necrotizingfascitis regio gluteus (D), post OP excisional debridement, Dm hiperglikemia, ARDS	dr heru sp An, dr Anton, Sp.B
18	Tn. Asep Dayat S	ICU	Peritonitis	dr. Zaky Sp. B Konsul dr. Heru Sp. An
19	Tn. Chamim Tohari	ICU	DOA	dr. Rino
20	TN. ABDUL MUJIB	IGD	CVA HEMORAGIK	dr. Fahima
21	Ny Hadidjah	ICU	TB Paru, ARDS	dr Andi Sp P

22	NY. SRI WAHYUNI	IGD	DOA	dr Sofia
23	TN. KAYAT	IGD	SYOCK SEPTIC	dr Rino
24	Ny. Ismatul Iza	IRNA	DM Hiperglikemia, Syok Hipovolemik, AKI dd DM Nefropaty, HF, Akute DOC	dr. Ardhi Sp. PD
25	Ny. Siti Rohmah	IGD	CAD	dr. Ardhanay Sp. PD
26	By. Ny. Dinda	NEO	IUFD	dr. Humairah Sp. OG
27	Ny. Juma'ani	IRNA	AMS Susp Eremic Encephalopatya, CKD st 5, dm Post Hipoglikemia	dr. Ardhi Sp. PD
28	Tn. Rakiman	IRNA	Hepatocarsinoma, Hidrouretronefrosis, Splenomegali, Asites	dr. Heri Sp. PD
29	By. Ny. Firda	NEO	Missed Abotion	dr. Humairah Sp. OG

- Analisa :**
1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Januari 2025 sebanyak 29 pasien
 2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 10 pasien, ICU : 10 pasien, IRNA 6 pasien, dan Neonatologi sebanyak 3 pasien.
 3. Pada bulan Desember 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 2 kasus.
 4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut
 Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.8 *Cleaning Service*
3.5.8.1 Indikator Kerja *Cleaning Service*

KATEGORI	DESKRIPSI
SEIRI	Penempatan Alat Kebersihan di Janitor/ trolly
	Penempatan Alat Kebersihan di Janitor/ trolly
SEITON	Kerapian baju dan kebersihan, penampilan petugas CS
	Kerapian baju dan kebersihan, penampilan petugas CS
SEISO	Membersihkan area kerja secara rutin sesuai jadwal
	Membersihkan area kerja secara rutin sesuai jadwal
SEIKETSU	Mematuhi SOP kebersihan
	Mematuhi SOP kebersihan
SHIKETSU	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan
	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan
	Konsistensi dalam menjalankan 5S secara mandiri tanpa pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

NO	JENIS SPV	NILAI BULAN INI	NILAI MAX	CAPAIAN
1	SEIRI / RINGKAS	272.5	430	63%
2	SEITON / RAPI	560	645	87%
3	SEISO / RESIK	920	1290	71%
4	SEIKETSU / RAWAT	335	430	78%
5	SHITSUKE / RAJIN	1090	1505	72%
	TOTAL	3177.5	4300	74%

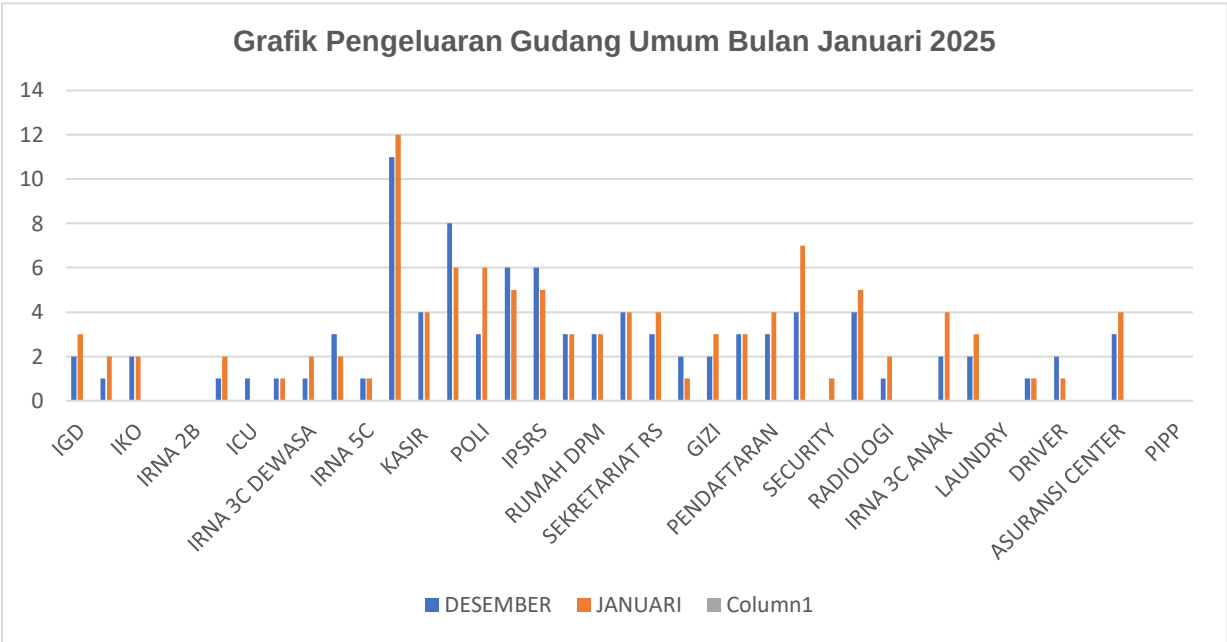
Analisa :
 Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih dalam moneyv karena memakai instrument supervise yang baru.

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		DESEMBER	JANUARI	
1	IGD	2	3	↑33,33%
2	MATERNITAS	1	2	↑50%
3	IKO	2	2	↑0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	1	2	↑50%
7	ICU	1	0	↓0%
8	IRNA 3A	1	1	↑0%
9	IRNA 3C DEWASA	1	2	↑50%
10	IRNA 4C+4A	3	2	↓-50%
11	IRNA 5C	1	1	↑0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	11	12	↑8,33%
13	KASIR	4	4	↑0%
14	DAPUR	8	6	↑-33,33%
15	POLI	3	6	↓50%
16	CLEANING SERVICE	6	5	↓-20%
17	IPSRs	6	5	↑-20%
18	GUDANG FARMASI	3	3	↑0%
19	RUMAH DPM	3	3	↑0%
20	SEKRETARIAT PT	4	4	↑0%
21	SEKRETARIAT RS	3	4	↑25%
22	CSSD	2	1	↓-100%
23	GIZI	2	3	↑66,66%
24	REKAM MEDIS	3	3	↓0%
25	PENDAFTARAN	3	4	↓25%
26	DEPO FARMASI	4	7	↑42,85%
27	SECURITY	0	1	↑100%
28	LABORATORIUM	4	5	↑20%
29	RADIOLOGI	1	2	↑50%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	2	4	↑50%
32	NS NICU	2	3	↑50%
33	LAUNDRY	0	0	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	1	↑0%
35	DRIVER	2	1	↓-100%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	3	4	↑25%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara Sehat dan dapur,poli

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 - 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 - 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

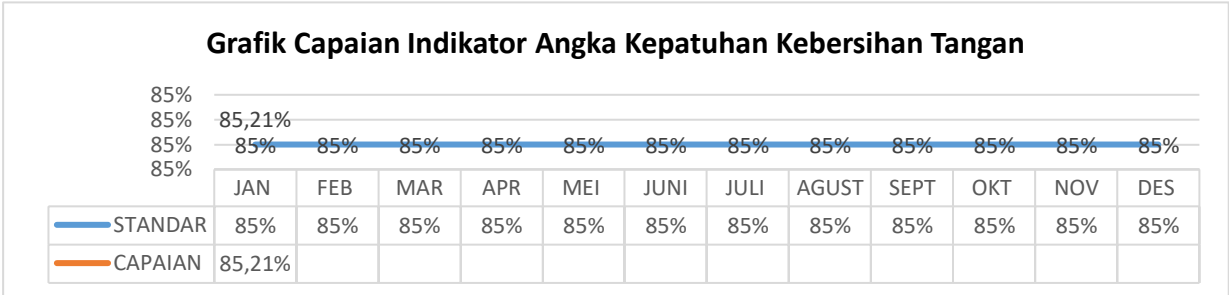
3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu
3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	JAN '25	FEB '25	MAR '25	APR '25	MEI '25	JUN '25	JULI '25	AGUS T '25	SEPT '25	OKT '25	NOV '25	DES '25	RATA-RATA
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21 %												
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01 %												
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55 %												
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%												
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16 %												
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%												
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9 %												
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9 %												
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%												
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%												
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75 %												
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%												
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81 %												

3.6.1.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

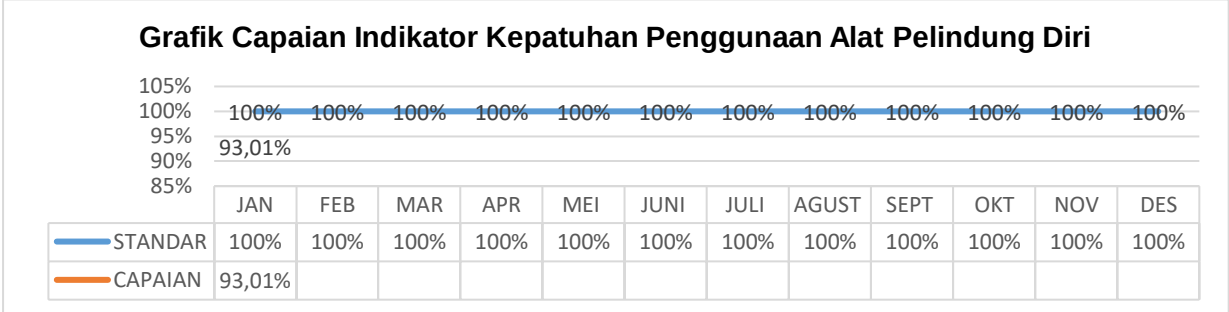


Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu diatas 85,21%, meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu diatas 85,21%, meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

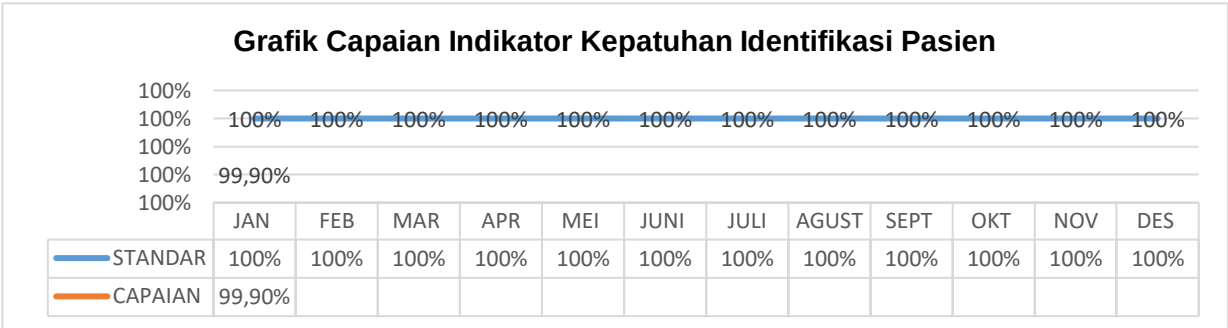


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

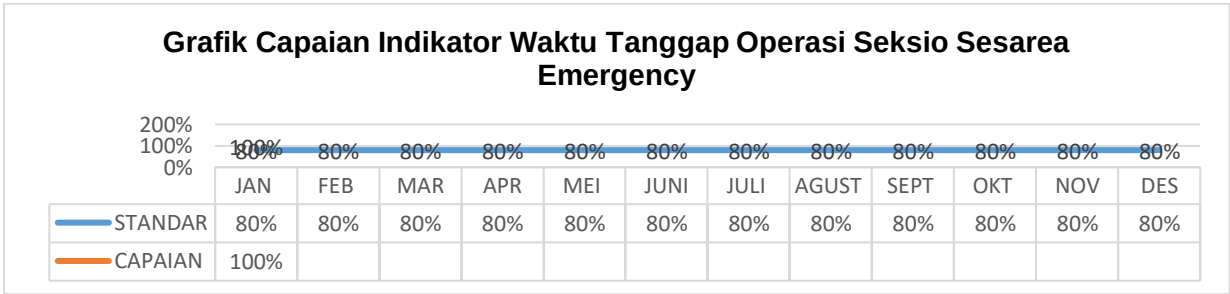


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,90%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

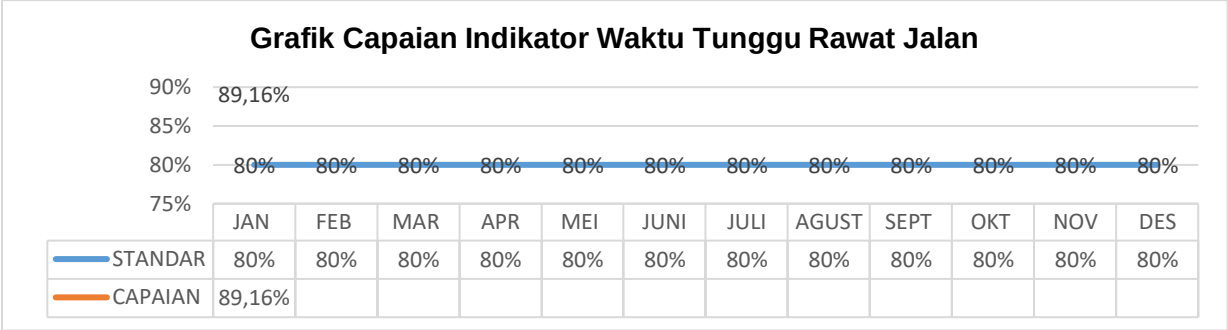
3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

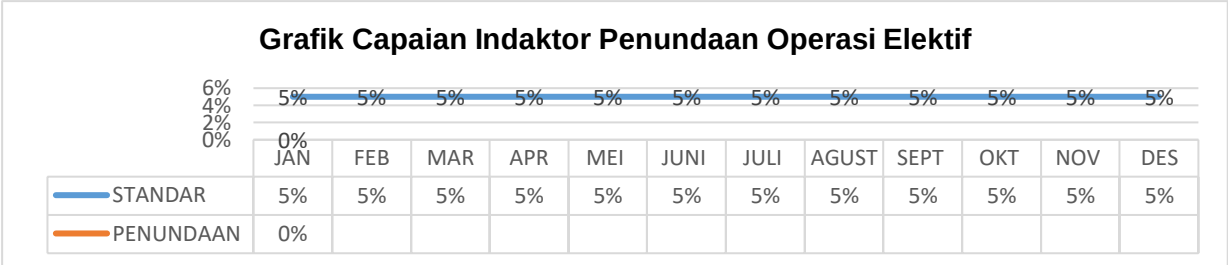
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian di bulan ini yaitu 89,16%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

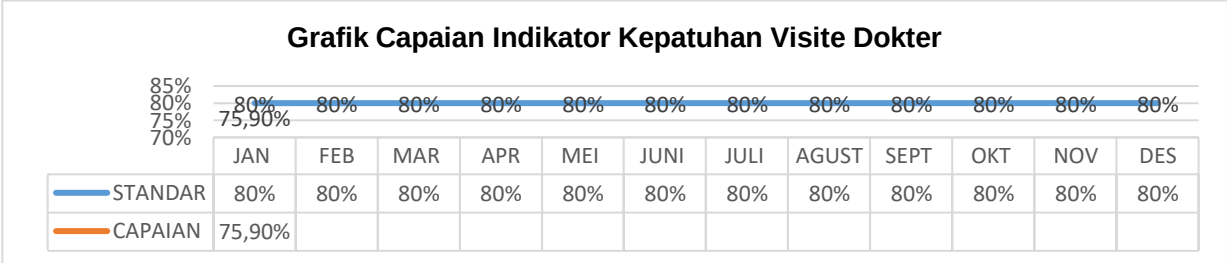
3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

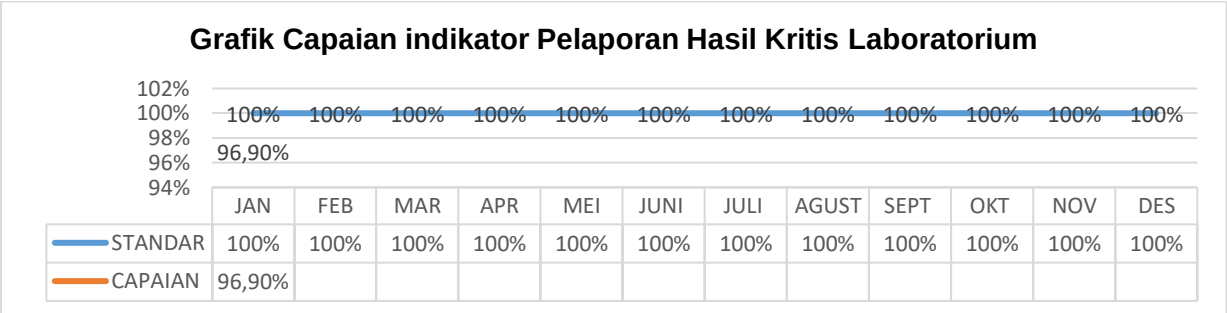


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%. Dari hasil supervisi didapatkan.nnya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena sebagian besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



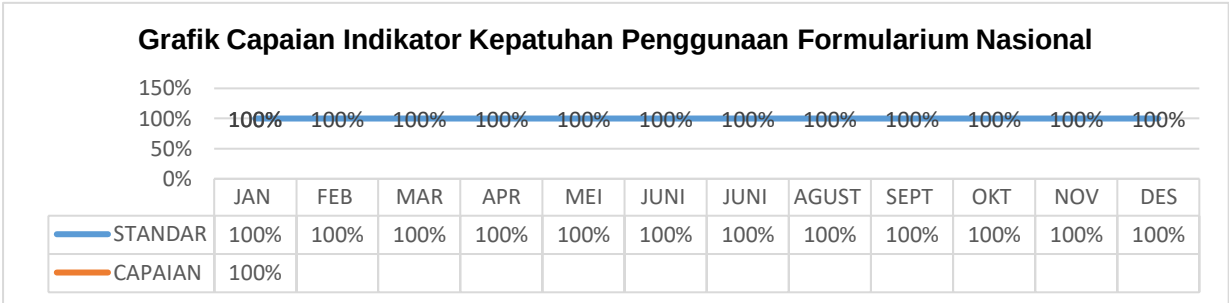
Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

			laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.5 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

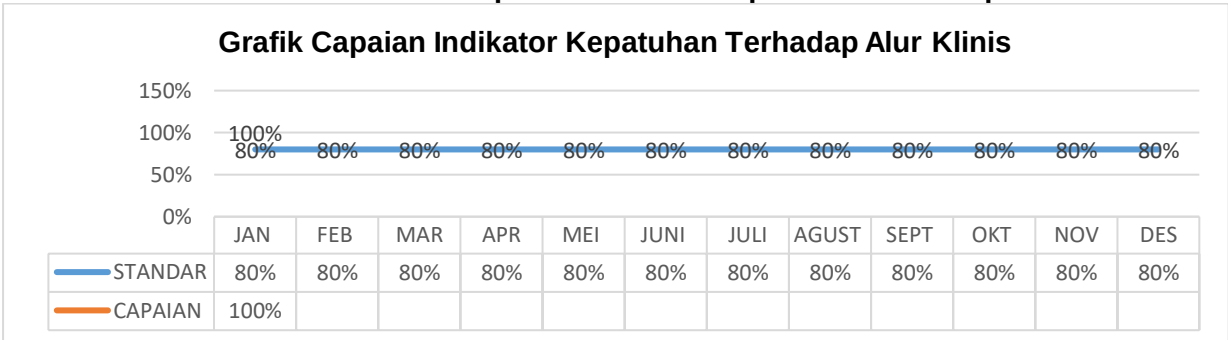
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.6 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

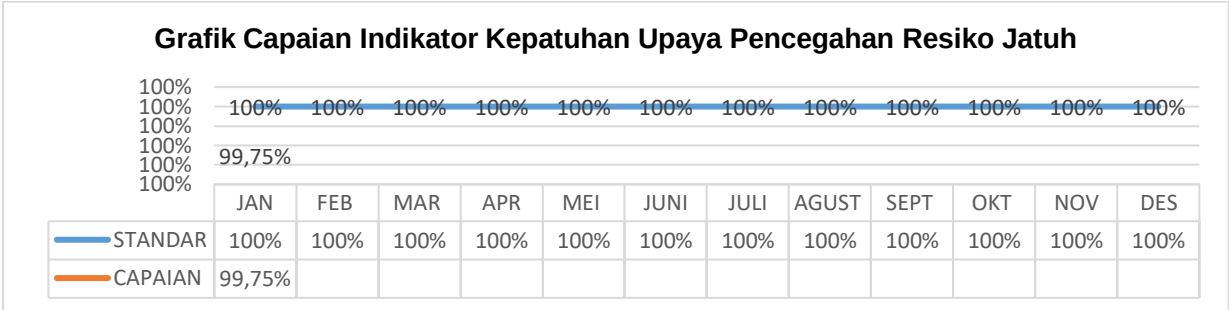
Daftar Clinical Pathway Bulan Januari 2025

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			

HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea			
Partus Normal			
Jumlah			

3.6.1.1.7 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

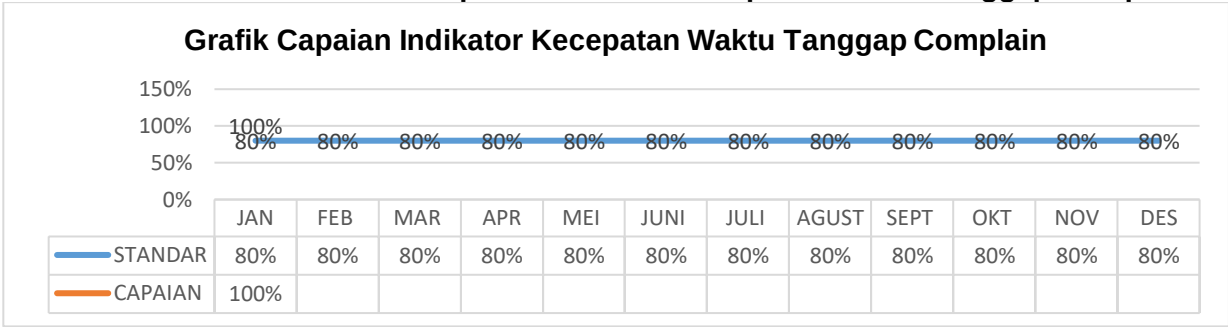


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 99,75%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Tahun

3.6.1.1.8 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

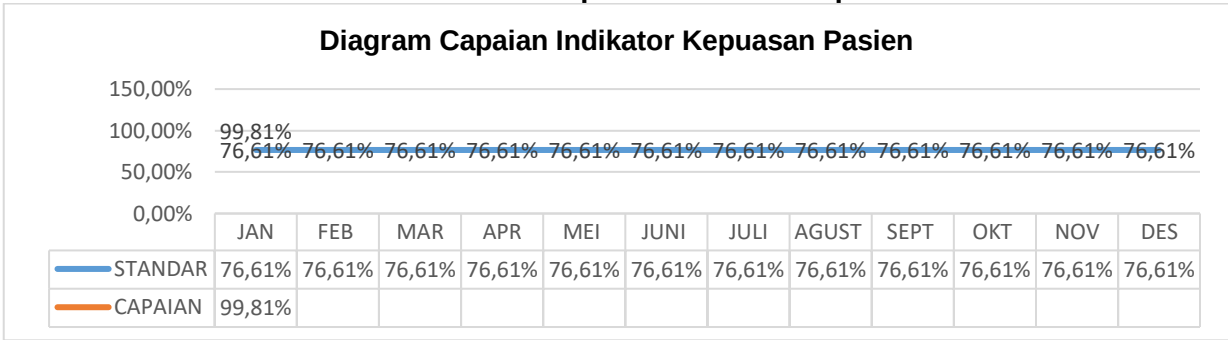
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap komplain bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.9 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 99,81%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

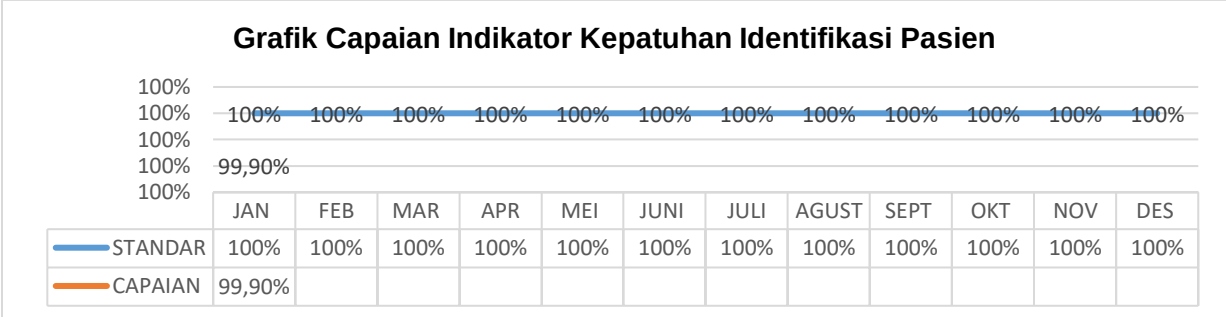
3.6.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.6.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO.	JUDUL	STAND	JAN '25	FEB '25	MAR '25	APR '25	MEI '25	JUN '25	JUL '25	AGT '25	SEPT '25	OKT '25	NOV '25	DES '25	RATA-RATA
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%												
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0												
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0												
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,21%												
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	99,75%												

3.6.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

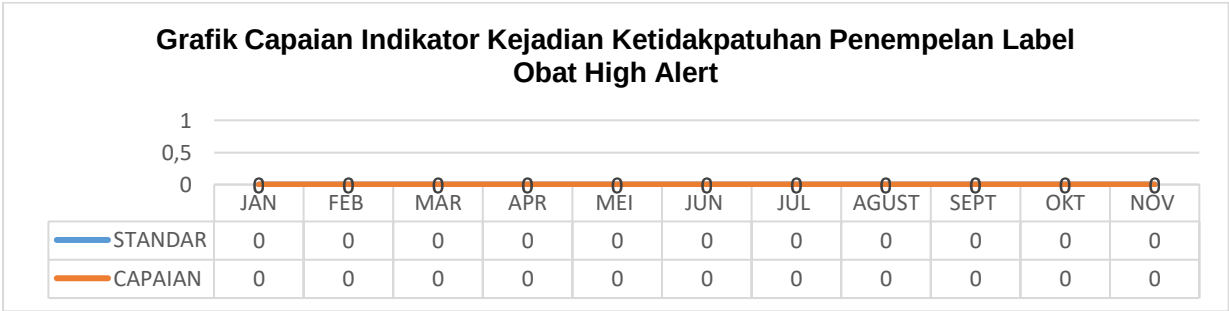


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,90%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

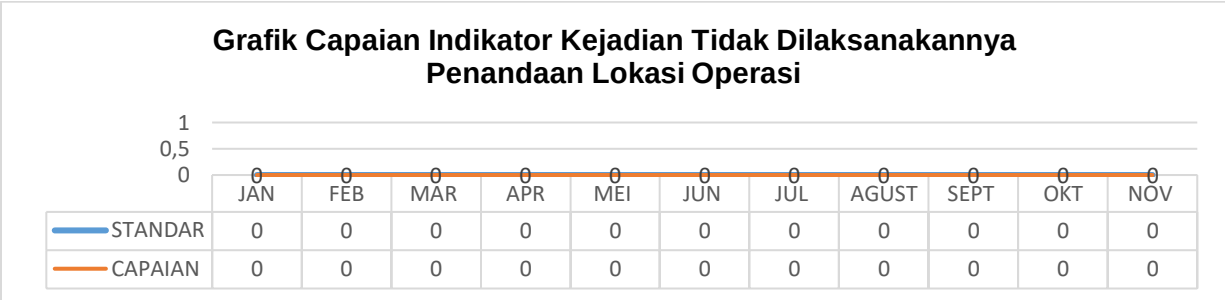
3.6.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



Dari grafik indikator kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh perawat instalasi rawat inap dan juga petugas farmasi yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert . Hasil tersebut sesuai dengan hasil supervisi pada unit rawat inap, di semua unit rawat inap tidak ditemukan obat obat haigh alert yang tidak berlabel. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

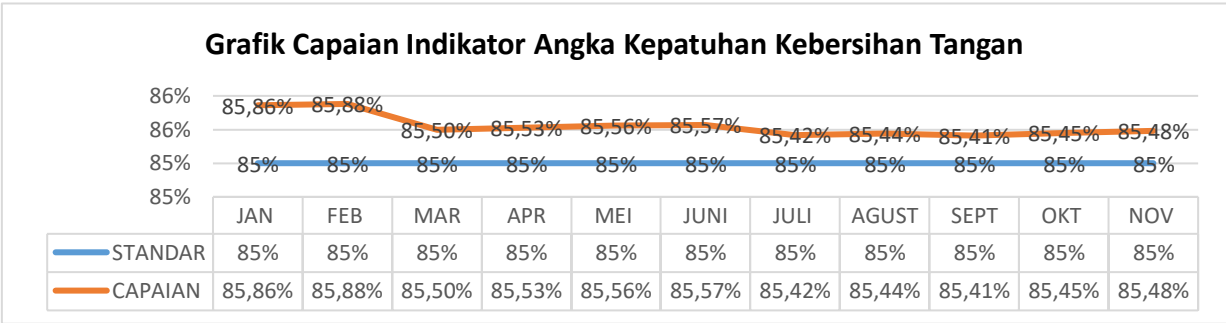
3.6.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi



Dari grafik indikator kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh perawat instalasi rawat inap dan juga petugas instalasi kamar operasi yang telah bersinergi untuk selalu melakukan penandaan lokasi operasi dengan baik. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



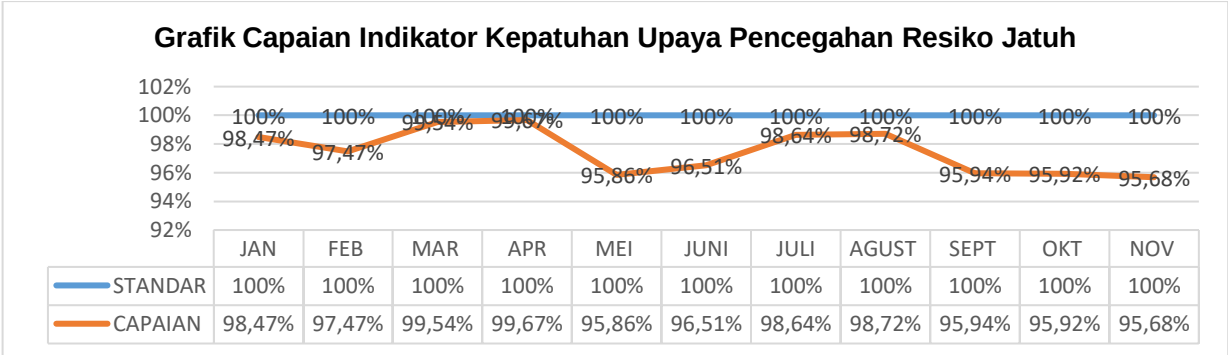
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu diatas 85,21%, meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan.\ 2. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 3. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 4. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,48%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (84,34%) dan nakes lain (84,62%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (74%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena persepsi yang salah dan kurangnya kesadaran petugas terkait pentingnya kebersihan tangan seperti pada profesi dokter yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) namun juga melakukan cuci tangan dengan handrub yang tidak efektif jika masih memakai handscoon.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.2.1.5Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

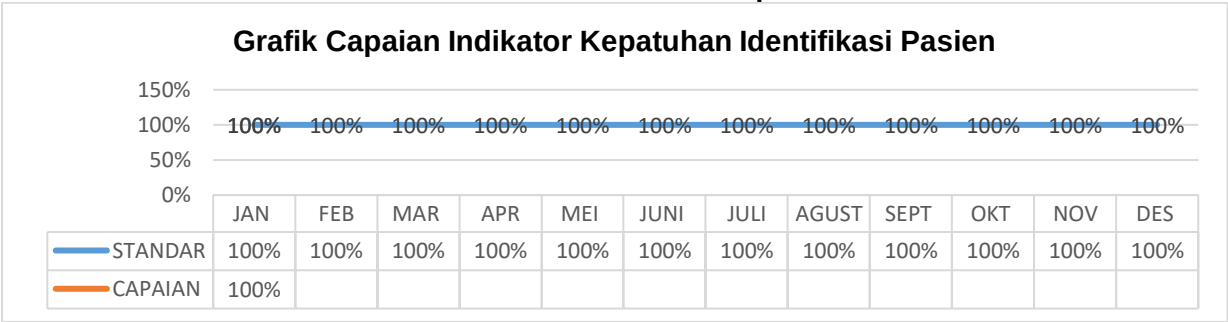
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 99,75%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Tahun

3.6.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	JAN '25	FEB '25	MAR '25	APR '25	MEI '25	JUN '25	JUL '25	AGUS T '25	SEPT '25	OKT '25	NOV '25	DES '25	RATA-RATA
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2.	Angka Tidak Terpasangny a Gelang Identitas Pasien IGD >30 Menit	0%	0%												

	Setelah Pasien Terdaftar Rawat Inap													
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%											
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	4,6%											
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥80%	100%											

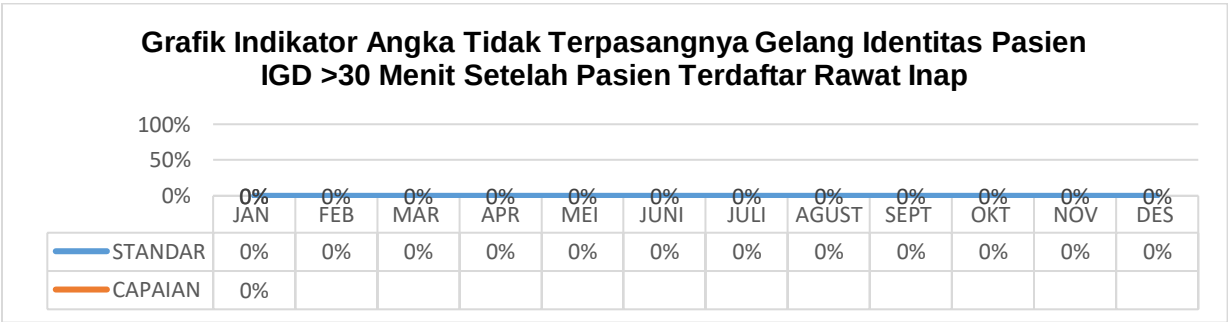
3.6.1.2.2.1 Kepatuhan identifikasi Pasien
3.6.1.2.2.1.1 Grafik Analisa Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari tahun 2025 di IGD diketahui capaian telah mencapai standart, ini terjadi berkat kedisiplinan seluruh petugas IGD yang melaksanakan kepatuhan identifikasi pasien dengan benar. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.2.2.2 Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD >30 Menit Setelah Pasien Terdaftar Rawat Inap

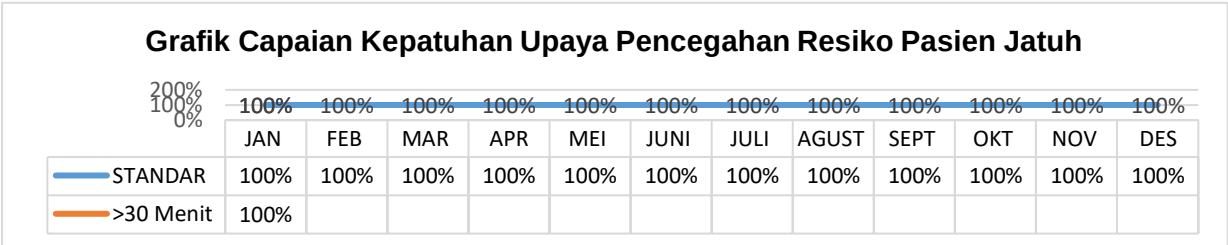
3.6.1.2.2.2.1 Grafik Indikator Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD >30 Menit Setelah Pasien Terdaftar Rawat Inap



Berdasarkan grafik capaian indikator angka tidak terpasangnya gelang identitas pasien IGD >30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap pada bulan Januari tahun 2025 capaian telah mencapai standart, ini terjadi berkat kedisiplinan petugas pendaftaran dan petugas IGD yang telah bersinergi dan berkoordinasi dengan baik sehingga gelang identitas pasien dapat dicetak segera setelah pasien dinyatakan untuk rawat inap dan gelang segera dipasangkan oleh perawat. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.2.2.3 Angka Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Patuh

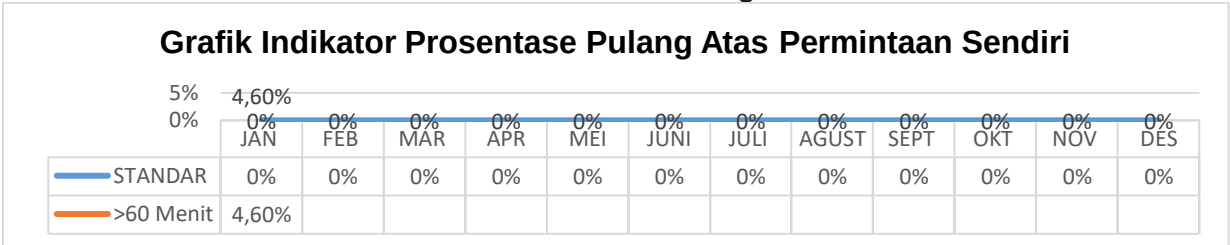
3.6.1.2.2.3.1 Grafik Capaian Indiaktor Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Patuh



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh dapat diketahui bahwa capaian telah mencapai standart 100%. Hal ini karena petugas IGD telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga dengan baik. Tanda resiko jatuh juga telah terpasang pada tempat tidur dan gelang pasien. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.2.2.4 Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri

3.6.1.2.2.4.1 Grafik Indikator Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri



Berdasarkan grafik capaian indikator prosentase pulang atas permintaan sendiri pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk mengurangi prosentasi pulang atas permintaan sendiri hingga mencapai standart 0%.				
DO	Melakukan koordinasi dengan bagian humas dan marketing terkait pendaftaran BPJS serta sosiali terkait manfaat dan prosedur BPJS.				
STUDY	Berdasarkan grafik capaian indikator prosentase pulang atas permintaan sendiri pada bulan Januari Tahun 2025 capaian belum mencapai standart karena pasien tidak memiliki BPJS dan keberatan jika harus dirawat dengan biaya pribadi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA
Mengurangi prosentase pulang atas permintaan sendiri	Mengurangi prosentase pulang atas permintaan sendiri	Indikator mutu prisentase pulang atas permintaan sendiri bisa mencapai standart 0%.	Melakukan koordinasi dengan bagian humas dan marketing terkait pendaftaran BPJS serta sosiali terkait manfaat dan prosedur BPJS.		1. Kepala Ruang IGD 2. Humas dan Marketing
				WAKTU	
				Satu Bulan	

PASIEN PULANG ATAS PERMINTAAN SENDIRI IGD BULAN JANUARI TAHUN 2025

01/01/2025	1	DANI TOBIAS ADITYA	L	19 THN	224858	UMUM	CKR 456	EKONOMI
02/01/2025	2	ALI MUSTOFA	L	43 THN	224935	UMUM	CHEST PAIN	EKONOMI
02/01/2025	3	SUNARMi	P	64 THN	109487	BPJS	NSTEMI	ALASAN PRIBADI
03/01/2025	4	SITI MUKHAYANA	P	55 THN	222081	BPJS	DM TYPE 2	ALASAN PRIBADI
03/01/2025	5	RABBANI DHARMA TRI PAMUNGKAS	L	12 THN	224992	UMUM	OPEN WOUND PEDIS	EKONOMI
03/01/2025	6	ARVIN ANDRIAWAN	L	37 THN	224945	UMUM	CKR 456	EKONOMI
04/01/2025	7	ARIFIN	L			UMUM	INJURY	EKONOMI
04/01/2025	8	KHOIRUL UMAM	L	29 THN	225028	UMUM	INJURY	LAIN - LAIN

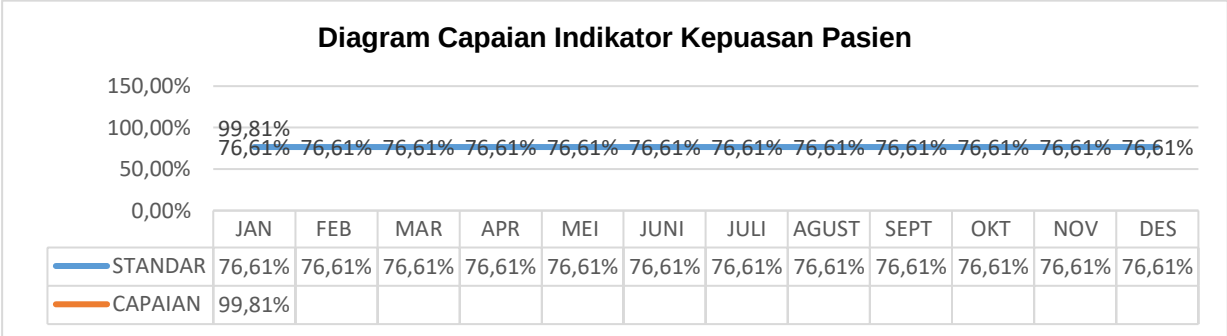
05/01/2025	9	FARADILLAH	P	29 THN	225047	UMUM	GASTRIIS	LAIN - LAIN
06/01/2025	10	SOFIA YAKSEL C B	P	27 THN	225071	UMUM	GASTRIIS	ALASAN PRIBADI
06/01/2025	11	AHMAD MUZAKKY IMAM MAHDI	L	7 THN	117199	BPJS	DF	ALASAN PRIBADI
06/01/2025	12	SLAMET	L	40 THN	225124	UMUM	OPEN WOUND	EKONOMI
13/01/2025	13	CANDRA EKO NURHIDAYAT	L	35 THN	179698	UMUM	GERD	ALASAN PRIBADI
15/01/2025	14	SONI CHRISYUWONO	L	33 THN	202598	JKK	CF TALUS SIN	ALASAN PRIBADI
17/01/2025	15	VIOLA BELVANIA KUSUMA	P	1 THN	198862	UMUM	TF	ALASAN PRIBADI
18/01/2025	16	ISWATI	P	54 THN	192583	UMUM	NECROTIZING ASCITIS + DM HIPERGLIKEMIA	EKONOMI
18/01/2025	17	ALI AHDAL	L	13 THN	225802	UMUM	FEBRIS	EKONOMI
19/01/2025	18	CHUSNUL CH	P	57 THN	105382	UMUM	HEMORROID	EKONOMI
19/01/2025	19	NANANG LULUS ANDIKA	L	33 THN	225834	UMUM	TRAUMA OCULI SIN	EKONOMI
20/01/2025	20	HJ SUWARTININGSIH	P	65 THN	225924	UMUM	FEBRIS	EKONOMI
22/01/2025	21	SUKARNI	P	72 THN	226032	UMUM	CKR 456	EKONOMI
23/01/2025	22	NGATEMIN	L	80 THN	225990	UMUM	PNEUMONIA	EKONOMI
23/01/2025	23	MAYA AMANDA AZAHRO	P	18 THN	226099	UMUM	SPRAIN GENUE SINISTRA	EKONOMI
23/01/2025	24	M. HUFRON	L	54 THN	211007	UMUM	CVA INFARK	ALTERNATIF
23/01/2025	25	MULYONO	L	65 THN	225894	BPJS	CVA INFARK	ALASAN PRIBADI
23/01/2025	26	KASRIN	L	46 THN	226054	UMUM	COR 456	EKONOMI
23/01/2025	27	WARLI'AH	P	77 THN	226082	UMUM	VULNUSS APPERTUM OXCIPITAL	EKONOMI
24/01/2025	28	BUSTAN	L	78 THN	226153	UMUM	ADHF	EKONOMI
25/01/2025	29	MUHAMMAD DAFIAN SYAIFUDDIN	L	12 THN	226198	UMUM	VULNUSS APPERTUM DIGITI 2 PEDIS SINISTRA	EKONOMI
25/01/2025	30	ONTEN AGUS SUSANDA	L	38 THN	226163	UMUM	VULNUSS PUNCTUM REGIO WRIST SINISTRA	EKONOMI
26/01/2025	31	NICKY ACHMAD AFIFUDDIN	L	12 THN	226225	UMUM	TF	EKONOMI
26/01/2025	32	AULIA ZURAFa RISQIANA	P	3 THN	174168	UMUM	COMBUSTIO GR 2A	EKONOMI
26/01/2025	33	SHIREEN PARAMITA AZZARINE	P	2 THN	190683	UMUM	BP	EKONOMI
26/01/2025	34	ALEA NAJMA MAHARANI	P	9 THN	070218	UMUM	CF RADIUS SINISTRA	EKONOMI
26/01/2025	35	ANDI IRAWAN	L	34 THN	226227	UMUM	TF	ALASAN PRIBADI
27/01/2025	36	ZHRUTU SHITA	P	15 THN	137267	UMUM	CKR 456	EKONOMI
28/01/2025	37	THERESIA JUWITA SARI	P	22 THN	221099	UMUM	HF	EKONOMI
30/01/2025	38	RUKIYAH	P	66 THN	226362	UMUM	VOMITING	ALASAN PRIBADI

3.6.1.2.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	JAN '25	FEB '25	MAR '25	APR '25	MEI '25	JUN '25	JUL I '25	AGT '25	SEPT '25	OKT '25	NOV '25	DES '25	RATA-RATA
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%												

3.6.1.2.3.1 Kepuasan Pasien

3.6.1.2.3.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



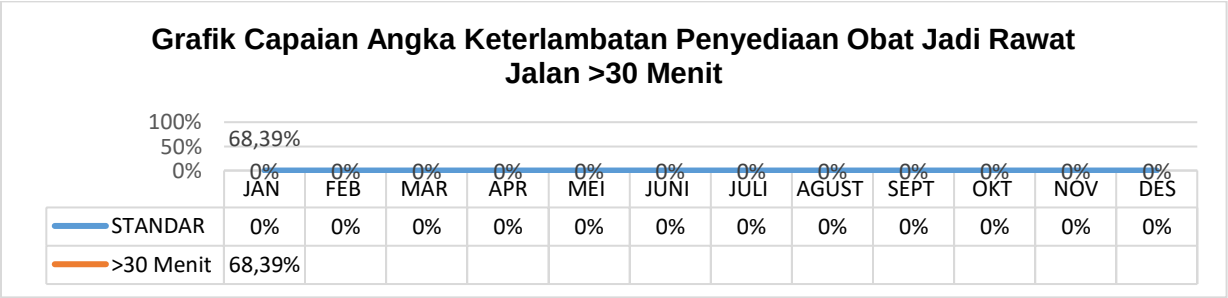
Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 99,81%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.2.4 Perbaikan Sistem

NO	JUDUL	STAND	JAN '25	FEB '25	MAR '25	APR '25	MEI '25	JUN '25	JUL '25	AGT '25	SEP T '25	OKT '25	NOV '25	DES '25	RATA - RATA
1.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,39 %												
2.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,22 %												

3.6.1.2.4.1 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

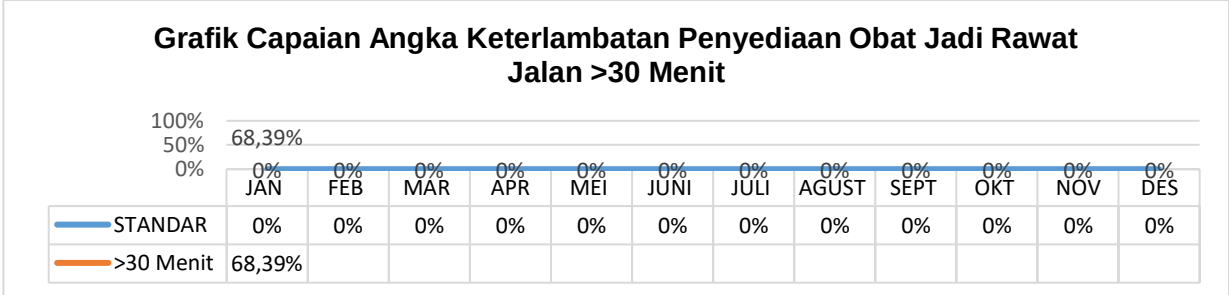
3.6.1.2.4.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena petugas farmasi seringkali melakukan klik selese obat tdak realtime ketika obat selesai atau klik obat selesai dilkaukan ketika 5 atau 10 resep selesai dikerjakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai 4. Meningkatkan promosi layanan pengantaran obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.4.2 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

3.6.1.2.4.2.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



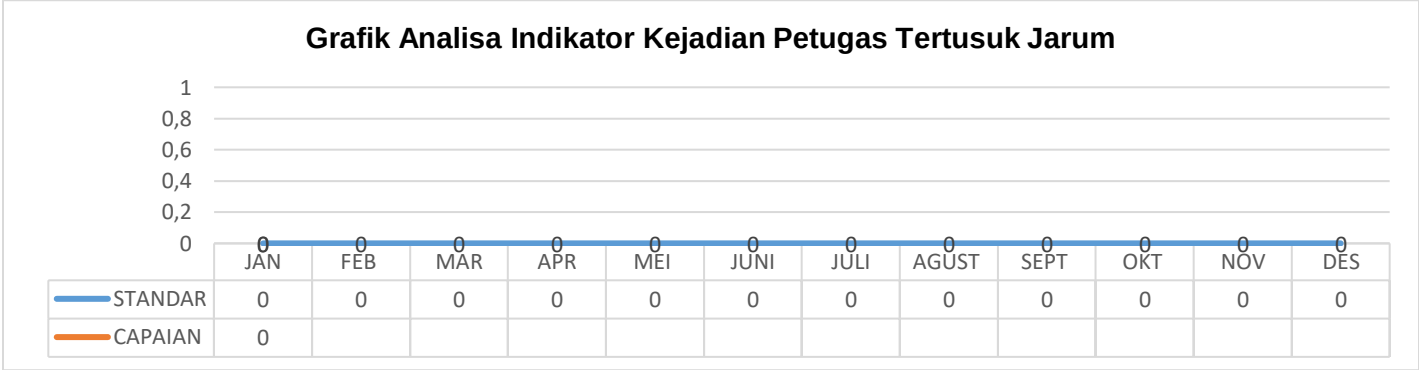
PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena petugas farmasi seringkali melakukan klik selese obat tdak realtime ketika obat selesai atau klik obat selesai dilkaukan ketika 5 atau 10 resep selesai dikerjakan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. 2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervisi terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervisi terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Berdasarkan grafik analisa indikator kejadian petugas tertusuk jarum pada bulan Januari tahun 2025 telah mencapai standart atau tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum pajanan. Tetapi masih ditemukan laporan dari petugas CS, bahwa petugas CS hampir saja terkena jarum karena jarum berada disampah infeksius.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	1. Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien. 2. Supervisi petugas terkait pembuangan jarum bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.5 Manajemen Resiko

NO	JUDUL	STAND	JAN '25	FEB '25	MAR '25	APR '25	MEI '25	JUN '25	JUL '25	AGUS T '25	SEPT '25	OKT '25	NOV '25	DES '25	RATA-RATA
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0												

3.6.1.2.5.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum (Pajanan)
 3.6.1.2.5.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum (Pajanan)



Berdasarkan grafik analisa indikator kejadian petugas tertusuk jarum pada bulan Januari tahun 2025 telah mencapai standart atau tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum pajanan. Tetapi masih ditemukan laporan dari petugas CS, bahwa petugas CS hampir saja terkena jarum karena jarum berada disampah infeksius. Untuk itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

3.6.1.2.6 Mutu Unit

3.6.1.2.6.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD >30 Menit Setelah Pasien Terdaftar Rawat Inap	0%	0%												
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%												
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	4,6%												
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%												

3.6.1.2.6.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%													
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%													
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%													
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%													
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%													
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis	100%													

7	Kelengkapan Pengisian EWS	100%													
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%													

3.6.1.2.6.3 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	90,6%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	97,14%												
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%												
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis	100%	93,96%												
7	Kelengkapan Pengisian EWS	100%	100%												
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%	100%												

3.6.1.2.6.4 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												

2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	88,98%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	0%												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	99,02%												
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%												
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis	100%	90,15%												
7	Kelengkapan Pengisian EWS	100%	100%												
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%	100%												

3.6.1.2.6.5 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,4%												
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	68,97%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	0%												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	99,13%												
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%												
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%												

7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%											
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%	100%											

3.6.1.2.6.6 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	0%												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%												
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%												
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis	100%	100%												
7	Kelengkapan Pengisian EWS	100%	100%												
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%	100%												

3.6.1.2.6.7 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												

2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	81,25%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%												
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%												
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis	100%	98,4%												
7	Kelengkapan Pengisian EWS	100%	100%												
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%	100%												

3.6.1.2.6.8 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	82,14%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%												
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,46% (1 px)												

6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis	100%	100%											
7	Kelengkapan Pengisian EWS	100%	100%											
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%	100%											

3.6.1.2.6.9 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80,36%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥80%	0%												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%												
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%												
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis	100%	100%												
7	Kelengkapan Pengisian EWS	100%	100%												
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%	100%												

3.6.1.2.6. 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												

2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80,39%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%												
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	2,3% (3 px)												
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis	100%	100%												
7	Kelengkapan Pengisian EWS	100%	100%												
8.	Kelengkapan Form Edukasi Terintegrasi	100%	100%												

3.6.1.2.6.11 ICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	99,12%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	97,22%												
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%												
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%												

7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%												
---	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.12. HCU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%												
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-												
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%												
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-												
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%												
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%												

3.6.1.2.6.13 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%												
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	89,16%												
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	78,92%												
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%												

3.6.1.2.6.14 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%												
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%												
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%												
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%												
6	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%												
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0												
8	Angka kematian ibu	0%	0												
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0												
10	Kejadian partus macet	0	0												
11	Kejadian eklamsi	0	1												
12	Kejadian pre eklamsi	0	5												
13	Kejadian infeksi nifas	0	0												
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	5,8%												
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%												
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%												
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108												

18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0												
----	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.15 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%												
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	0												
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%												
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,11%												
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0												
6	Angka Kematian Bayi	0%	7												
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0												

3.6.1.2.6.16 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%												100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%												0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%												
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0												
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0												

6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0												
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0												
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	00												
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0												
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0												
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0												
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0												
13	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi	0	0												
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%												

3.6.1.2.6.17 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%												
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%												
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	9												
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0												
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%												

3.6.1.2.6.18 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%												
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%												
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0												

3.6.1.2.6.19 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%												
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0												
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0												
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0												

3.6.1.2.6.20 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%												
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%												
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0												
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0												
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,39%												

6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,22%												
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0												
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0												
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0												
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0												
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0												
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0												
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0												

3.6.1.2.6.21 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%												0,15%

3.6.1.2.6.22 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%												
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰												
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 %	0‰												
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 %	0‰												
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%												
6.	Angka Decubitus	0%	0%												
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%												
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%												

9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%												
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0												

3.6.1.2.6.23 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%												
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%												
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%												
4	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%												
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12												
6	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%												

3.6.1.2.6.24 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0												
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%												
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%												

3.6.1.2.6.25 Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0,14%												

2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	91,86%												
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik	0	0												
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS	100%	100%												
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%												

3.6.1.2.6.26 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%												
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0												

3.6.1.2.6.27 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%												
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%												
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%												
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1												

3.6.1.2.6.28 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%												

3.6.1.2.6.29 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7												
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10												

3.6.1.2.6.30 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%												
2	Kejadian komplain Kebersihan Kamar Mandi	0%	0												

3.6.1.2.6.32 KESEKRETARIATAN

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%												
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%												
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%												

3.6.1.2.6.33 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%												

2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0												
3.	Kejadian Tercampur Benda Asings	0	0												

3.6.1.2.6.34 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0												
2	Kejadian instrument kurang	0	0												

3.6.1.2.6.35 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%												
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%												

3.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0												
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%												
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%												

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%												

3.6.1.2.6.38 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%												

3.6.1.2.6.39 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%												
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%												

3.6.1.2.6.40 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Pengontrolan Area Rumah Sakit	100%	100%												
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0												

3.6.2 Komite PPI

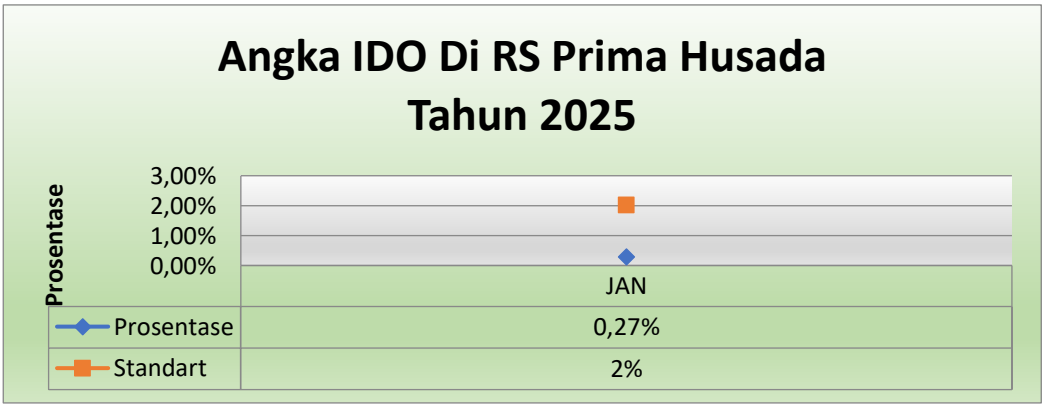
3.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	65	0%
Seksio Sesaria	0	71	0%
Apendiktomi	0	10	0%
Herniotomi	0	12	0%
Katarak	0	35	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	17	0%
Semua Operasi	1	367	0,27%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 1 orang pasien yang menjalani operasi Kistectomy. Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien berusia 26 tahun. Saat kontrol hari 1, ditemukan kondisi jahitan luka terbuka. Pasien belum sempat melakukan perawatan luka sebelumnya. Dari hasil jaringan yang diperiksakan PA, ditemukan hasil Tubo Ovarial Abses (sedang dalam kondisi infeksi). Pasien operasi bersamaan dengan 2 pasien lainnya, namun pasien ini pengguna ruang OK 3 pertama kali untuk hari itu.				
Masalah saat ini	1. Pasien dengan kondisi terdapat penyakit infeksi penyerta sebelumnya, perlu dilakukan edukasi lebih lanjut terkait perawatan lukanya dan perilaku hidup bersihnya.				
Permasalahan sebelumnya	2. Pasien dengan kondisi klinis khusus, perlu mendapatkan perhatian lebih terutama pasien post SC anak 1 dengan usia yang masih terlalu muda, edukasi pada proses perawatan ibu sendiri dan bayinya saat dirumah sangat penting, karena dapat berpengaruh pada proses penyembuhan luka.				
Tindakan yang dilakukan	3. Melakukan evaluasi proses edukasi pada pasien post operasi dengan memastikan pemahaman dari pasien/keluarganya, terutama terkait perawatan saat di rumah dan lebih menekankan pada keluarga yang tinggal serumah dan yang membantu kebutuhan ADL ibu dan bayi. 4. Memberikan edukasi tambahan pada pasien yang terjadi IDO, untuk tidak khawatir jika terdapat penyakit penyerta dan konsultasi dengan DPJP untuk mendapatkan terapi yang sesuai untuk membantu mempercepat pemulihan. 5. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai di ruang perawatan pasien. 6. Melakukan monitoring perawatan luka pasien setelah dilakukan rehecting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

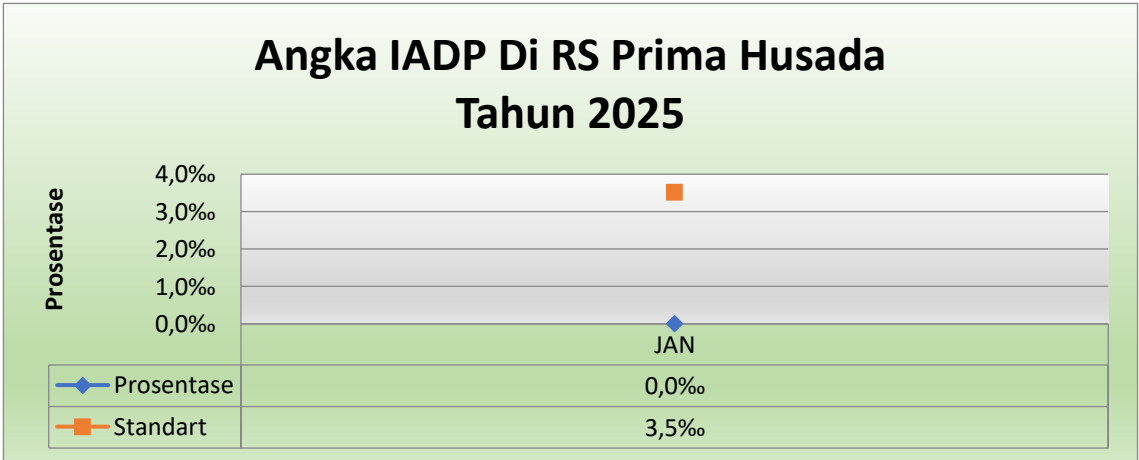
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien di rumah	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama pada ibu muda yang baru memiliki anak.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/PCPN	Satu bulan
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	4. Pasien operasi	5. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 6. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptik/sabun untuk mengurangi risiko infeksi. 7. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik)	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAI's Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	60	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.2.2 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



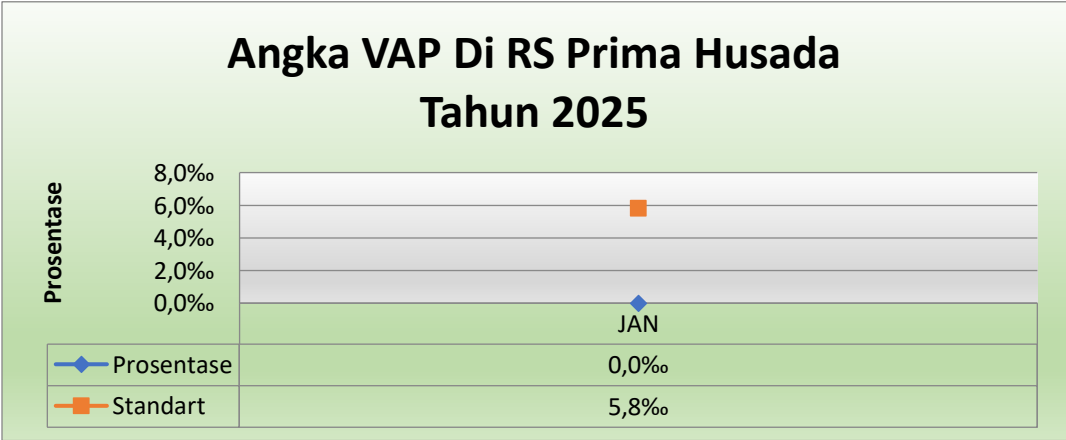
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 60 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	103	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



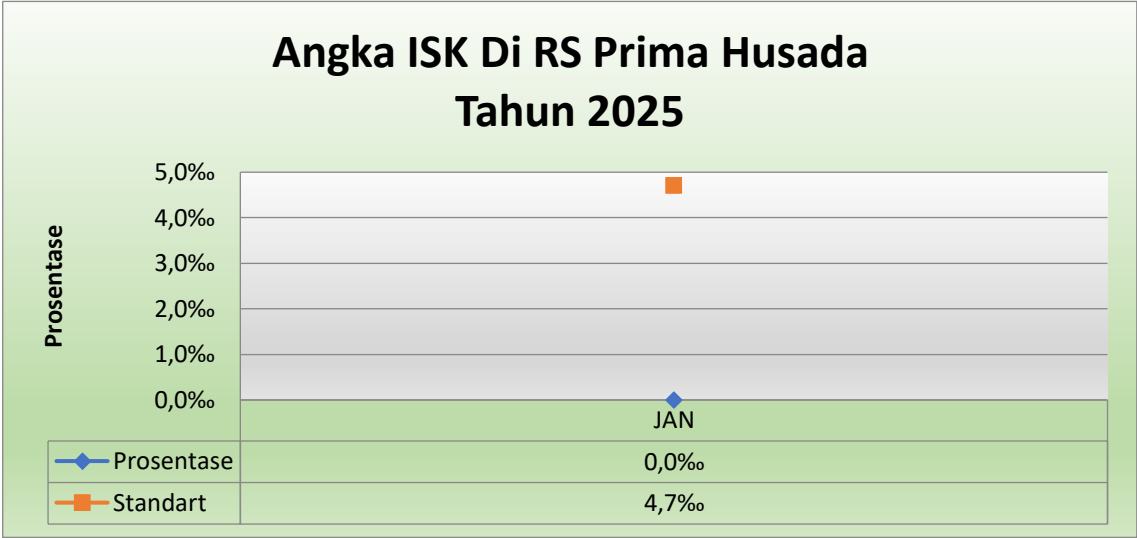
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 103 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.4 ISK

3.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR ((Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	257	0‰
HCU	0	33	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

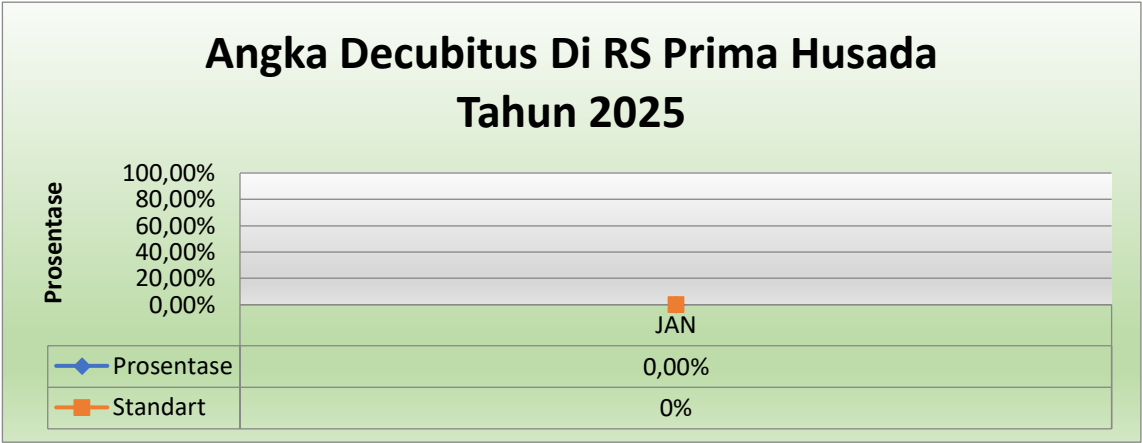
3.6.1.1.4.2 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1148 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.5 Decubitus

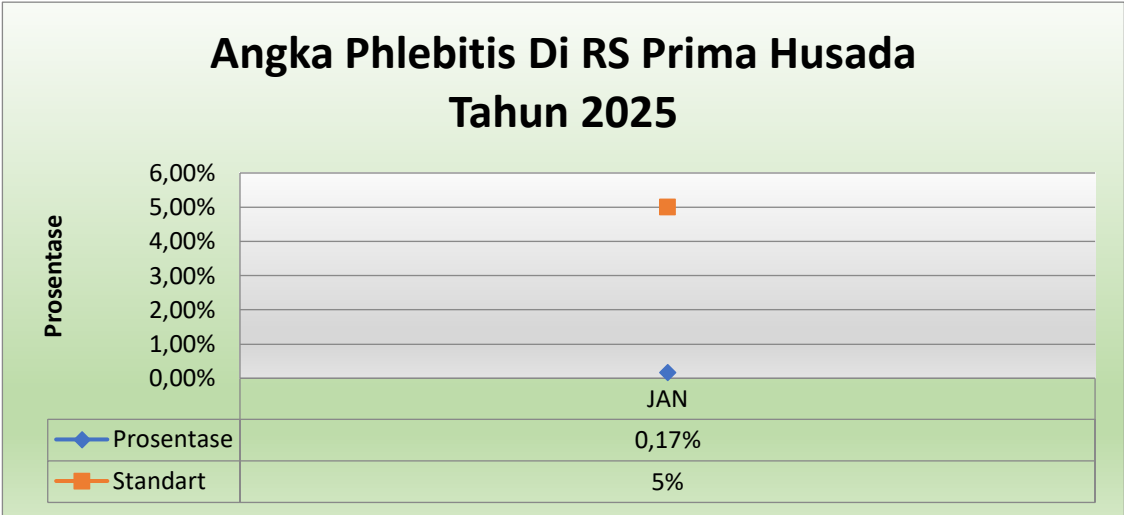
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 15 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

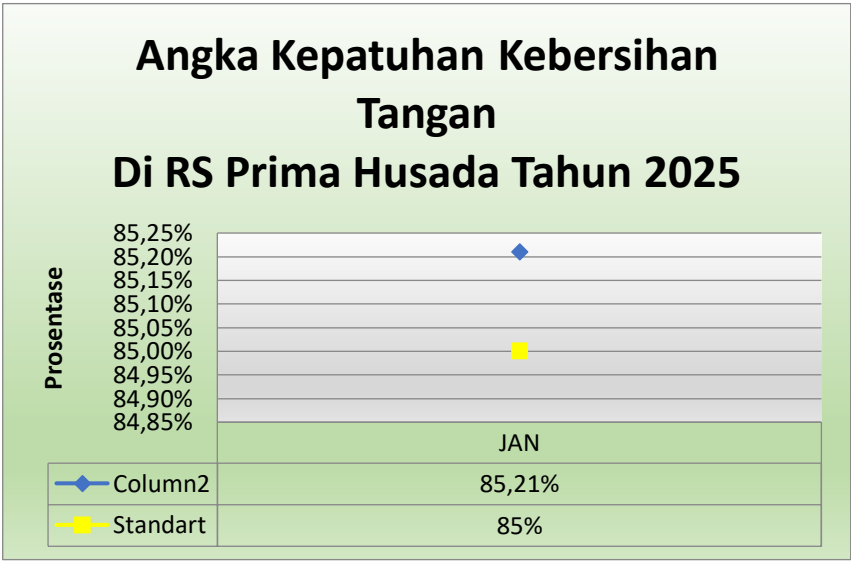


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2870 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,21%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 6 pasien yang mengalami phlebitis, 1 diantaranya karena mendapat cairan pekat KCL dengan kondisi hipokalemi, 2 lainnya mendapatkan terapi anastesi post tindakan operasi, dan 3 lainnya hanya mendapatkan terapi antibiotic dan anti nyeri biasa. 5 Pasien berada pada stadium 1 (tanda awal gejala phlebitis dan 1 pasien pada stadium 2 phlebitis (stadium dini phlebitis). Dari 5 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, meskipun sediaannya sudah berupa cairan infus 500 ml, namun karena pemberiannya rutin untuk menaikkan kadar elektrolit s.d normal. 2. Faktor teknik penyuntikan obat petugas juga berpengaruh terhadap resiko kejadian phlebitis.				
Permasalahan sebelumnya	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, meskipun sediaannya sudah berupa cairan infus 500 ml, namun karena pemberiannya rutin untuk menaikkan kadar elektrolit s.d normal.				
Tindakan yang dilakukan	1. Menganjurkan perawat untuk memilih iv canula yang sesuai dengan kebutuhan pasien (lihat besarnya pembuluh darah & rencana pengobatan yang akan diberikan, usahakan menggunakan iv canula ukuran besar). 2. Mengajarkan perawat saat memberikan obat injeksi dengan melancarkan aliran infus dan mengusap aliran infus pada pasien dengan alkohol swab untuk melancarkan dan mengurangi nyeri dan menyuntikkan secara perlahan. 3. Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat seiap hari setelah melakukan injeksi.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 2. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 3. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 4. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

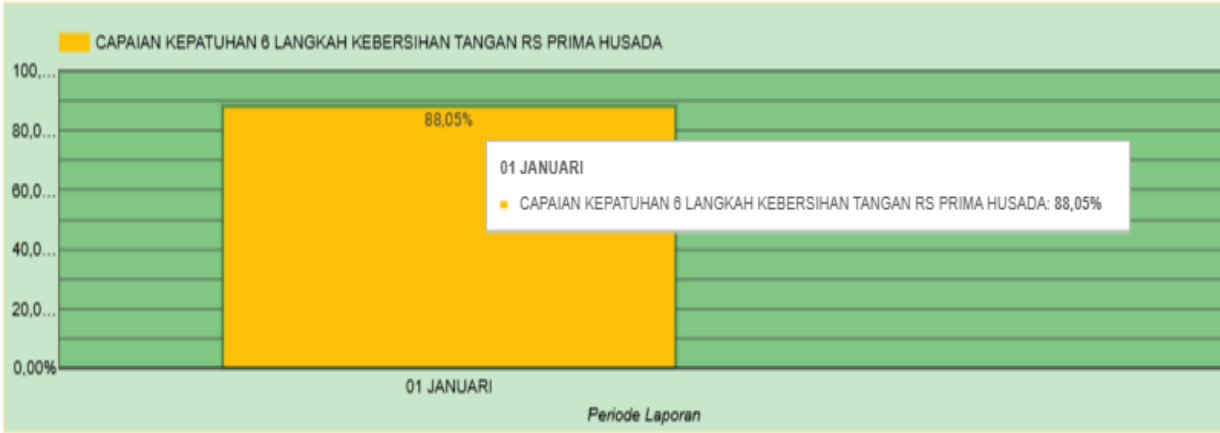
			dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 5. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 6. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 7. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

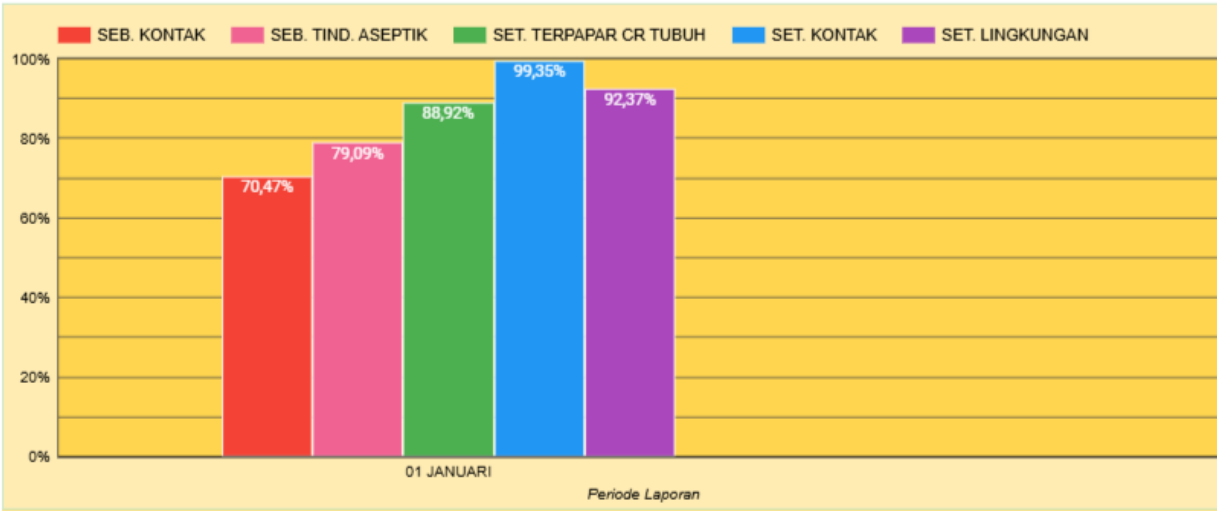
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



3.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



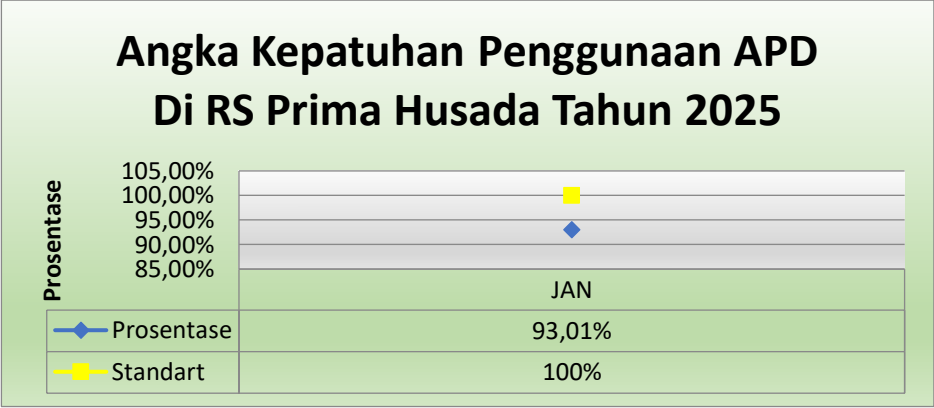
3.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan



Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,21%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (70,47%) dan sebelum melakukan tindakan aseptik (79,09%). Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 88,05% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik. Namun memang karena belum menjadi kebiasaan dari petugas sehingga masih ada yang tidak urut melaksanakan 6 langkah cuci tangannya.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap pentingnya cuci tangan dan persepsi kebersihan tangan yang salah.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

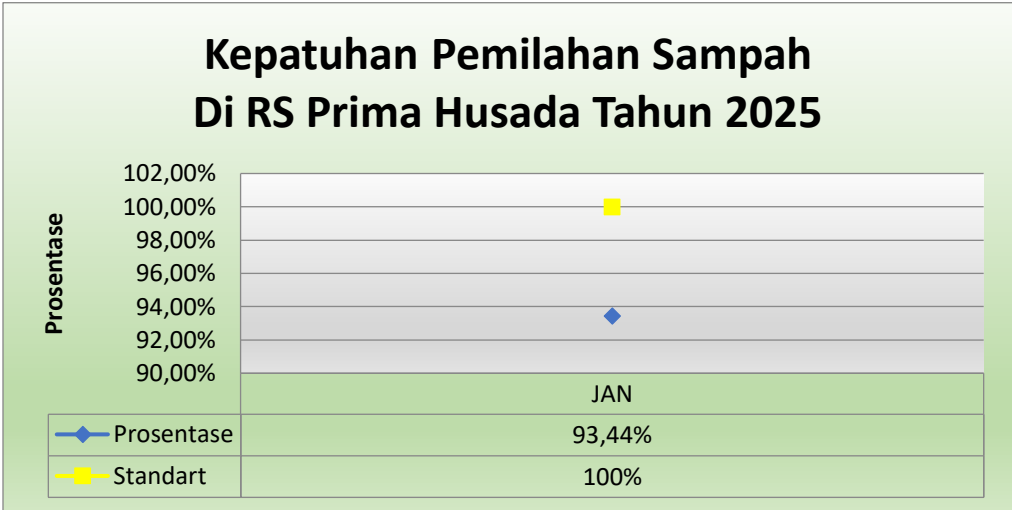
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,01%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi peningkatan kepatuhan pemakaian APD, terutama pada petugas penjamah makanan pada akhir bulan ini dikarenakan setelah mendapatkan resosialisasi terkait hygiene penjamah makanan. Namun, pada petugas cleaning service masih ditemukan petugas yang tidak memakai sarung tangan kerja tetapi memakai handscoon untuk membersihkan ruangan dengan alasan sarung tangan kerjanya berlubang/robek.				
Masalah saat ini	Petugas masih belum bisa membiasakan dengan kebiasaan baru yang benar dan lebih memilih diam-diam menjalankan kebiasaan yang salah.				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 5. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 6. Melarang perawat untuk memberikan handscoon jika ada CS yang meminta untuk membersihkan ruangan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

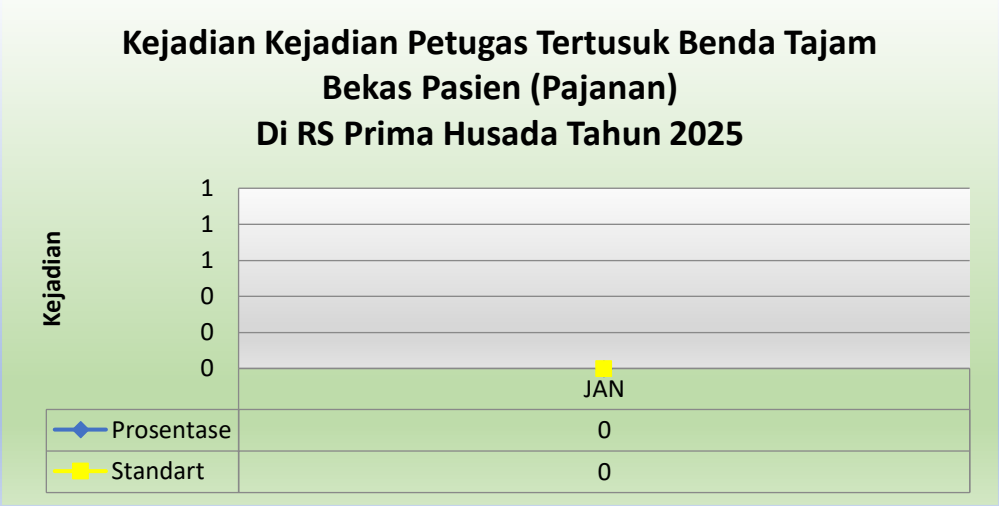
3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,44%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan tindakan seperti pada unit laboratorium yang juga membuang bungkus alcohol swab ke dalam safety box. Selain itu juga di unit perawatan pasien dan IGD juga masih ditemukan bungkus alkes yang ikut dibuang di sampah infeksius.				
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Permasalahan sebelumnya	Kebiasaan malas petugas membuang isi cairan di botol infus saat tidak ada yang mensupervisi dan beranggapan jika sampah plastik bungkus alkohol swab kecil tidak akan menambah berat timbangan sampah.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengajukan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah non infeksius dan infeksius atau bengkok. 2. Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera mengajukan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. 3. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 4. Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. 5. Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 2. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera mengajukan untuk membenarkan bila memungkinkan. 3. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Tidak ditemukan kejadian pajanan.				
Masalah saat ini	Tidak ada kejadian pajanan.				
Permasalahan sebelumnya	Safety box tidak standar, tembus tusukan jarum.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pemilahan sampah khususnya benda tajam pada saat melakukan tindakan. 2. Melakukan monitoring kerapian dan kebersihan troli tindakan untuk segera dibersihkan setelah tindakan dan tidak meninggalkan jarum/benda tajam terbuka di troli tindakan. 3. Melakukan monitoring teknik recapping saat menutup jarum saat menyiapkan obat pasien. 4. Sudah diajukan telaah penggantian safety box, dengan melampirkan kejadian pajanan namun tidak ada penggantian safety box.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	NOV	DES	JAN	%	MANDOK	KETERANGAN
1	IRNA 2C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
2	ICU HCU	8x/Bulan	0%	0%	0%	Menurun	Ada	
3	IRNA 3C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
4	MATERNITAS	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
5	PERINATOLOGI	8x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Ada	

6	IRNA 5C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
7	IRNA 2A,3A,4A	8x/Bulan	75%	75%	100%	Tercapai	Ada	
8	IRNA 6A,7A,8A	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
9	IGD	8x/Bulan	50%	25%	0%	Tercapai	Ada	
10	FARMASI	8x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Ada	
11	GIZI	8x/Bulan	100%	75%	50%	Menurun	Ada	
12	IRJA	8x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Ada	
13	PPI		100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

Analisis : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Januari Petugas PKRS tiap unit sudah melakukan kegiatan dengan baik , dari data tersebut Unit IGD dan ICU/HCU belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal sehingga peresentasi 0%, untuk Unit Gizi mengalami penurunan dari bulan Desember 2024

Rencana Tindak Lanjut : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Desember.

3.6.3.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	NOV	DES	JAN	%	Keterangan
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

Analisis : Hasil Edukasi individu unit pada bulan oktober tercapai 100%, terbukti dalam lembar edukasi kolaborasi DRM telah terisi.

Rencana Tindak Lanjut : -

3.6.3.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

NO	LEMBAR DRM	JML SAMPLE	KELENGKAPAN		ISI BENAR	VERIFIKASI KE PASIEN	KET
			YA	TIDAK			
1	General Consent	30					
2	SBAR	30					
3	Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan	30					
4	Pengkajian Kebutuhan KIE	30					
5	KIE Informed Consent	30					
6	CPPT	30					
7	Ringkasan Pasien Pulang	30					
8	Discharged Planning	20					
9	Edukasi kolaborasi	30					
11	KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal)	3					
12	Form AMA	1					
13	KIE Pre OP di Lembar Pre OP	6					

3.6.3.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	NOV	DES	JAN	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	50%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0	100%	0%	Tidak Tercapai	Terlaksana	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	NOV	DES	JAN	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%	-	

- Analisis

: PROGNAS yang tercapai di bulan Januari hanya dari Unit Gizi.
- Rencana Tindak Lanjut

: Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat menghidupkan kembali kegiatan PROGNAS

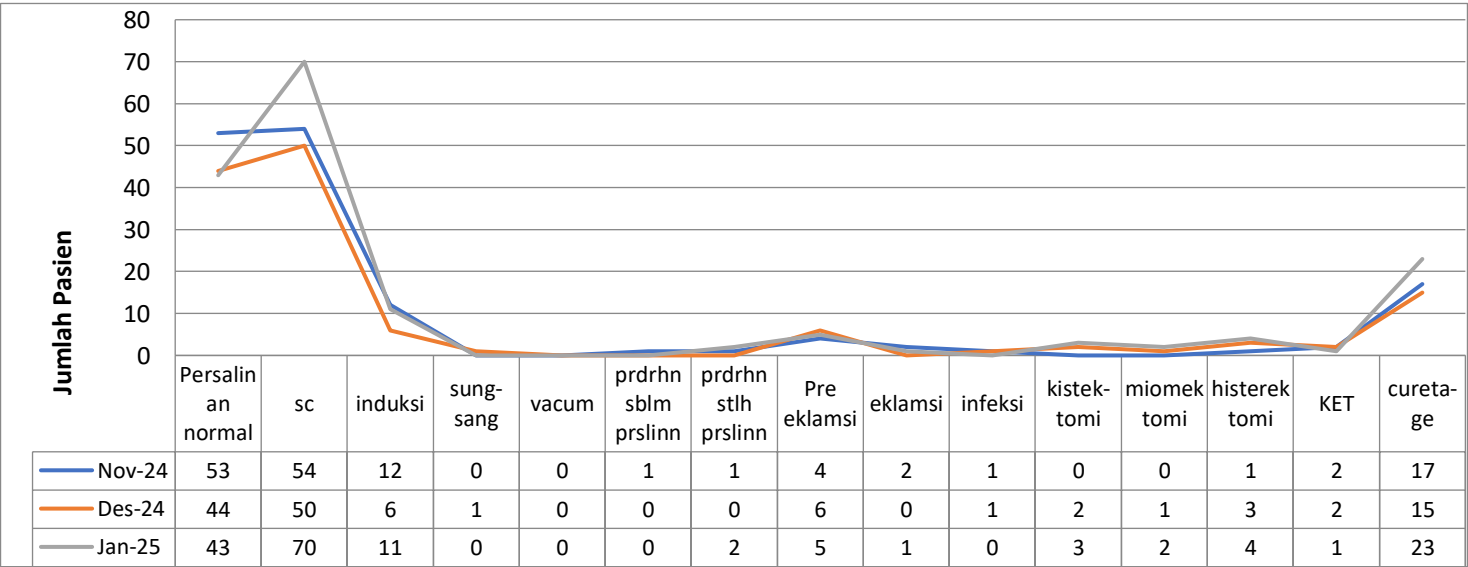
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Januari 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	53	44	43
	b. SectioCaesaria	54	50	73
2				
	a. Induksi / Drip	12	6	11
	b. Sungsang	0	1	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	1	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	0	2
	c. Pre Eklamsi	4	6	5
	d. Eklamsi	2	0	1
	e. Infeksi	1	1	0
4				
	a. Curretage	23	17	23
	b. Kistektomi	1	0	3
	c. Miomektomi	0	0	2
	d. Histerectomy	2	1	4
	e. KET	1	2	1

1.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Januari 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 70 pasien. Dan untuk persalinan

- normal pada bulan Januari 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 43 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
 3. Tidak ada persalinan dengan sungsang pada bulan Januari 2024 dan November 2024, sedangkan pada bulan Desember terdapat 1 persalinan dengan sungsang. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Januari 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
 4. Induksi Persalinan pada bulan Januari mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 11 pasien
 5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Januari sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5 pasien. Dan ada 1 kejadian eklamsi pada bulan Januari 2025
 6. Jenis pelayanan curretage di bulan Januari meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 23 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

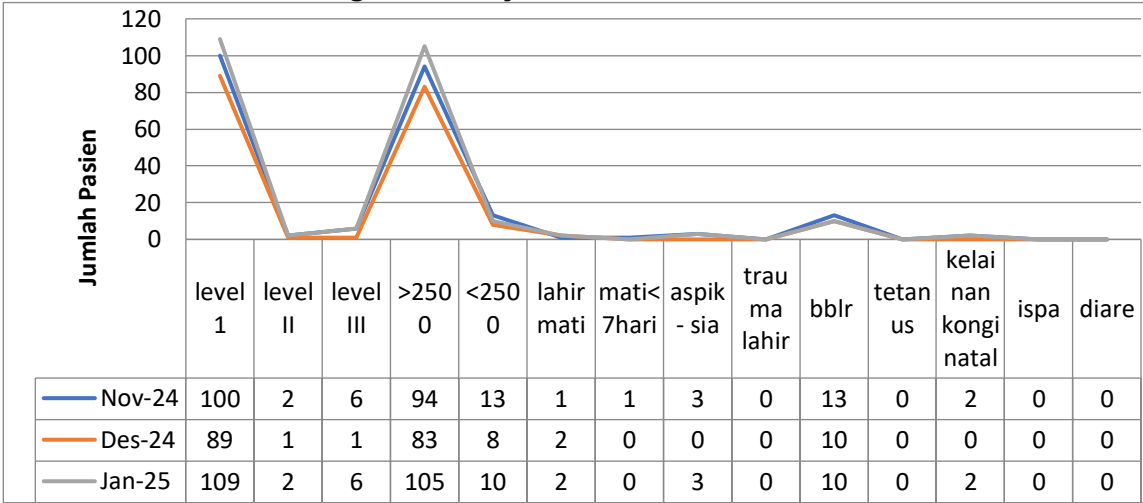
3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Januari 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1				
	a. Level 1	100	89	109
	b. Level II	2	2	2
	c. Level III	6	2	6
2				
	a. ≥ 2500 gram	95	83	105
	b. ≤ 2500 gram	13	10	10
3				
	a. Kelahiran Mati	1	2	2
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	1	0	0
4				
	a. Asphyxia	3	0	3
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	13	10	10
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	2	0	2
	f. ISPA	0	0	0

	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Januari 2024



Analisis :

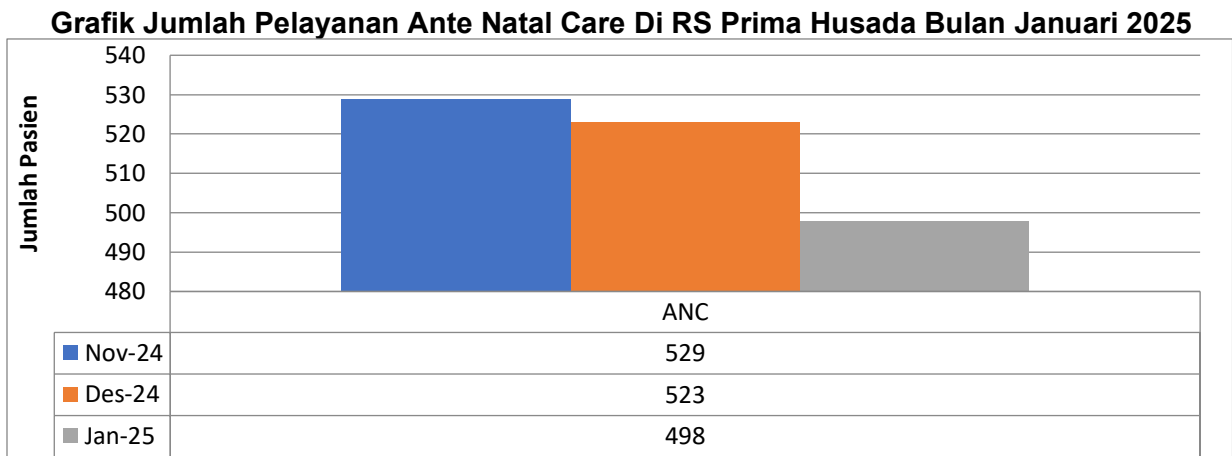
1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Januari 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 109 bayi. Dan pada level 2 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi. Sedangkan pada level 3 juga meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 6 bayi.
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Januari 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 105 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Januari 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan Januari 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 10 bayi.
5. Ada 2 kasus kelahiran mati pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025, dan 1 kasur kelahiran mati pada bulan November
6. Tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025, sedangkan pada bulan November ada 1 kasus kematian bayi

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek November 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	ANC	529	523	498

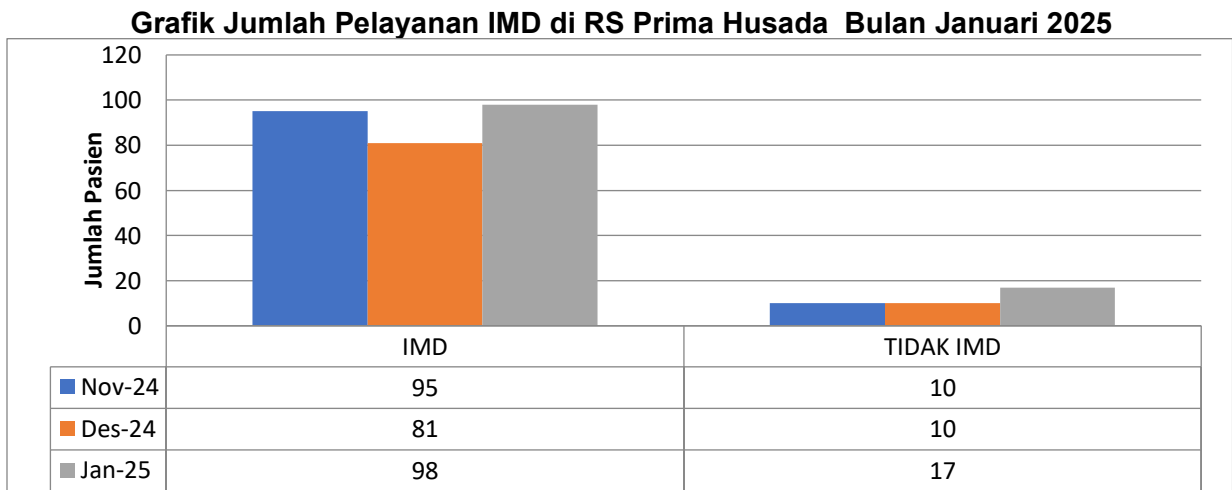


Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Januari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 498 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Januari 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	IMD	95	81	98
2	Tidak IMD	10	10	17



- Analisis :**
- Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Januari 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 98 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
 - Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Januari sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 17 bayi, Sedangkan pada bulan Desember dan November 2024

tetap, yaitu 10 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.

3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :

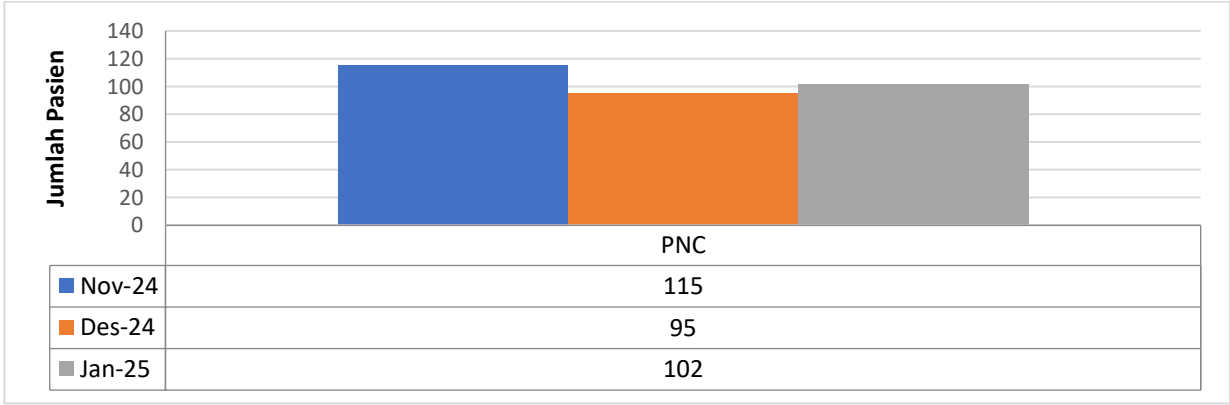
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponok Januari 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	PNC	115	95	102

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

Pelayanan PNC pada bulan Januari 2025 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 102 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

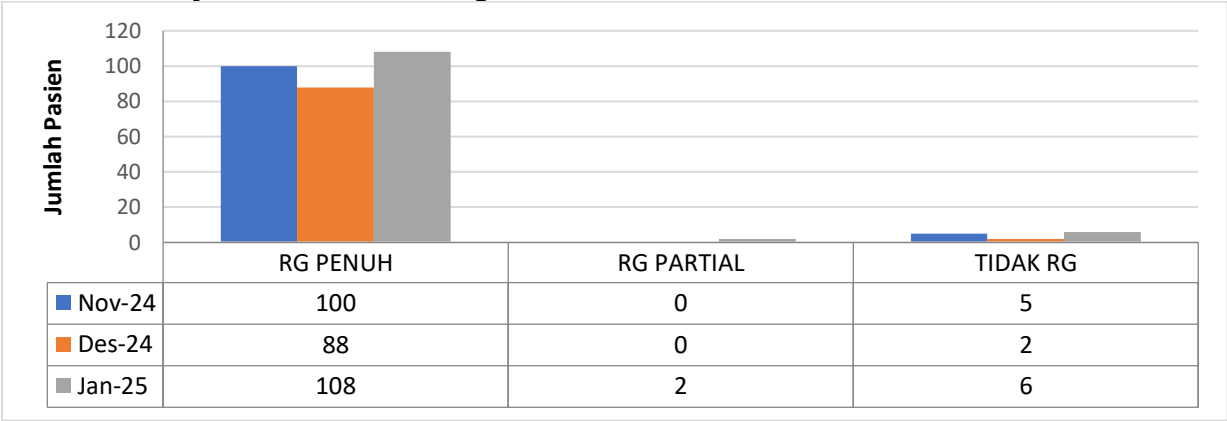
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung

Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponok November 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	Rawat gabung penuh	100	88	108
2	Rawat gabung partial	0	0	2
3	Tidak Rawat gabung	5	2	6

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Januari 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 108 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Januari juga meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 6 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan

Rencana dan Tindak Lanjut :

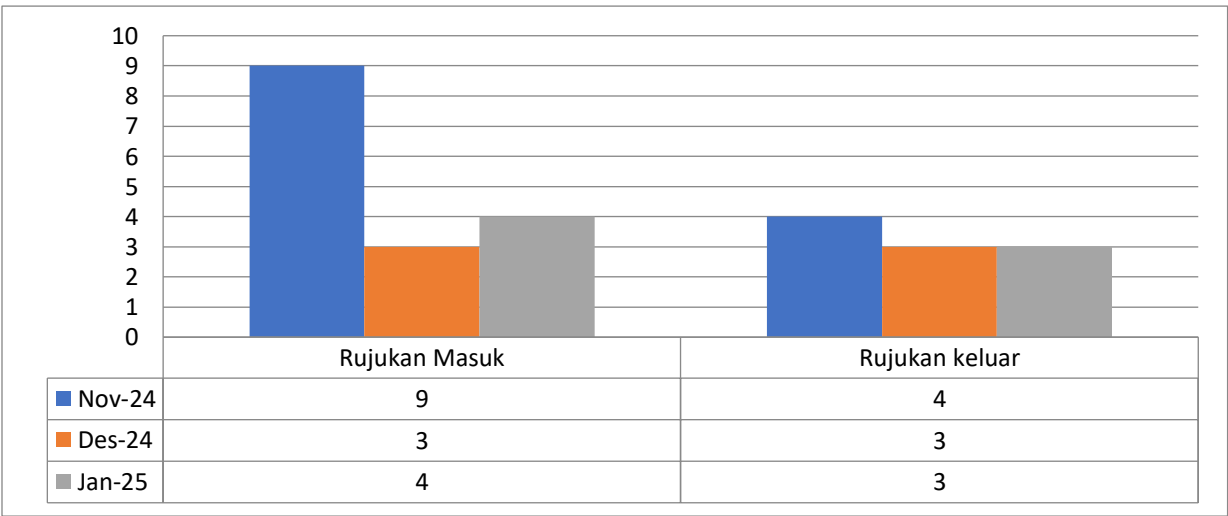
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan

Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек Januari 2025

NO	RUJUKAN	BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	Rujukan Masuk	9	3	4
2	Rujukan keluar	4	3	3

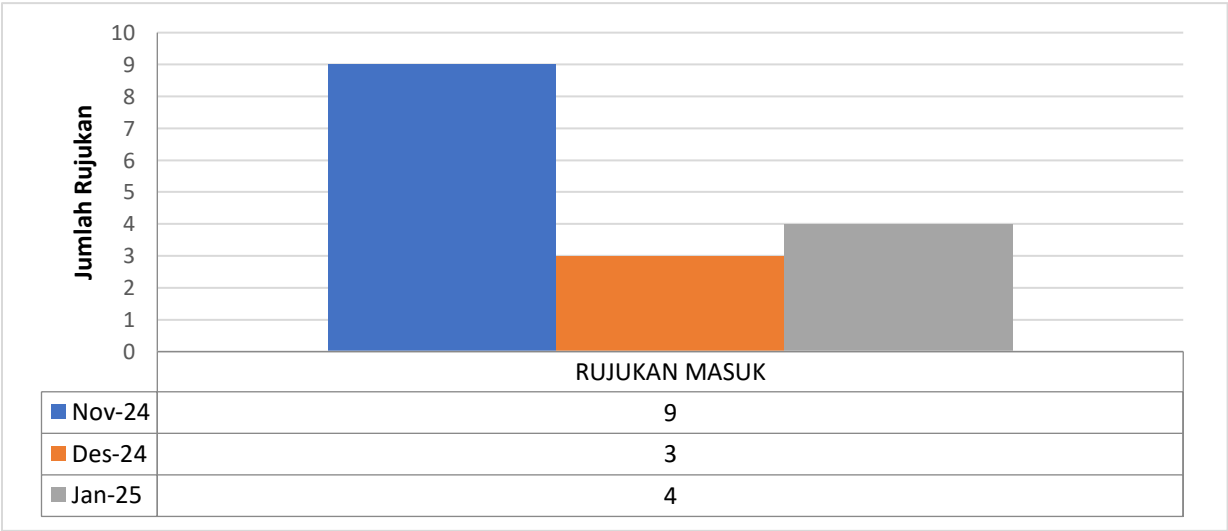
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Januari 2025



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponek Januari 2025

BULAN NOVEMBER 2024		
1	G3 P1001 AB100 UK 10-12 Mgg dg Abortus Inkomplit	Bidan Tri Widiyawati
2	G2P1001AB000 UK 41-42 Mg Dg K1FA + Post date	Bidan Fitri Dwi
3	G1P000 ABOO UK 34-36 Mgg + KPD JAM 03.00	Bidan Dilla Sobirin
4	G1 P0000 AB000 UK 30-31 Mgg Dg PPI	Bidak Titik Sunariyarti
5	G1P0000AB000 UK 39-40 Mgg + Kala 2 Lama	PKM Ardimulyo
6	G1P000 ABOO 40-41 Mgg + Prolong KIFL	Bidak Titik Sunariyarti
7	G2 P1001 AB000 UK 39-40 Mgg DG BSC 5 TH + KIFL	Bidan Nurul Ismawati
8	G1P0AB0 UK 37-38 MGG DG PE	Bidan Nuiana
9	G1 PO AB 0 UK 30-32 Mgg Dg KALA 2 + PPI Primi Muda	Bidan Tri Widiyawati
BULAN DESEMBER 2024		
1	G2 P1001 Ab000 UK 12 -14 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
2	G4 P3003 Ab000 UK 39 - 40 mgg dg KIFA	BPM Lilik Agustina
3	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 mgg dg KIFA	PKM Singosari
BULAN JANUARI 2025		
1	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg BSC + Prolong KIFL	BPM Lilik Agustina
2	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD	BPM Titik Sunariyati
3	G3 P1001 Ab100 UK 10-12 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
4	G3 P2002 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD +KIFL	PKM Singosari

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

Jumlah rujukan masuk pada bulan Januari 2025 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 4 rujukan, sedangkan pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 rujukan, dan 9 rujukan masuk pada bulan November 2024

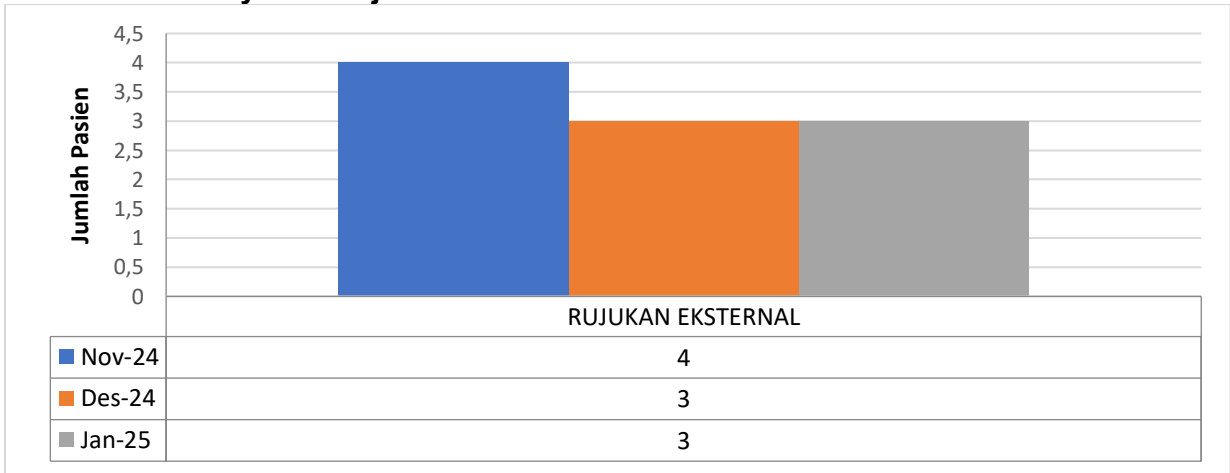
Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponek Januari 2025

BULAN NOVEMBER 2024		
1	G2P10AB0 UK 36-37 mgg dg KIFL + KPD + Tali Pusat Menumbung + Fetal Distress	RS Saiful Anwar
2	G2P1001 ABOO UK 21-22 mgg + HEG + DF	RS Saiful Anwar
3	NKB + BBLR +ASFIKSIA	RS Saiful Anwar
4	NKB + BBLR + TTNB	RS Lavalette
BULAN DESEMBER 2024		
1	RDS + Prematur + BBLASR	RS Lavalette
2	Abdominal Pregnancy dd syok Hipovelemik	RS Saiful Anwar
3	PEB + BSC+Ascites Permagna+ IUFD	RS Saiful Anwar
BULAN JANUARI 2025		
1	BBLR + Asfiksia	RS Saiful Anwar
2	RDS ok Neonatal pneumonia dd TTNB + Makrosefali	RS Soepraon
3	Post curettage + Sub Involusi Uteri + syok hipovolemi	RS Saiful anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

Pada bulan Januari 2025 dan Desember 2024 pasien dan bulan November ada 4 pasien,

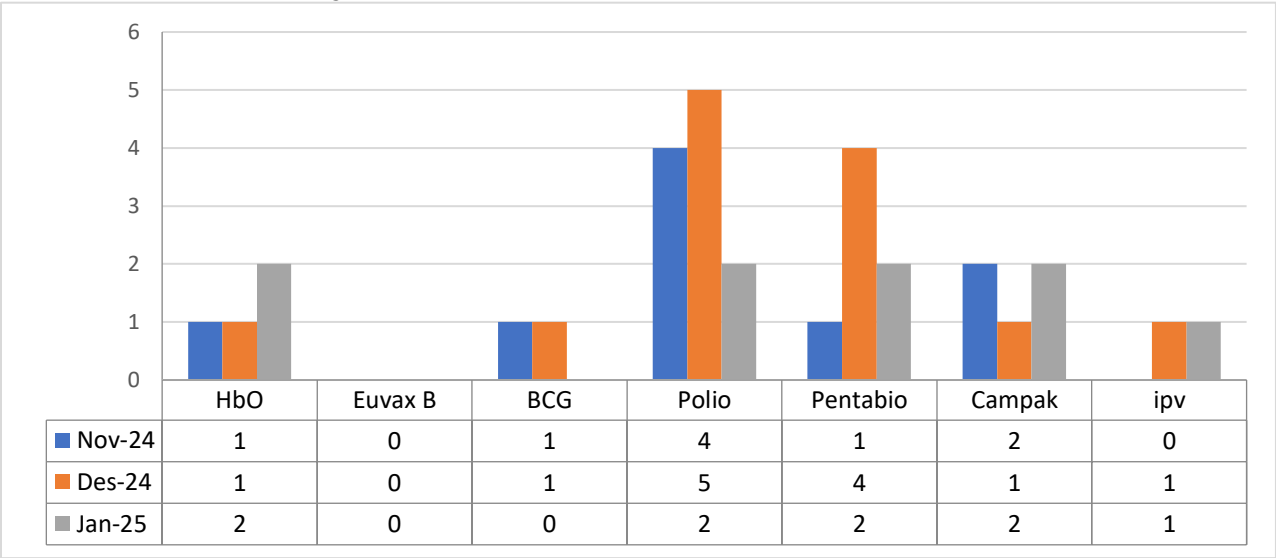
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Januari 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	HbO	1	1	2
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	1	0
3	Polio	4	5	2
4	Pentabio	1	4	2
5	Campak	2	1	2
6	IPV	0	1	1

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Januari 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Januari 2025 ada 2, sedangkan pada November 2024 dan Desember 2024 sebanyak 1 bayi. Hal ini dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025 sebanyak 1 bayi, sedangkan pada bulan November tidak ada
4. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Januari, dan pada bulan Desember dan November sebanyak 1 bayi
5. Bayi yang melakukan Imunisasi Campak Pada bulan Januari 2025 dan November 2024 sebanyak 2 bayi, sedangkan pada bulan Desember sebanyak 1 bayi
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Januari 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi
7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Januari menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 2 bayi

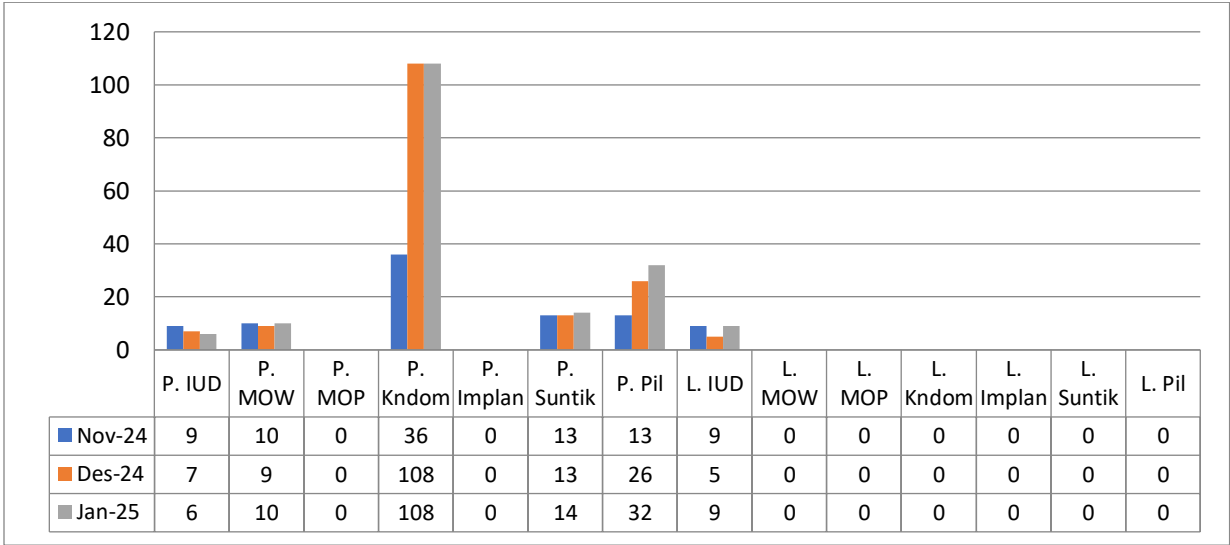
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok Januari 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025	BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	IUD	9	7	6	9	5	9
2	MOW	10	9	10	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	36	108	108	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	13	13	14	0	0	0
7	Pil	13	26	32	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2025



Aanalisis :

1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Januari 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 6 akseptor yang terdiri dari 3 akseptor IUD Nova T dan 3 akseptor IUD copper T
2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Januari 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025 sama, yaitu 108 pengguna, sedangkan pada bulan November yaitu 36 pengguna
4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Januari 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 32 pengguna
5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Januari sebanyak 14 pengguna. Dan 2 bulan sebelumnya sebanyak 13 penggunaan

Rencana dan Tindak Lanjut :

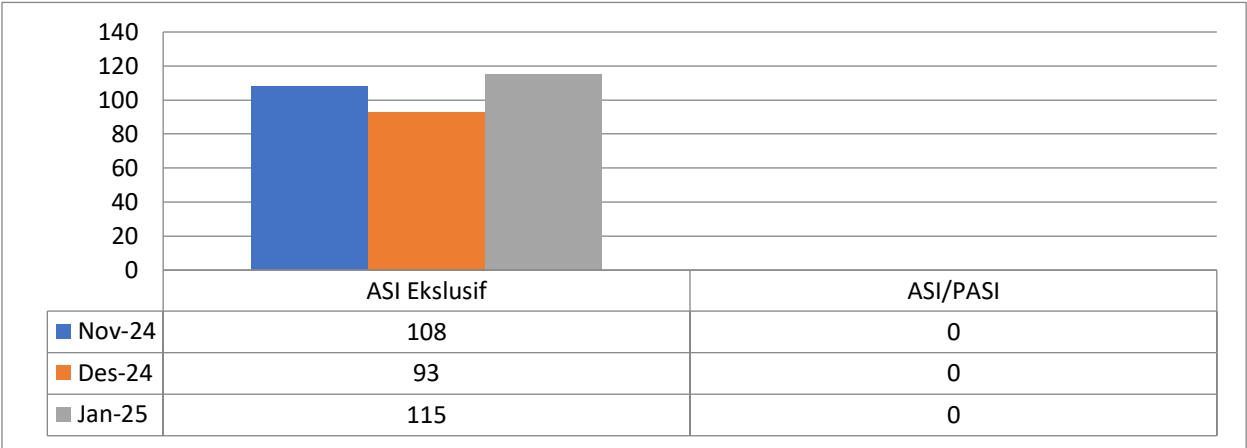
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Januari 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER	BULAN DESEMBER	BULAN JANUARI

		2024	2024	2025
1	Asi eksklusif	108	93	115
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Januari 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 115 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

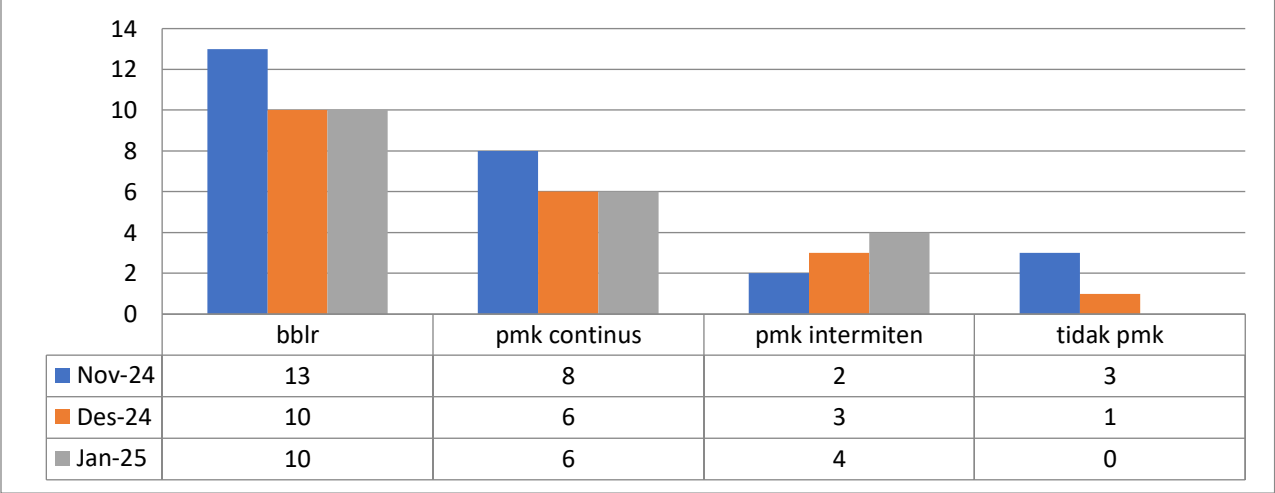
Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponек Januari 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	Bayi BBLR	13	10	10
2	PMK continuos	8	6	6
3	PMK Intermiten	2	3	4
4	Tidak PMK	3	1	0

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Januari 2025 meningkat sedikit jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 4 bayi, sedangkan pada bulan Desember 2025 sebanyak 3 bayi, dan pada bulan November sebanyak 2 bayi
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Januari 2025 dan Desember 2024 tetap sebanyak 6 bayi, dan pada bulan November 2024 sebanyak 8 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan tidak ada bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Januari 2025, sedangkan pada bulan Desember 2024 sebanyak 1 bayi, dan November sebanyak 3 bayi. Hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

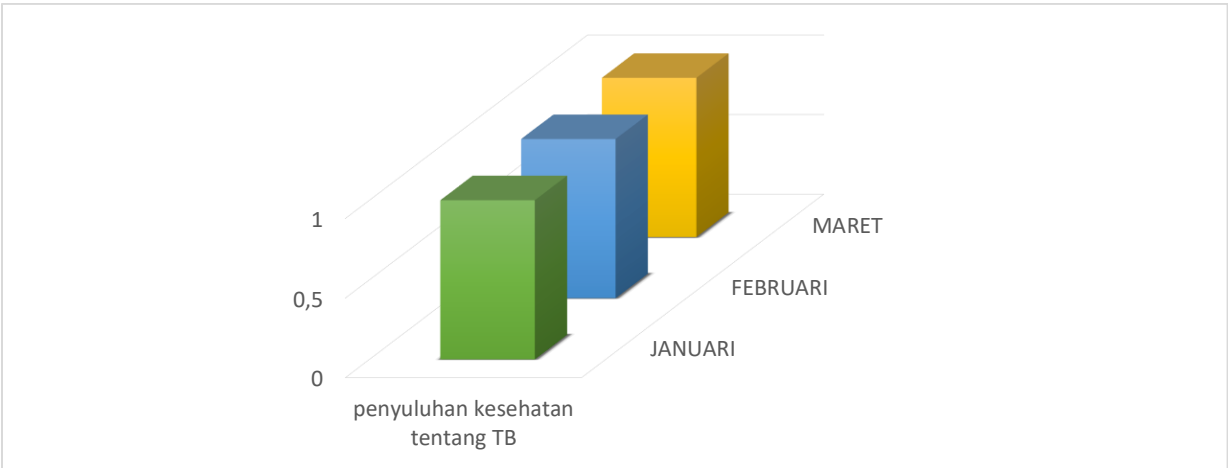
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1		

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

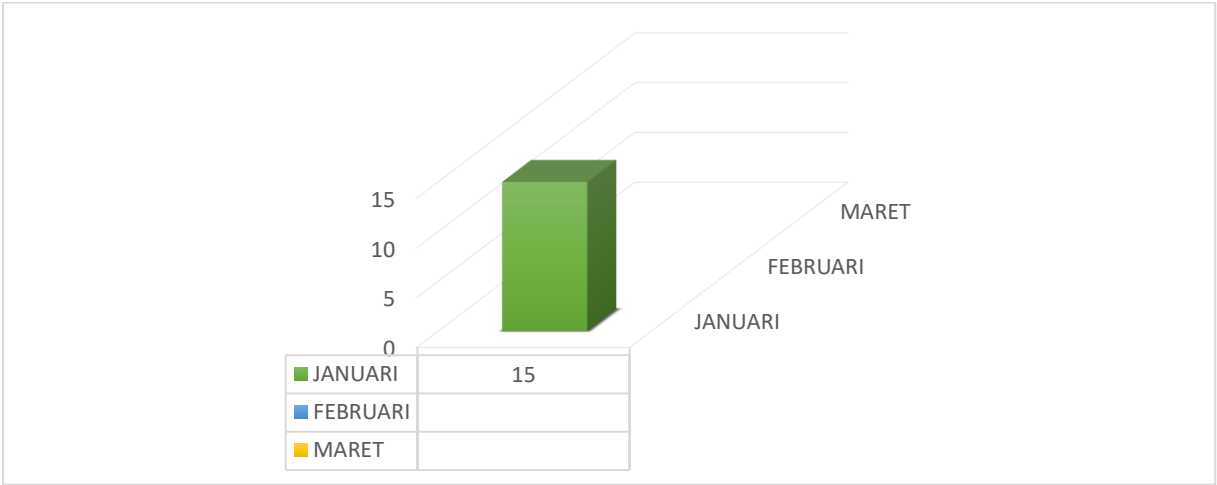
Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian Masker	15		

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Januari 2025 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

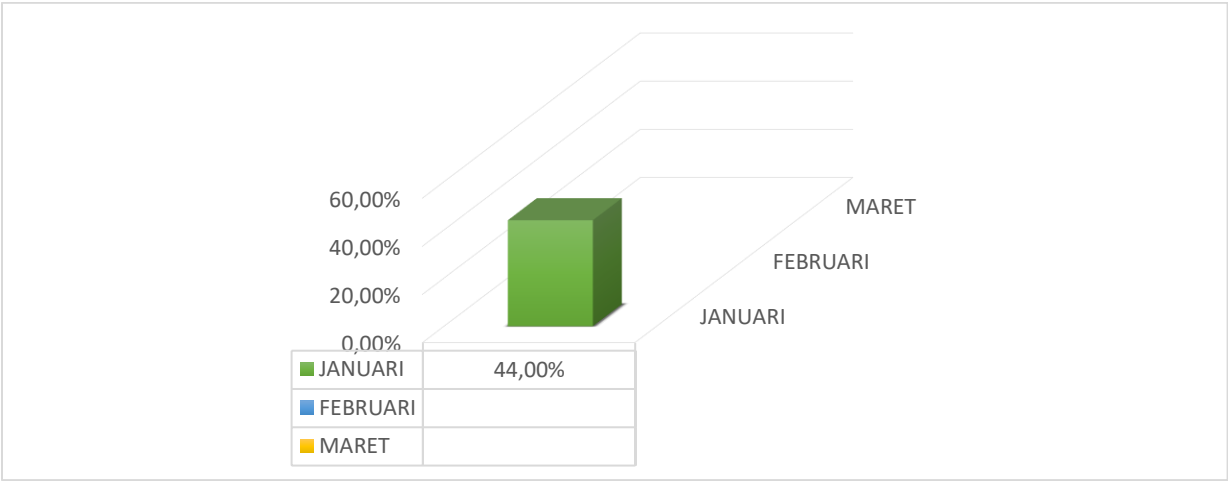
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	44		

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



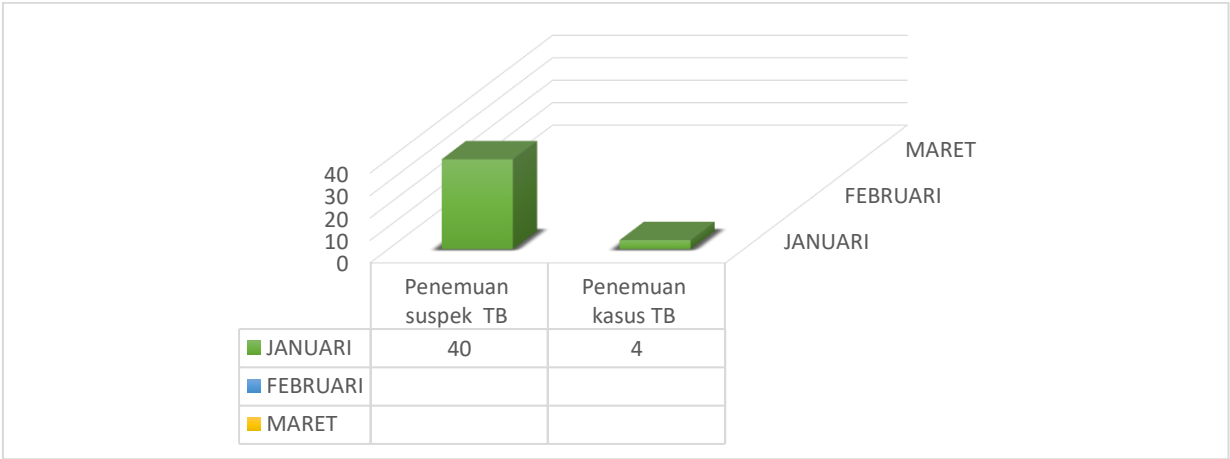
Analisis :
Pada bulan januari 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 44

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penemuan suspek TB	40		
2	Penemuan kasus TB	4		

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada

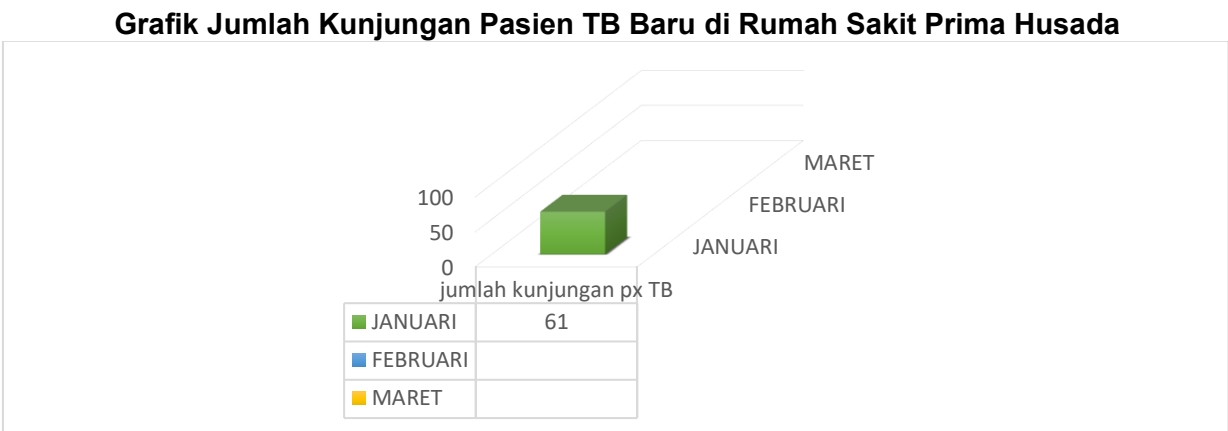


Analisis :
Pada bulan januari 2025 terdapat 40 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:
Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	61		

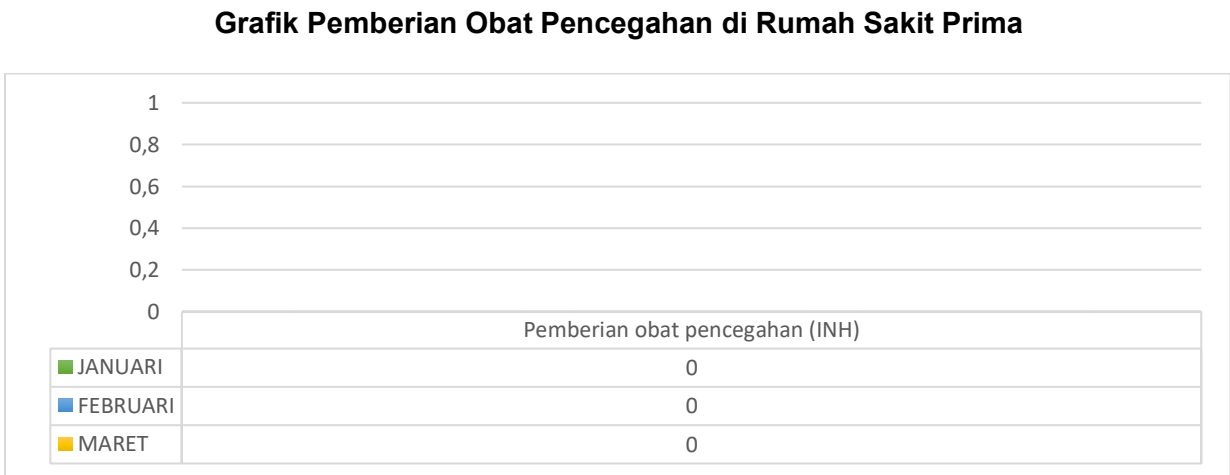


Analisis:
 Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Januari 2025 di poli pasien TBC mencapai 61 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0		



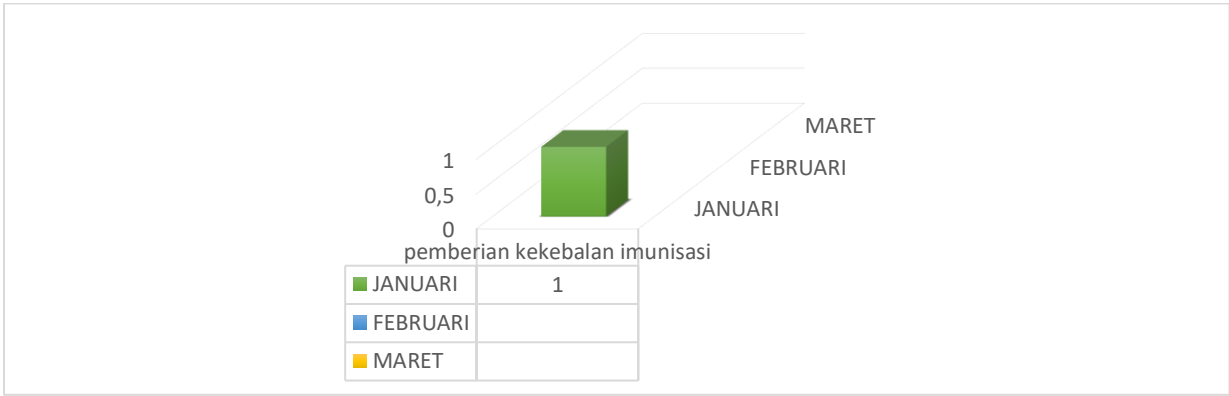
Analisis :
 Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

- Rencana dan Tindak Lanjut**
- Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
 - Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pemberian imunisasi BCG	1		

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



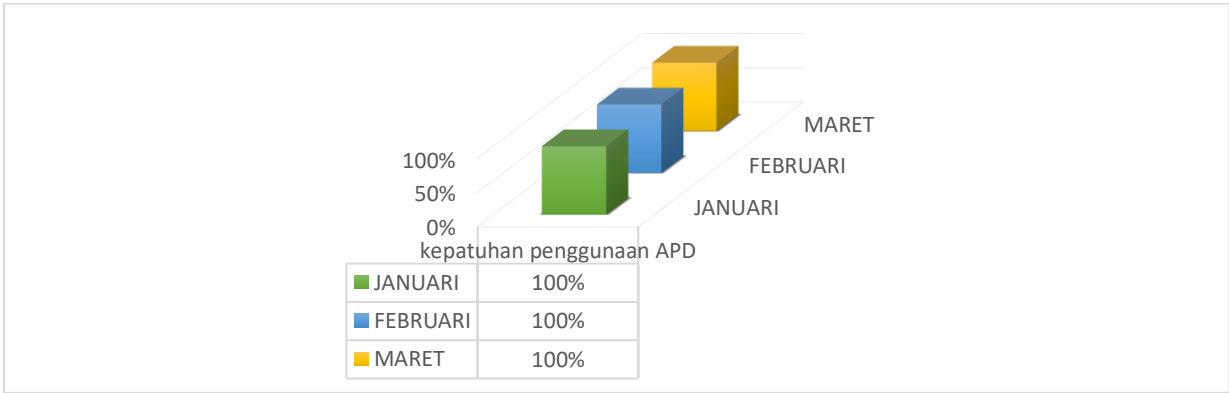
Analisis :
Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
 - 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulany

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



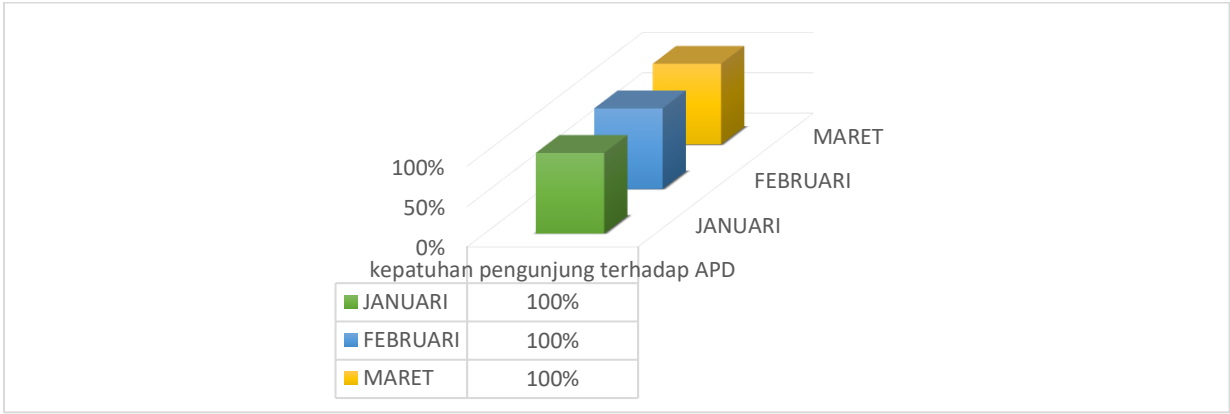
Analisis :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



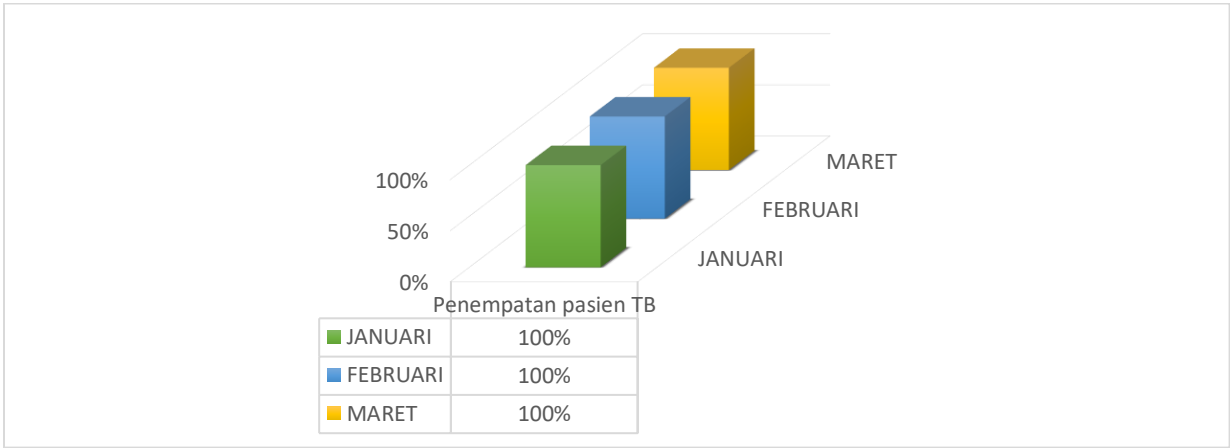
Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Oktober 2024



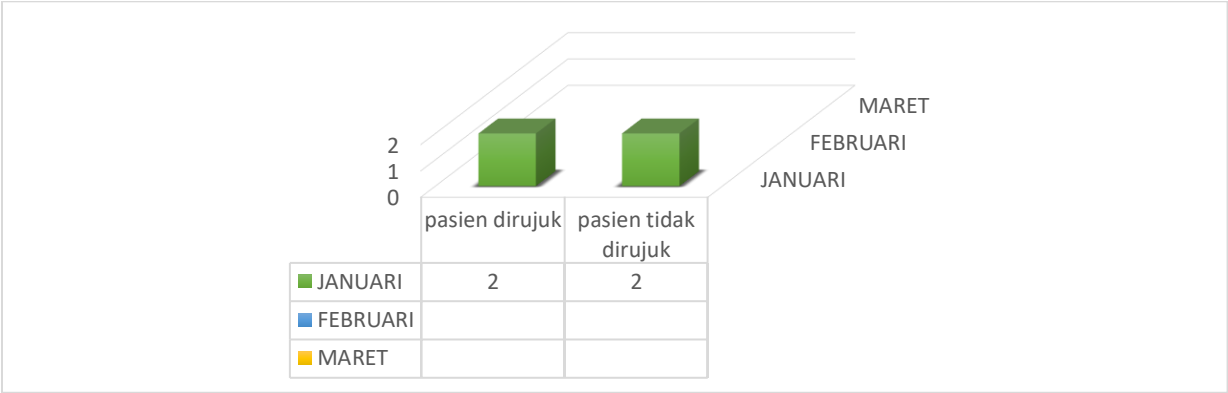
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien TB yang dirujuk	2		
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	2		

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



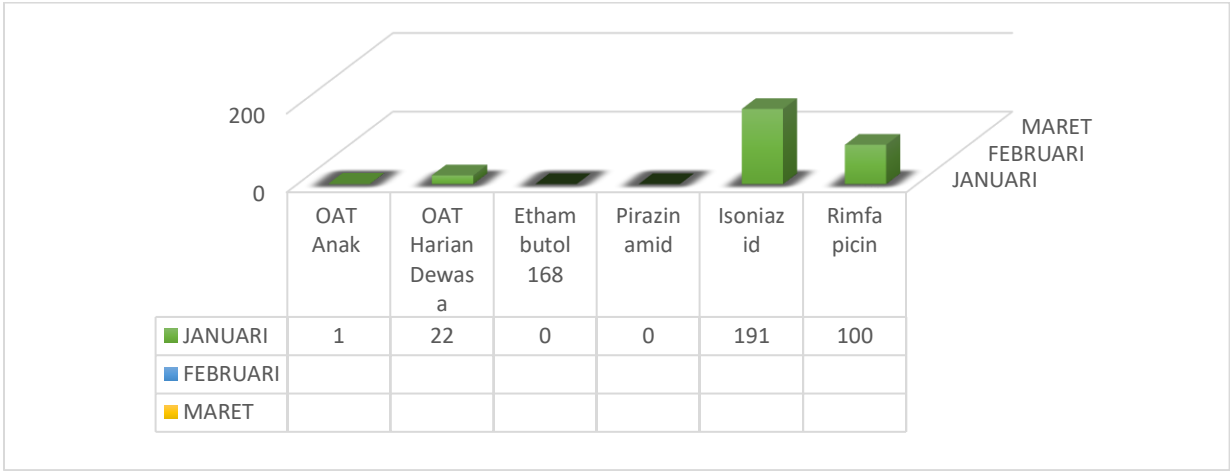
Analisis :
Pada bulan Januari 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	OAT Anak	1		
2.	OAT Harian Dewasa	22		
3.	Ethambutol	0		
4.	Pirazinamid	0		
5.	Isoniazid	191		
6.	Rimfapicin	100		

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

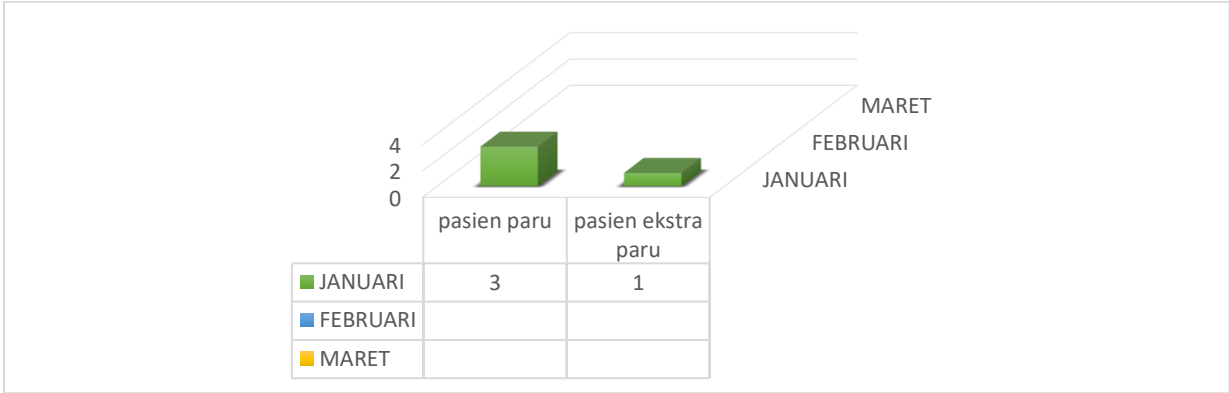
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien paru	3		
2.	Pasien Ekstra paru	1		

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



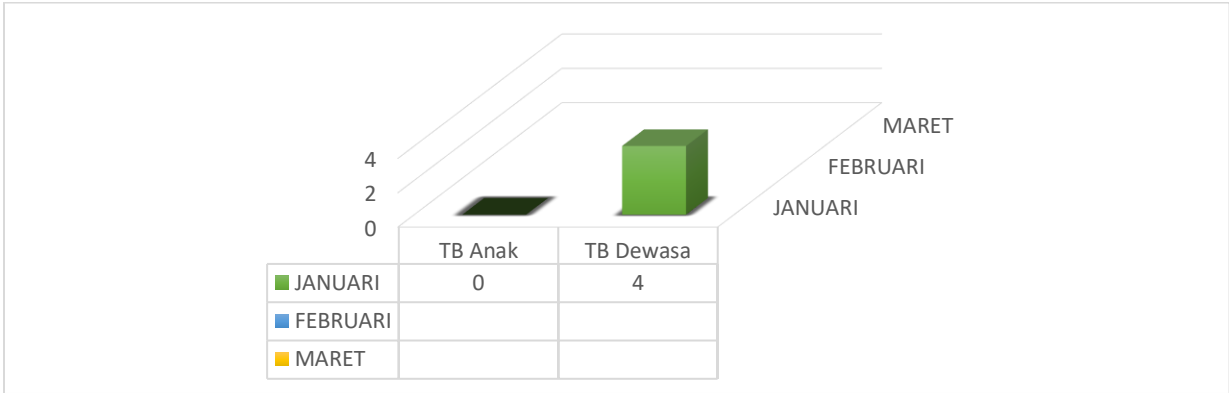
Evaluasi :
Pada bulan januari 2025 terdapat 1 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET
1.	Pasien Anak	0		
2.	Pasien Dewasa	4		

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Pada bulan Januari terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 4 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P				
		Tn. P	V		
3.	Dr. Yunita, Sp. P				
		Ny. S	V		

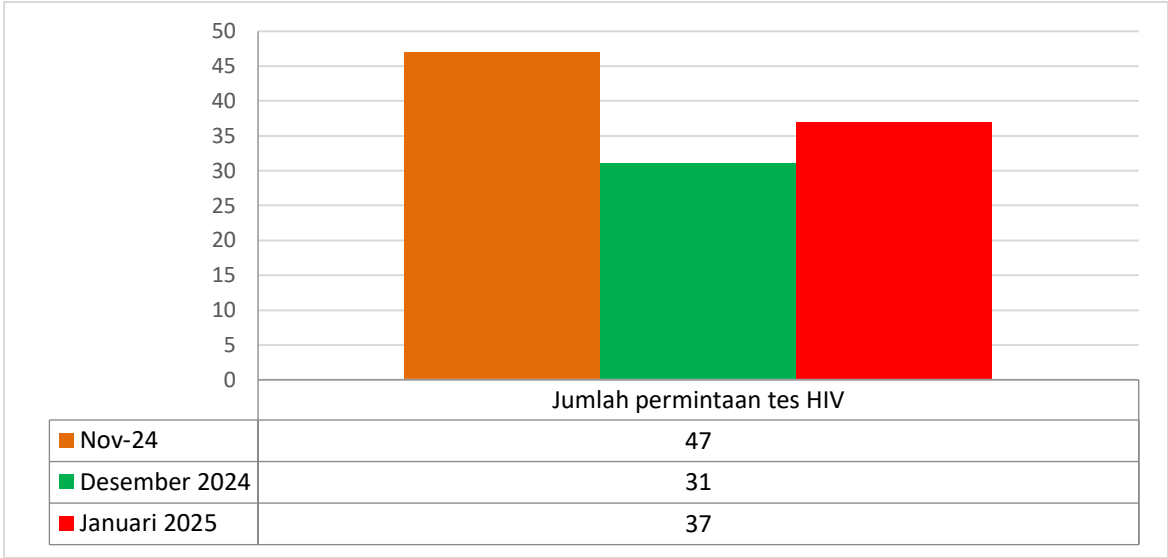
Analisis :
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Permintaan Test HIV	47	31	37

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Januari 2025 sebanyak 37 pemeriksaan, pada bulan Desember 2024 sebanyak 31 pemeriksaan, Sedangkan pada bulan November 2024 sebanyak 47 pemeriksaan, Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

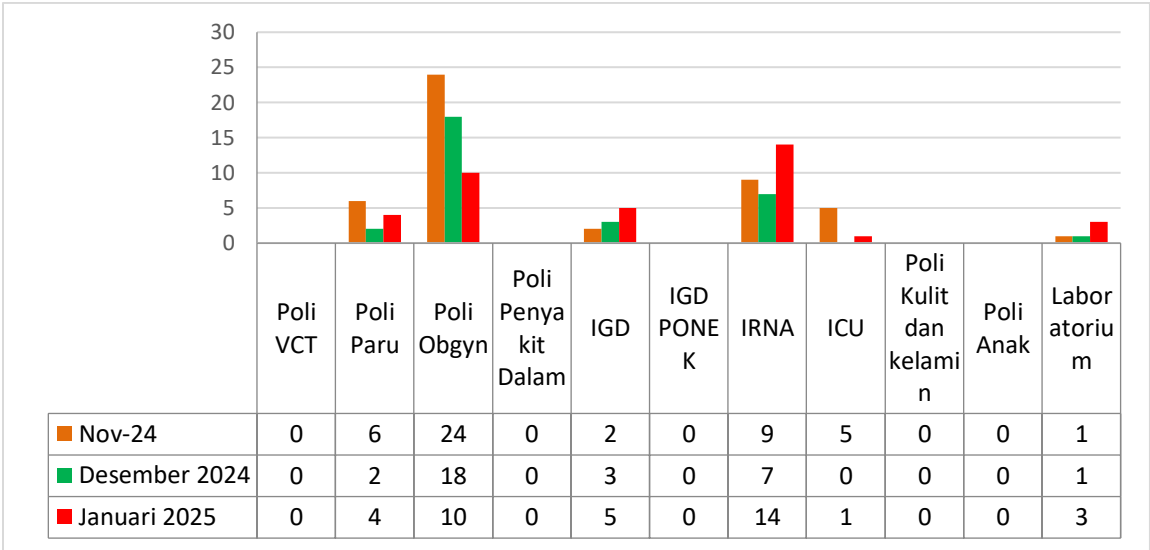
Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemeritksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	6	2	4
3	Poli Obgyn	24	18	10
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	2	3	5
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	9	7	14
8	ICU	5	0	1
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	1	1	3

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada

Bulan Januari 2025



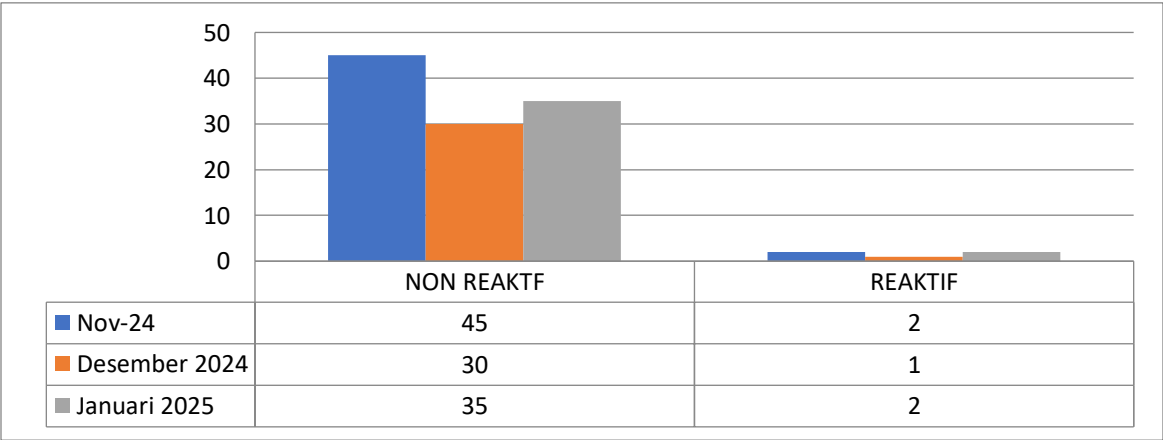
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan November 2024 sebanyak 24 pasien, pada bulan desember 2024 sebanyak 17 pasien Sedangkan pada bulan januari 2025 sebanyak 10 pasien
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Non Reaktif	45	30	35
2	Reaktif	2	1	2

Grafik Status HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Januari sebanyak 2 kasus dari rawat inap.

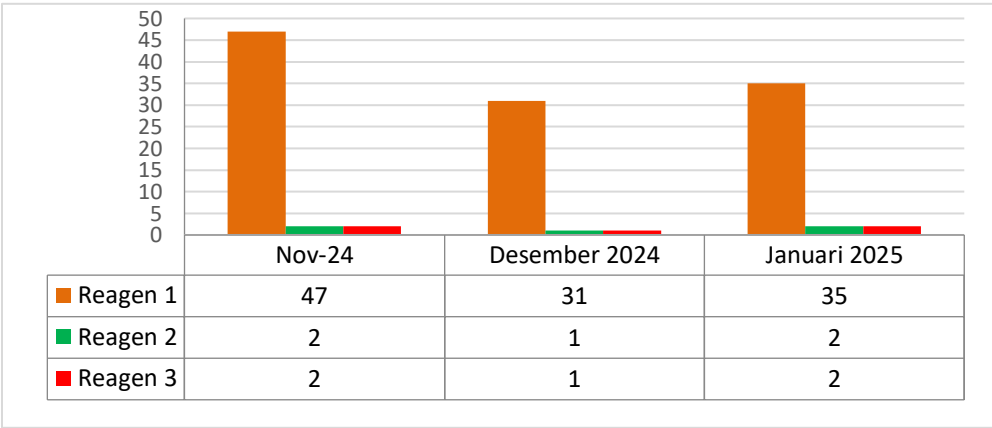
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Reagen 1	47	31	35
2	Reagen 2	2	1	2
3	Reagen 3	2	1	2

**Grafik Jumlah Pemakaian Reagen di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2025**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Januari memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien hasil reaktif sebanyak 2 pasien. Pada bulan Desember 2024 memakai reagen 3 Dikarenakan ada pasien dengan hasil reaktif sebeanyak 1 pasien, Sedangkan pada bulan November 2024 memakai reagen 3 Dikarenakan ada pasien dengan hasil reaktif sebeanyak 2 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

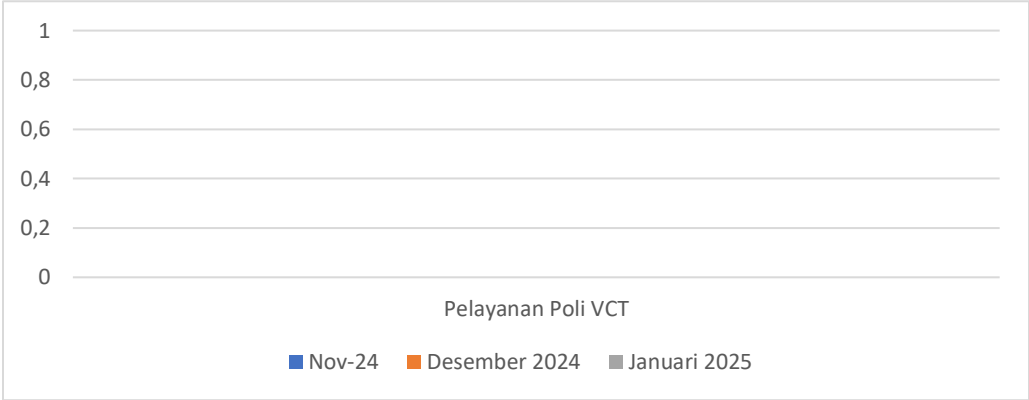
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Di Rumah Sakit Prima Husada

Bulan Januari 2025



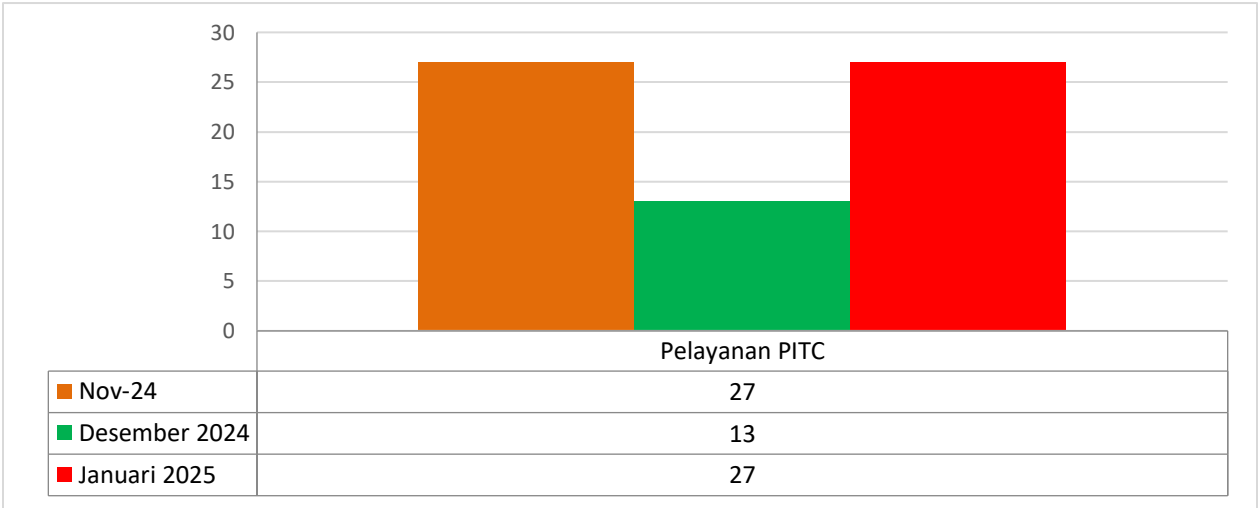
Analisis pelayanan Poli VCT
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Pelayanan PITC	27	13	27

Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2025



Analisis :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan November sebanyak 20 pasien pada bulan desember sebanyak 13 pasien. Sedangkan pada bulan januari 2025 sebanyak 27 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

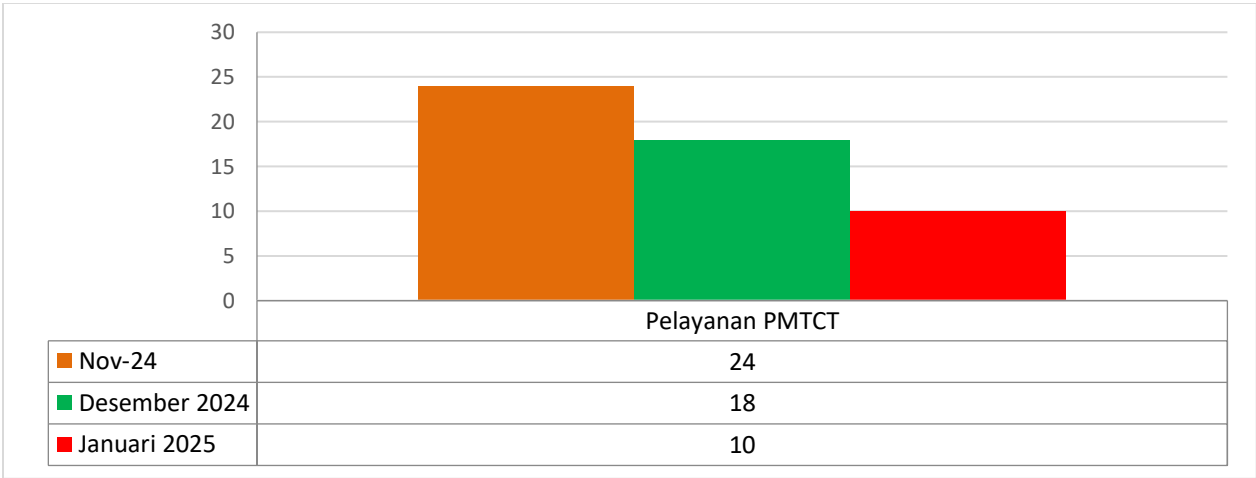
Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya

dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Pelayanan PMTCT	24	18	10

Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Januari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan November sebanyak 24 pasien, pada bulan Desember sebanyak 18 pasien Sedangkan Pada bulan januari 2025 sebnayak 10 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :

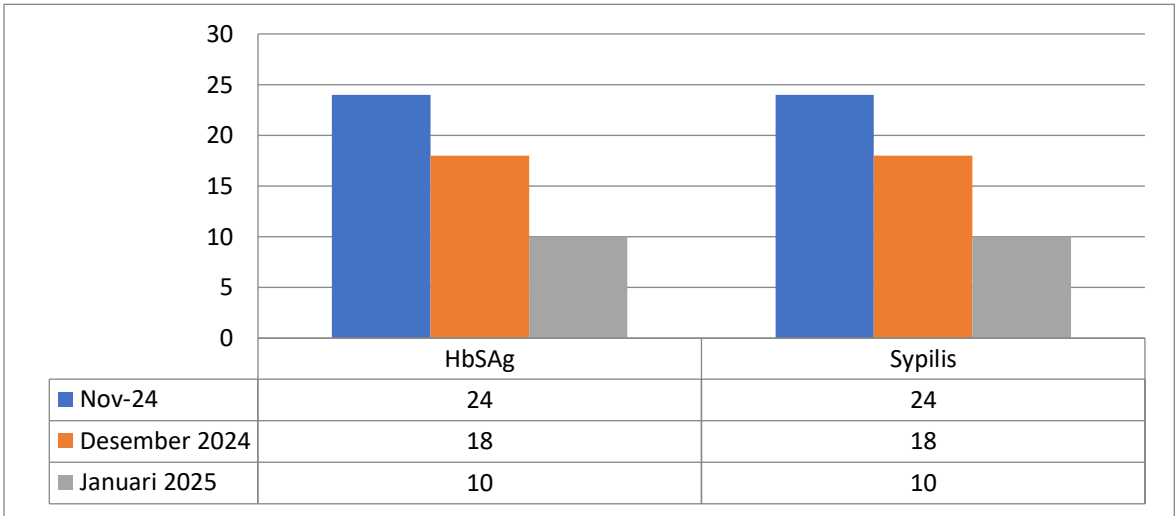
Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	HbSAg	24	18	10
2	Sypilis	24	18	10

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil

di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2025



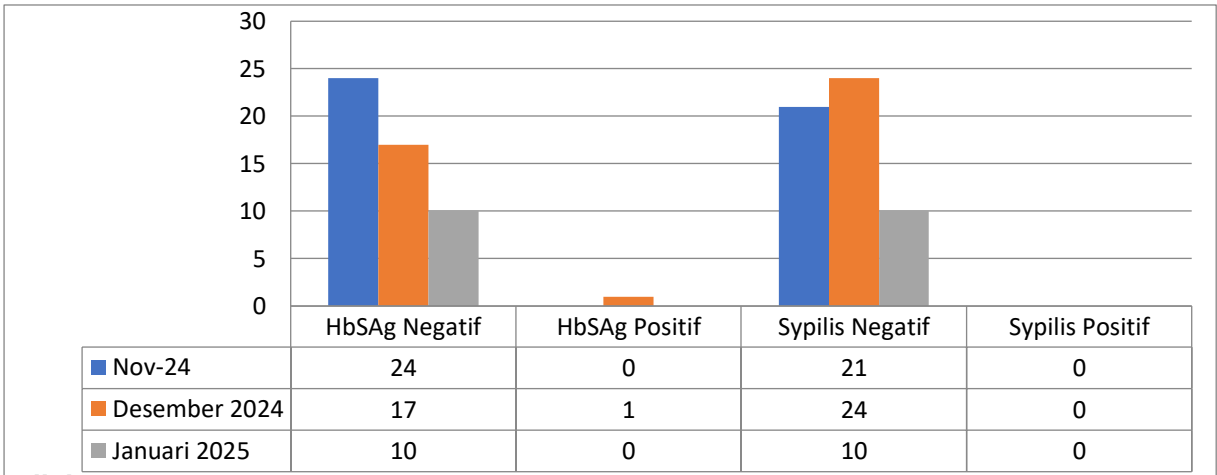
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan November sebanyak 24 pasien, pada bulan desember 2024 sebanyak 18 pasien Sedangkan pada bulan Januari 2025 sebanyak 10 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	HbSAg			
	Negatif	24	17	10
	Positif	0	1	0
2	Sypilis			
	Negatif	24	17	10
	Positif	0	1	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan oktober, November dan Desember 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif sedangkan pada bulan desember 2024 ditemukan 1 pasien dengan HbSAg Positif

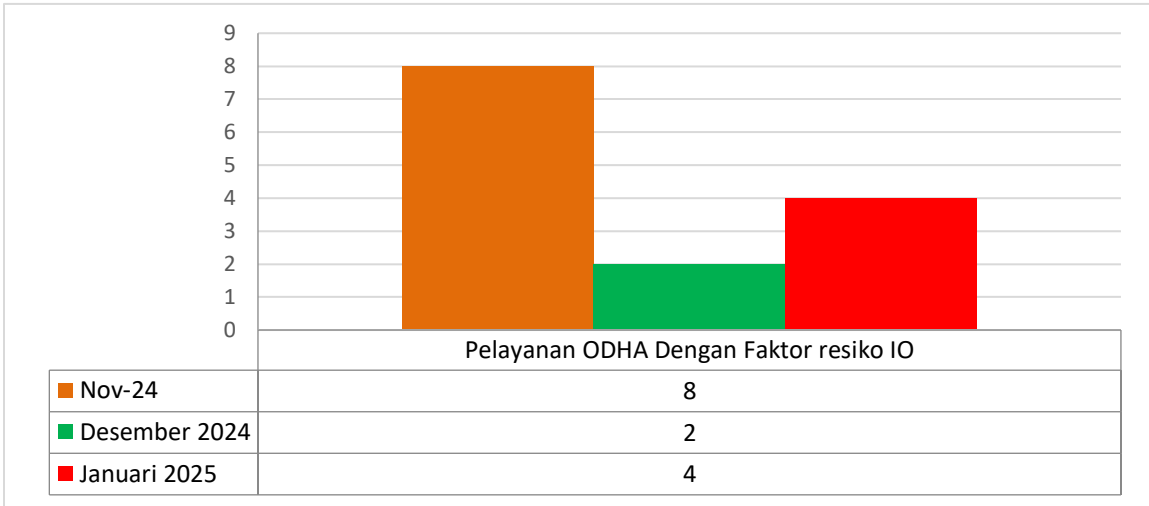
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Syphilis
- Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	8	2	4

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Januari 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan November 2024 didapatkan 8 pasien. pada bulan desember 2024 didapatkan 2 pasien. Sedangkan pada bulan Januari 2025 didapatkan 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

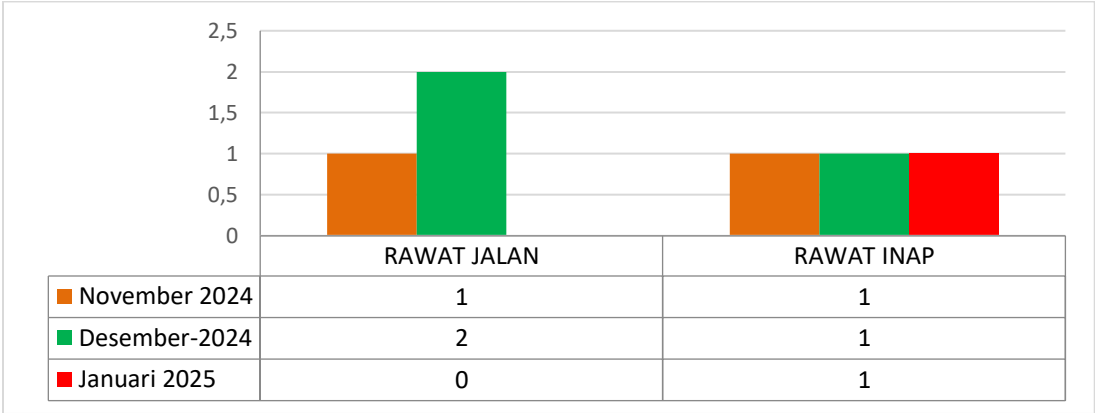
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	Rawat Jalan	1	2	0
2	Rawat Inap	1	1	1

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Januari 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan November ada 2 pasien yang dilakukan rujuk yaitu dari rawat inap dan dari rawat jalan poli IPD. pada bulan desember 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk 2 dari poli dan 1 dari rawat inap Sedangkan pada bulan januari terdapat 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Januari 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas

		3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2
Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1

	2. Pemberian tablet tambah darah dan asam folat					
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pemberian PMBA	IRNA Anak	-	0	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0

Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	0	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	529	523	498

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada Bulan Januari 2025



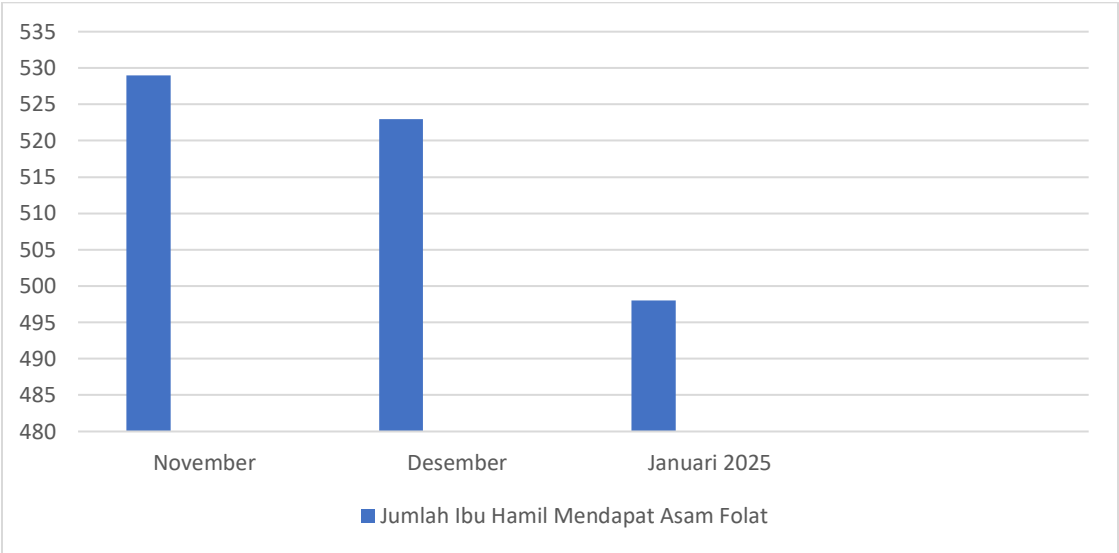
Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan Januari 2025 yaitu 498 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	IMD	95	81	98
2	Tidak IMD	10	10	18
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	105	91	116



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan Januari 2025 yaitu 498 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

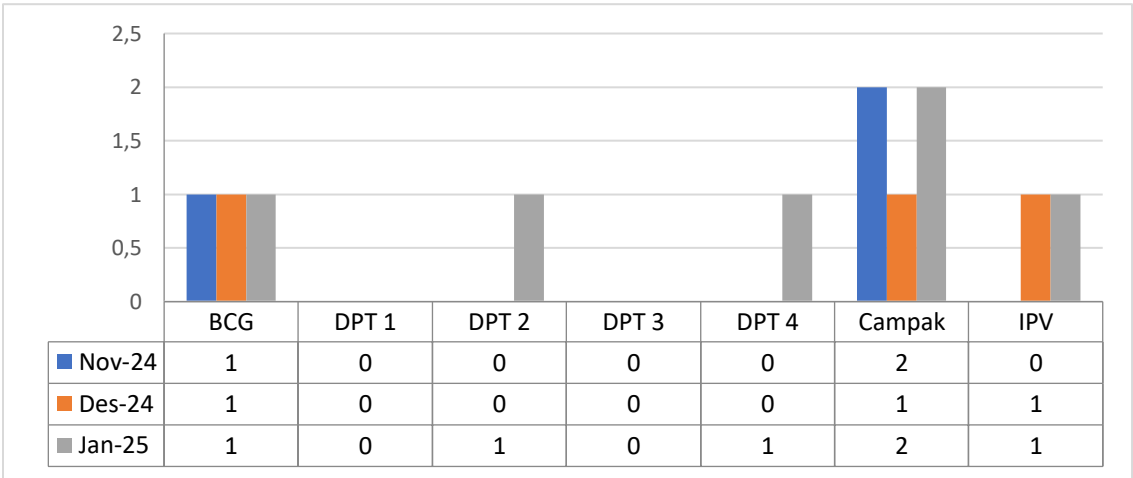
- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN OKTOBER 2024	BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024
1	BCG	1	1	1
2	DPT 1	0	0	0
3	DPT 2	0	0	1
3	DPT 3	0	0	0
4	DPT 4	0	0	1
5	Campak	2	1	2
6	IPV	0	1	1

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan November 2024 – Januari 2025



Analisis:

1. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Januari 2025
2. Terdapat 1 balita yang melakukan imunisasi DPT 2, dan 1 balita melakukan imunisasi DPT 4.
3. Terdapat 1 bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Januari 2025
4. Pada periode Januari 2025 terdapat bayi yang melakukan Imunisasi Campak yaitu 2 bayi.

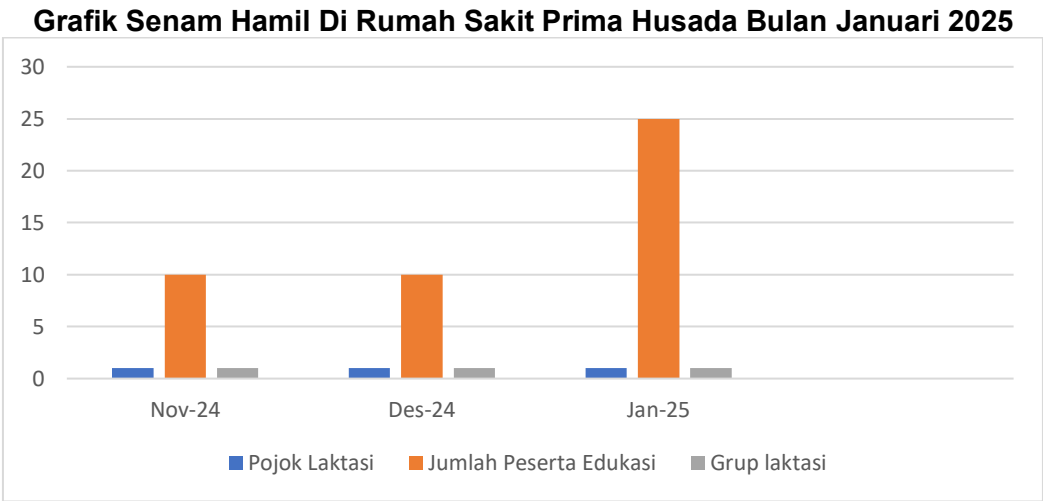
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	10	10	25
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1



Analisis :

1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
3. Jumlah peserta edukasi pada bulan Oktober meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 20 orang

Rencana Tindak Lanjut :

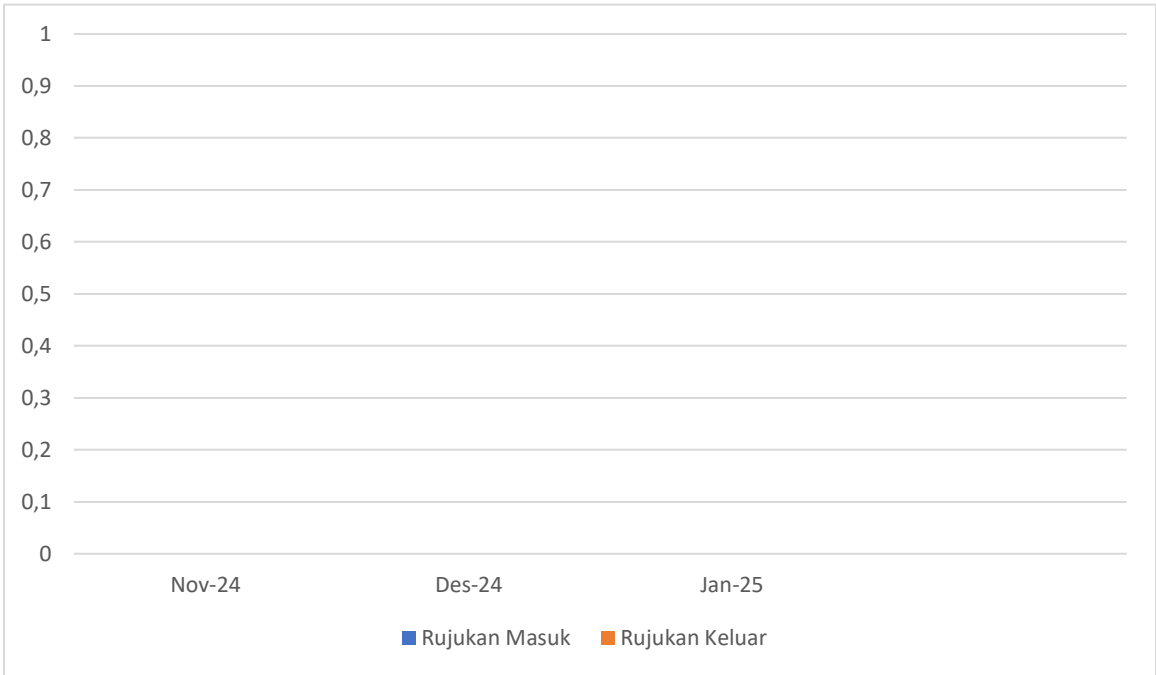
1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-

RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-



Analisis :
 Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

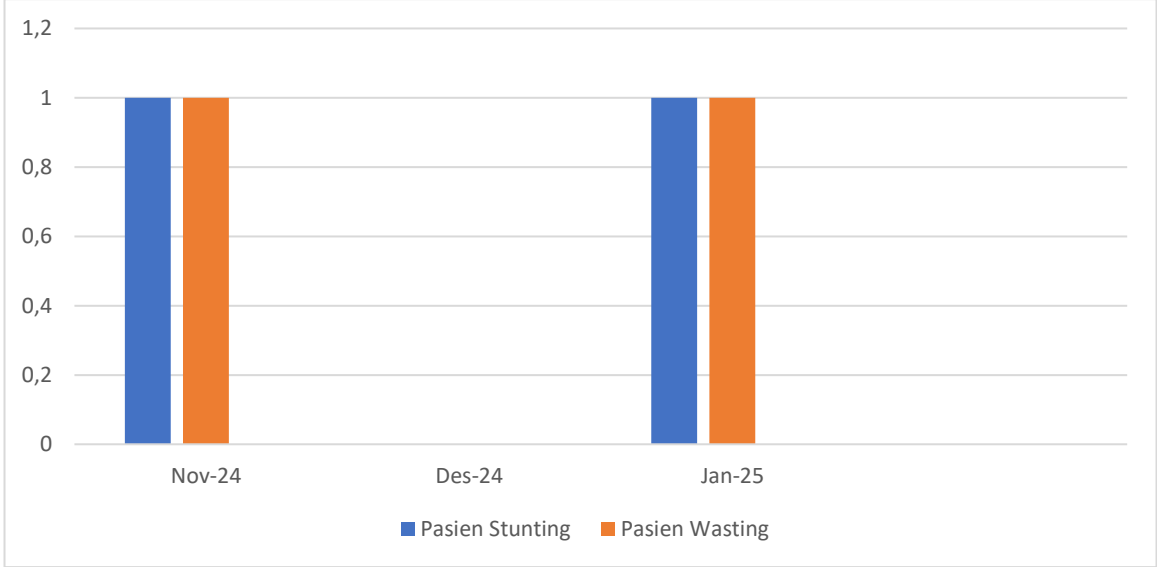
Rencana Tindak Lanjut:
 Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	1	1
Jumlah Pasien Wasting	0	1	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



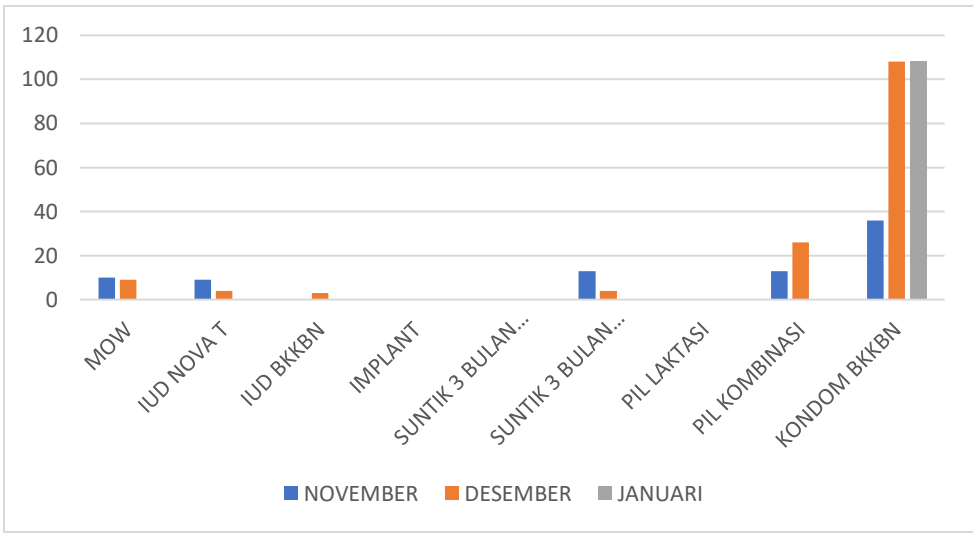
Analisis :
Terdapat 1 pasien stunting dan wasting pada bulan November 2024, dan 1 pasien stunting wasting di bulan Januari 2025. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut. Edukasi pemberian intervensi lanjut dilakukan dengan cara mengunjungi kediaman

3.1.2.5 KBRs
3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN NOVEMBER 2024	BULAN DESEMBER 2024	BULAN JANUARI 2025
1	MOW	10	9	10
2	IUD Nova T	9	4	9
3	IUD BKKBN	0	3	3
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	13	4	3
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	0	9	11
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	13	26	32
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	36	108	108

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan November turun (10) Desember turun (7) Januari (10)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan November naik (9) Desember turun (4) Januari (9)
- 3. Peserta IUD BKKBN November (0) Desember naik (3) Januari (3)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan November (13) Desember turun (4) Januari (3)
- 5. Peserta KB suntik progestin Desember (9) Januari (11)
- 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan November menurun (13) Desember naik (26), Januari (32)
- 7. Peserta KB Kondom pada bulan November menurun (36) Desember meningkat(108) Januari (108)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

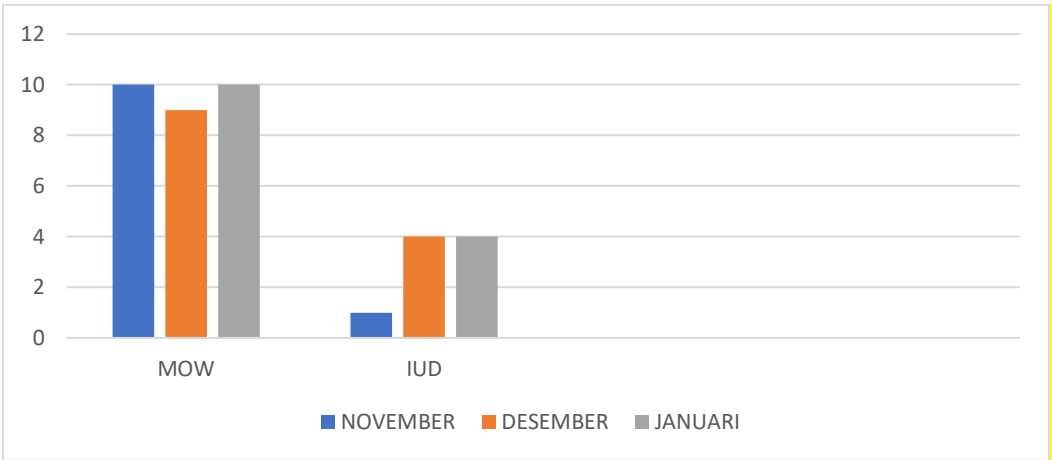
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

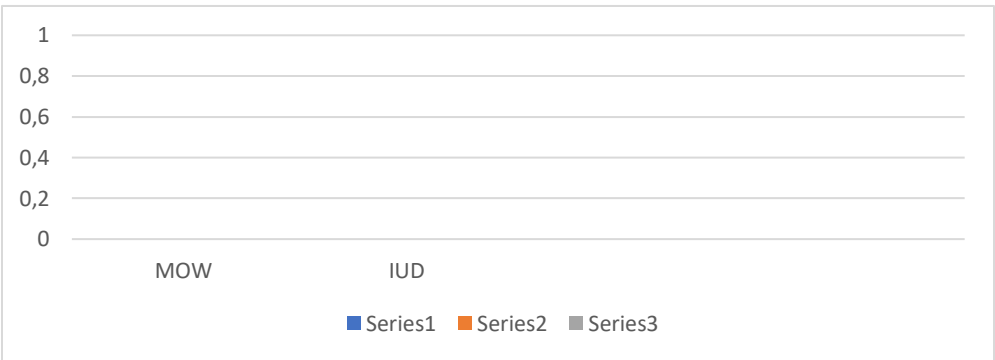
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	MOW	10	9	10
2	IUD	1	4	4

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		NOVEMBER 2024	DESEMBER 2024	JANUARI 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan November -Desember-Januari meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan November – Desember -Januari menetap.

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2024

3.2.2.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan November 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Istiqomah	P/58	dr. Ardhi, Sp.PD	221889	Dengue Fever (DF)	31/10/2024	05/11/2024	6	Ceftriaxone	2	2x1	12	2	6
									Levofloxacin inf		1x0,5	2	0,5	4
2	Eka Dia	P/20	dr. Aida, Sp.OG	207900	SC	03/11/2024	05/11/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
3	Wiwin	P/33	Dr. Ardhanay, Sp.Pd,K-GH	222013	Gastroenteritis and colitis	03/11/2024	06/11/2024	4	Metronidazole inf	1	3x0,5	3,5	1,5	2,33
4	Samsuri	L/80	dr. Elvi, Sp.P	222055	COPD	04/11/2024	07/11/2024	4	Ceftraixone	2	2x1	7	2	3,5
									Azitromycin		1x0,5	1,5	1,5	1
5	Erma Andriyanti	P/47	dr. Edi, Sp.U	185268	Unspecified Renal Colic	05/11/2024	07/11/2024	3	Meropenem	1	1x1	3	3	1
6	Muh Roji'in	L/53	dr. Anton, Sp.B	222172	Hernia Scrotalis (D)	07/11/2024	09/11/2024		Ceftizoxime	2	1x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	0,2
7	Charlos J	L/21	dr. Anton, Sp.B	222271	Necrotizing Facitis	09/11/2024	11/11/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
8	Rachmah Dheny	P/46	dr. Ardhi, Sp.PD	174600	Nausea and Vomitinh	09/11/2024	12/11/2024	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,4	0,8	3
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
9	Yuniningtyas R	P/47	dr. Humaira, Sp.OG	098894	Kista Bartolinitis	11/11/2024	12/11/2024	2	Cefriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ciprofloxacin po		2x0,5	1	1	1
10	H. Hardjono	L/70	dr. Ardhi, Sp. Pd	075275	DM Hiperglikemi	13/11/2024	17/11/2024	5	Cefriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Levofloxacin po		1x0,5	1,5	0,5	3
11	Khotima Nurlela	P/22	dr. Humaira, Sp.OG	210213	SC dalam keadaan emergency	14/11/2024	17/11/2024	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

12	Zainuddin	L/54	dr. Zaki, Sp.B	222651	Hemoroid, Anemia	17/11/2024	20/11/2024	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
13	Rumakyah	P/61	dr. Zaki, Sp.B	079000	Necrotizing Facitis	17/11/2024	19/11/2024	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
14	Bagus Sulisty	L/26	dr. Arianto, Sp.OT	222669	Disorder of patella	18/11/2024	19/11/2024	2	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
15	Ridho Ardiansyah	L/38	dr. Andy, Sp.P	218504	Typhoid Fever	18/11/2024	22/11/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Levofloxacin po		1x0,5	1,5	0,5	3
16	Muchamad Yusuf	L/76	dr. Elvi, Sp.P	209724	Obs Dyspnea	20/11/2024	22/11/2024	3	Levofloxacin inf	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5
17	Dwi Erna	P/34	Dr. Heri, Sp.Pd	222833	Colic Abdomen	21/22/2024	23/11/2024	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,6	0,8	2
18	Marsiyah	P/62	dr.Andi, Sp.B	202411	Ascites	23/11/2024	25/11/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Metronidazole inf		3x0,5	3	1,5	2
19	Susanti	P/24	dr. Zaki, Sp.B	223100	Ileus obstruktif	27/11/2024	29/11/2024	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Soerjati	P/79	dr. Anton, Sp.B	060759	Necrotizing Facitis	28/11/2024	30/11/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75

3.2.2.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Desember 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Emi	P/65	dr. Farid, Sp. N	222921	Hydrocephalus	23/11/2024	04/12/2024	12	Ceftriaxone	3	2x1	15	2	7,5
									Meropenem		3x1	14	3	4,67
									Levofloxacin inf		1x0,5	1,5	0,5	3
2	Reni Fitrijayanti	P/36	dr. Anton, Sp.B	189252	Acute lymphadenitis of face	30/11/2024	02/12/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
3	Amanie	P/63	dr. Zaki, Sp. B	193977	Necrotizing facitis	30/11/2024	03/12/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
4	Djatkiko	L/70	dr. Heri, Sp. Pd	102366	DM Hiperglikemi	30/11/2024	3/12/2024	4	Metronidazole inf	1	2x0,5	3,5	1,5	2,33
5	Rektiyani	P/47	dr. Ardhany, Sp.Pd	217160	DM Type 2	02/12/2024	06/12/2024	5	Levofloxacin inf	2	1x0,75	1,5	0,5	3
									Meropenem		3x1	9	3	3
6	Raymond S	L/75	dr. Andy, Sp. P	168930	COPD	03/12/2024	10/12/2024	8	Cefoperazone sodium	2	2x1	9	4	2,25
									Gentamycin inj		2x0,08	0,48	0,24	2
7	Suyatno	L/76	dr. Heri, Sp. Pd	058618	DM	06/12/2024	10/12/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Sulfasalazine		2x0,5	4	2	2
8	Suginem N	L/69	dr. Heri, Sp. Pd	077564	TF	07/12/2024	10/12/2024	4	Levofloxacin po	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5
9	Dasuki	L/64	dr. Andy, Sp. P	186331	COPD	09/12/2024	12/12/2024	4	Azithromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
10	Riyanto	L/70	dr. Zora, Sp. Pd	192849	DM, TF	10/12/2024	14/12/2024	5	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2,5	0,5	5
11	Amalia W	P/45	dr. Aida, Sp. OG	223649	Leiomyoma of uterus	12/12/2024	14/12/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	0,2
12	Nuryati	P/61	dr. Ardhi, Sp. Pd	059905	Colic Abdomen	13/12/2024	17/12/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2,8	0,8	3,5
13	Jito	L/62	dr. Ardhany, Sp.Pd	224093	Febris	17/12/2024	20/12/2024	4	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Asam pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2

									Levofloxacin po		1x0,75	1,5	0,5	3
14	Teko Wahyu P	L/56	dr. Anton, Sp.B	216562	Necrotizing fasciitis	18/12/2024	20/12/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	8	2	4
									Metronidazole po		3x0,25	2	2	1
15	Sukoyo	L/47	dr. Titok, Sp.	077824	Injury of eye and orbit	19/12/2024	23/12/2024	5	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Ciprofloxacin inj		2x0,4	1,6	0,8	2
16	Tony Setiawan	L/61	dr. Ardhi, Sp. Pd	196592	TF	19/12/2024	24/12/2024	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Levofloxacin po		1x0,5	2,5	0,5	5
17	Fany Chusnia	P/33	dr. Humaira, Sp. OG	116999	SC	21/12/2024	23/12/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
18	Tarista S	P/23	dr. Humaira, Sp. OG	202207	SC	21/12/2024	23/12/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Santi Supriatin	P/47	dr. Fachry, Sp. BS	224293	Hydrocephalus	21/12/2024	24/12/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Clindamycin po		4x0,6	7,2	1,2	6
20	Sudi Winarti	P/79	dr. Pradana, Sp.U	224481	Hematuri	24/12/2024	26/12/2024	3	Ceftizoxime	1	2x2	2	4	0,5

3.2.2.1.4 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Januari 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Evani Sanchia	P/35	dr. Humaira, Sp.OG	216894	Pre Eklamsia Ringan	31/12/2024	02/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
2	Rifa Kumala	P/48	dr. Pradana, Sp. U	194596	Cystoscopy	02/01/2025	04/01/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
3	Badariyah	P/55	dr. Ardhi, Sp.Pd	220134	DM type 2	02/01/2025	06/01/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Levofloxacin po		1x0.5	1,5	0,5	3
4	Robanah	P/64	dr. Zora, Sp.PD	224961	DM Hiperglikemi	04/01/2025	08/01/2025	5	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	1,4	0,8	1,75
									Asam Pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2,5
5	Muliani	P/68	dr. Yoga, Sp.JP	149322	Dyspnea	05/01/2025	10/01/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Ciprofloxacin po		2x0,5	4,5	1	4,5
6	Wahyu Aris	L/27	dr. Zaki, Sp.B	225127	Hemoroid	06/01/2025	09/01/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
7	Supiani	P/44	dr. Aida, Sp.OG	223418	PRM	07/01/2025	09/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
8	Supriyadi	L/46	dr. Anton, Sp.B	212029	Necrotizing fasciitis	07/01/2025	09/01/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftizoxime		3x1	6	4	1,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
9	Suliana	P/34	dr. Anton, Sp.B	199917	Necrotizing fasciitis	14/01/2025	16/01/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
10	Rara Ayu	P/29	dr. Aida, Sp.OG	156799	SC	16/01/2025	18/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Musringatun	P/46	dr. Zaki, Sp.B	095948	Susp appendicitis acute	16/01/2025	19/01/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
12	Paeri	L/63	dr. Ardhany, Sp. Pd	225648	Systemic inflamatory	16/01/2025	19/01/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3

13	Desi Ayu	P/29	dr. Humaira, Sp.OG	217065	SC	17/01/2025	19/01/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Sulasmini	P/57	dr. Ira, Sp.JP	225708	Angina Pectoris	17/01/2025	24/01/2025	8	Azitromycin	2	1x1	1,5	0,3	5
									Levofloxacin inf		1x0.75	3	0,5	6
15	Paini	P/58	dr. Zaki, Sp.B	213310	Cholangitis ikterik	18/01/2025	19/01/2025	2	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Metronidazole inf		3x0,5	3	1,5	2
16	Suryanto	L/61	dr. Farid, Sp. U	201834	CVA	18/01/2025	21/01/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
17	Tjong Sui Lan	P/69	dr. Ardhii, Sp.Pd	174685	Colic Abdomen	19/01/2025	26/01/2025	8	Ceftiaxone	2	2x1	4	2	2
									Cefoperazone		2x1	10	4	2,5
18	Atim	P/63	dr. Zaky, Sp.B	064323	Gangren daibeticum	22/01/2025	25/01/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3.5
									Cefoperazone		1x2	2	4	0.5
									Metronidazole inf		3x0,5	5	1,5	3,33
19	Ngadi	L/72	dr. Elvi, Sp.P	225992	Dyspnea	22/01/2025	25/01/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Levofloxacin inf		1x0,75	1,5	0,5	3
									Asam Ppipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2,5
20	Kustinah D	P/50	dr. Heri, Sp.Pd	225997	DM type 2	22/01/2025	26/01/2025	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	3,6	0,8	4,5

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

3.6.6.1 Tabel Dokumen Rekam Medis Elektronik Bulan Januari 2025

NO	NAMA PERAWAT	Σ DRM	PENGKAJIAN KEPERAWATAN				KELENGKAPAN			
			L	TL	V	TV	%L	NILAI	%V	NILAI
1.	Sistha Ghea Aprilia, Amd. Kep	50	45	5	90%	10%	90%	45	10%	5
2.	Ns. Betdi Prasetyo, S.Kep	30	24	6	80%	20%	80%	24	20%	6
3.	Wibowo Krisdianto, Amd. Kep	43	37	6	86%	14%	86%	37	14%	6
4.	Hana Hamimah, Amd.Keb	72	68	4	94%	6%	94%	68	6%	4
5.	Rosi Slamet Saputri, S.Kep,Ns	54	47	7	87%	13%	87%	47	13%	7
6.	Bdn. Nurul Azizah Jihad Fisabilillah, S.Tr.Keb	85	80	5	94%	6%	94%	80	6%	5
7.	Leny Puji Rahayu, Amd. Keb	94	91	3	97%	3%	97%	91	3%	3
8.	Tuti Dwi jayati, Amd.Keb,SE	70	65	5	93%	7%	93%	65	7%	5
9.	Oktavia Amelia Sari Amd. Kep	52	46	6	88%	12%	88%	46	12%	6
10.	Ns. Tika Aryuni, S.Kep	33	29	4	88%	12%	88%	29	12%	4
11.	Ria Christiasari, Amd.Kep	34	24	10	71%	29%	71%	24	29%	10
12.	Khairun Nisa, A.Md.Kep	39	33	6	85%	15%	85%	33	15%	6
13.	Adelia May Adetry, Amd.Kep	36	32	4	89%	11%	89%	32	11%	4
14.	Raysa Rosadila, Amd. Kep	41	34	7	83%	17%	83%	34	17%	7
15.	Dyah Kusuma W, Amd.Kep	32	27	5	84%	16%	84%	27	16%	5
16.	Maulidya Sari, Amd.Kep	45	40	5	89%	11%	89%	40	11%	5
17.	Ns.Isa Ariyanti, S.Kep	40	34	6	85%	15%	85%	34	15%	6
18.	Ns. Winda Lestari, S.Kep	45	37	8	82%	18%	82%	37	18%	8
19.	Ns. Andraina Wulandari Oktavia, S. Kep	41	36	5	88%	12%	88%	36	12%	5
20.	Reyna Oktavia Kristianti, Amd.Kep	38	34	4	89%	11%	89%	34	11%	4
21.	Ns. Cyntia Sapta Anggraeni, S.Kep	26	22	4	85%	15%	85%	22	15%	4
22.	Ns. Anggun Tria Istiqomah, S.Kep	24	20	4	83%	17%	83%	20	17%	4
23.	Ajeng Ika Octavianna, SST	18	10	8	56%	44%	56%	10	44%	8
24.	Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns	9	9	0	100%	0%	100%	9	0%	0
25.	Yuni Novita, Amd. Kep	48	45	3	94%	6%	94%	45	6%	3
26.	Ns. Rara Ayu Dewanti, S.Kep	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0
27.	Devi Kartika Sari, Amd.Kep	32	26	6	81%	19%	81%	26	19%	6
28.	Fisioterapis	73	58	15	79%	21%	79%	58	21%	15
TOTAL		1204	1053	151	83%	14%	83%	1053	14%	151

Analisis :

- 1. Dari table diatas, dapat diketahui hanya terdapat 1 perawat dengan kelengkapan 100% dari 28 perawat.
- 2. Ada 1 perawat gigi dengan ketidaklengkapan dibawah 60%.

Masalah :

Hanya 3.5% dari total keseluruhan jumlah perawat yang kelengkapan DRM nya 100%.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Ruang.
- 2. Melakukan teguran terhadap petugas yang mempunyai PR kelengkapan RM.
- 3. Melakukan telusur dan perbaikan.
- 4. Koordinasi dengan Programmer.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Menemukan seperti klem tali pusat dan bolpoin di baju iko saat di laundry	P	Mensosialisasikan ke cs IKO untuk skrining barang yanag ada di saku perawat sebelum dikirim ke laundry
		D	Koordinasi dengan cs IKO dilakukan pengecekan sebelum diambil oleh laundry
		S	Beberapa khusus seperti bolpoin,klem yang masuk ke laundry
		A	Membuat kebijakan sebelum baju di ambil laundry
2	Kerusakan mesin anastesi di IKO 2	P	Berkoordinasi dengan atem untuk menelusur kerusakan mesin di IKO
		D	Melakukan pengajuan jika sudah tidak bisa digunakan
		S	Kasus mesin anastesi di iko 2 rusak
		A	Setiap 1 bulan sekali dilakukan maintenance untuk monitoring mesin anastesi

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Kelengkapan SOAP di IGD	P	Mengoptimalkan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan jaminan yang di kliam bpjs dan sesuai dengan kondisi pasien
		D	Koordinasi dengan kains IGD terkait ketepatan pemeriksaan fisik pasien dan penulisan yang tepat untuk dr IGD
		S	Menemukan rekam medis yang di tulis dr IGD tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi pasien
		A	Menjalankan pemeriksaan fisik yang tepat sesuai dengan rapat
2	IGD tidak dapat melihat riwayat pengobatan	P	Koordinasi dengan tim IT dan programer untuk komputer di IGD bisa di akses Icare
		D	Memfolloup untuk kelanjutan akses icare di simrs
		S	Dokter IGD kesulitan melihat riwayat obat
		A	Melakukan pengajuan ke pt untuk diberikan aplikasi icare
3	Ada bebrapa dokter IGD masih ragu dalam memberikan terapi awal karena takut disalahkan oleh DPJP karena salah terapi	P	Koordinasi dengan superviser IGD untuk menentukan terapi sesuai dengn kompetensi IGD
		D	Memberikan kebebasan dokter IGD menentukan dan memberikan terapi awal kegawatdaruratan
		S	Menemukan beberapa kasus dokter IGD sering disalahkan oleh dokter dpjp terkait terapi dan konsulan
		A	Manajemen memberikan kebebasan dr IGD sesuai dengan kompetensi sesuai denagn SPK

			dan RKK, jika dirasa masih bingung bisa dikonsulkan ke supervisor IGD
4	Saat pindah ruangan biasanya harus menunggu tlpn konfirmasi dari IGD untuk pindah	P	Mentelusur unit yang kurang visioner
		D	Koordinasi dengan karu iGD dan semua unit rawat inap
		S	Menemukan beberapa kendala saat akan transfer pasien ke rawat inap
		A	Melakukan komunikasi 2 arah sehingga tidak saling menunggu
5	Kondisi over capacity dari IGD dengan total bed 20 masih kurang saat crowdit	P	Koordinasi dengan karu ,kains dan yamed untuk mendata untuk jam jam crowdit
		D	Melakukan pengajuan ke PT untuk bed cadangan yang ada di IGD
		S	Kekurangan bed saat pasien banyak di IGD dan meminjam bed IKO
		A	Memfolloup pengajuan bed jika belum datang
6	Waktu balasan DPJP yang sangat lama	P	Koordinasi dengan supervisor IGD mencari solusi untuk membuat data di IGD untuk dpjp
		D	Koordinasi dengan karu IGD untuk mencatat balasan dokter dpjp yang lama
		S	Banyak dpjp yang membalas jawaban pasien sangat lama dan tidak mau di telpon
		A	Melakukan pencatatn yang rapi untuk raport dpjp dan menjalankan sop yang sudah ada untuk konsul dpjp

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Kekurangan ruangan isolasi ICU	P	Koordinasi dengan supervisor IGD untuk mencari solusi jika isolasi penuh
		D	Koordinasi dengan direktur untuk ruang HCU di buat ruang isolasi ICU
		S	Bulan januari ada 1 kasus pasien membutuhkan ruangan isolasi dengan back up ventilator tetapi saat itu ada pasien sehingga tidak bisa masuk
		A	Membuat SK penambahan TT
2	IGD dan ruangan rawat inap masih belum paham aplikasi SITB	P	Koordinasi dengan semua unit untuk skrining pasien yang mengarah ke TB
		D	Kolaborasi dengan karu isolasi untuk mensosialisasikan pengaplikasian SITB yang ada di semua unit
		S	Ada beberapa kasus di IGD tidak terskrining dengan baik sehingga tdak tepat dalam penempatan pasien
		A	Membuat alur untuk cara menggunakan aplikasi sehingga bisa digunakan semua perawat pelaksana
3	Kelengkapan pengkajian awal IGD lebih teliti dalam pengisiannya	P	Mengadakan rapat karu IGD dan rawat inap membahas kelengkapan pengkajian awal IGD
		D	Membuat kesepakatan antara IGD dan rawat inap saat transfer ke rawat inap harus di cek untuk kelngkapan pengkajian awal IGD
		S	Menemukan beberapa kasus dr DPJP yang

4	Semua karu wajib mengontrol semua alkes di unit		komplain dengan tidak lengkapnya pengisi
		A	Menjalankan sesuai dengan kesepakatan antara kepala ruangan dan di sosialisasikan kepada perawat pelaksana
		P	Melakukan sosialisasi ke semua karu untuk mencatat semua alkes yang ada di unit masing masing
		D	Koordinasi dengan atem mencocokkan barang yang ada di unit
		S	Ada 1 kasus di unit barang rusak
		A	Membuat kebijakan ke unit jika kesalahan human eror akan di tanggungkan ke perawat yang bersangkutan

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Penyesuaian surat kontrol	P	Koordinasi dengan pendaftaran untuk kie jika mundur kontrol harus konfirmasi terlebih dahulu
		D	Sosialisasi ke semua pasien lewat media sosial untuk kontrol mundur tidak bisa di layani
		S	Beberapa pasien komplain terkait tidak bisa di layani dengan tidak sesuai jadwal kontrol
		A	Berkoordinasi dengan asisten dan pendafran tentang sosialisasi ini
2	Penyesuaian E-casemix,ada beberapa anamnesa dan diagnosa yang kurang sesuai	P	Rapat antara unit irja dan asuransi center
		D	Koordinasi antara verifikasi dan karu untuk di lengkapi ulang
		S	Masih ada beberapa yang tidak lengkap di poli
		A	Feriv selalu mengingatkan ke bagian asisten perawat poli jika belum lengkap langsung bisa di lengkapi
3	Rujuk Internal	P	Sosialisasikan rujuk internal dalam 1 hari dan beda hari sesuai ke advice dpjp
		D	Koordinasi dengan karu rawat jalan dan asuransi center
		S	Menemukan bebrapa kasus di rawat jalan yang ada di rujuk internal dalam 1 hari dan beda hari
		A	Kesepatan dari asuransi dan karu kain dan manajmen untuk rujuk internal sesuai dengan advice dpjp

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. November 2024 : +12.731.643 Desember 2024 : +25.820.296 Januari 2025 : +226.818 Belum berjalan scan barcode menunggu antrian Programmer PT.	P	Perencanaan scan barcode.
		D	1. Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. 2. Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan

			pelayanan pasien.
		A	Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
2.	Ruang Pencampuran Obat (LAF) tidak sesuai standar akreditasi. Saat ini proses renovasi di Lantai 4 Maternitas. Ruang Ganti sudah ada wastafel dan toilet, ditambahkan ruangan anteroom.	P	Melakukan renovasi LAF.
		D	Melakukan survey lokasi yang cocok untuk perpindahan ruangan LAF yang baru.
		S	Mengacu pada penilaian ruangan LAF pada akreditasi Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan standar.
		A	6) Kolaborasi dengan PT untuk meminta tukang melakukan renovasi sesuai dengan standar akreditasi (denah sudah diberikan). 7) Penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-bock air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran.
3.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 76.95% dan waktu tunggu obat racikan 59.54%	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1) Follow up ke Programmer. 2) Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 408 KPO.
4.	Selisih sediaan sharing dose antara fisik dengan monitoring stok pada sistem	P	Memperbaiki cara penginputan pada SIMRS.
		D	Melakukan rapat koordinasi dengan perawat anastesi bersama Kains Farmasi, Karu IKO dan Kabid Keperawatan.
		S	Penginputan penggunaan sediaan sharing dose seperti isonest yang tidak dipantau mengakibatkan selisih saat stok opaname.
		A	1) Membuat satu pemahaman cara penginputan, kesepakatan minimal penginputan 0.1. 2) Membuat tabel penggunaan pada sediaan isonest untuk mempermudah perawat anastesi melanjutkan penginputan supaya menghasilkan jumlah pemakaian bulat 1 botol. 3) Monitoring dan Evaluasi setiap hari. 4) Supervisi oleh Kabid.
5.	Sediaan vaksin yang tidak segera digunakan oleh pasien sejak tahun 2023, barang ada di Kulkas Depo Farmasi.	P	Memperbaiki pencatatan keluar masuknya inden vaksin. Meperbaiki kebijakan inden vaksin dari Poli Spesialis.
		D	Kolaborasi dengan Kains Farmasi, Gudang Farmasi, MOD, Kasir dan Karu IRJA.
		S	Pemesanan vaksin hexaxim an An Yahya Hermawan sejak Juli 2023 belum digunakan, inden vaksin menggunakan jaminan Asuransi.
		A	8) Membuatkan spreadsheet pemesanan vaksin dengan keterangan jadwal vaksin dan ED vaksin untuk memudahkan MOD

			menginformasikan kepada pasien. 9) Membuat kebijakan pembayaran penuh untuk inden vaksin meskipun jaminan asuransi, uang akan direture jika pasien datang untuk pelaksanaan vaksin. 10) Menghubungi pasien-pasien yang tidak datang sesuai jadwal untuk kepastian jadwal pelaksanaan, jika tidak ada DP maka dialihkan kebutuhannya untuk pasien lain. 11) Menyediakan VR di Depo Farmasi.
6.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi deathmoving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1) Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2) Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3) Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
7.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan indicator vaksin pemerintah yang berubah warna sehingga tidak layak digunakan.	P	Mengadakan VR di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli.

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortorium RSPH Malang.
		D	Mengingatnkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Petugas belum kompeten dalam pelaksanaan crossmatch labu darah	P	Mendaftarkan pelatihan/magang secara bergilir.
		D	1) Melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan crossmatch. 2) Melakukan pelatihan dengan vendor.
		S	Hasil crossmatch menentukan apakah labu darah bisa diberika kepada pasien atau tidak, jika hasil aglutinasi positif maka tidak bisa diberikan.

		A	1) Melakukan pencatatan pengulangan kegiatan crossmatch. 2) Permintaan labu darah cito ketika malam hari sementara permintaan ke PMI Lawang terlebih dulu. 3) Petugas magang secara bergilir setiap 2 minggu sekali.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 2. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 3. Menentukan stok minimal untuk order reagen.
5.	Pengadaan rectal swab di Lab RS Prima Husada Malang	P	Mengajukan TOR pelayanan rectal swab.
		D	Diskusi dengan Kains Laboratorium RS, dr Ari Putri, Sp.PA
		S	Utilitas jarang tidak direkomendasikan, kecuali jika bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk MCU.
		A	Proses perhitungan unit cost, jika sudah maka akan diajukan TOR

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan

	tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan		meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan.
		S	Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
		A	12) Melakukan edukasi kepada pasien yang pulang rawat inap atau selesai control di IRJA untuk control sesuai dengan jadwal yang tertera di surat control, jika ingin mundur maka konfirmasi H-1 ke RS untuk dibantu edit surat control oleh petugas. 13) Melakukan edukasi berkala kepada pasien saat melakukan pendaftaran di Pendaftaran Central. 14) Membuat grup dengan unit-unit terkait untuk mendiskusikan masalah yang ditemui dan dikonsulkan dengan petugas verifikator supaya mendapatkan pemecahan masalah.
3.	Dokumen rekam medis belum tercentralisasi. Selesai Bulan Februari 2025.	P	Melakukan centralisasi DRM di ex Poli Blok 1.
		D	Merencanakan pemindahan DRM.
		S	Tidak adanya rak yang tersedia dan bertambahnya DRM dengan nomor rekam medis baru.
		A	1. Melakukan pemindahan DRM. 2. Kolaborasi dengan programmer PT untuk pemilahan DRM yang akan diretensi dan dimusnahkan. 3. Pengajuan vendor dengan system penyimpanan secara digitalisasi
4.	ERM Rawat Inap belum terlaksana, ERM rawat jalan masih ditemukan kendala.	P	Merealisasikan pelaksanaan ERM rawat Inap dan rawat Jalan pada tahun 2025.
		D	Kolaborasi dengan Programmer PT.
		S	ERM Rawat jalan sudah terlaksana, tetapi masih banyak ketidaklengkapan dalam penginputan ERM.
		A	Follow up terus menerus ke programer dengan cara screenshot permasalahan dan dikirimkan via whatsapp guna menindaklanjuti permasalahan tersebut agar proses validasi ERM berjalan lancar.

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1) Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2) Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid.	P	Memperbaiki pencatatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan. Pencatatan real per lantai.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi	P	Memperbaiki respon time pelayanan radiologi.
		D	Kolaborasi antara perawat dan radiographer dengan DS Radiologi.
		S	Pencatatan dapat diketahui respon time pelayanan radiologi dari selesai periksa sampai dengan selesai hasil.
		A	Melakukan pencatatan waktu permintaan dan selesai hasil di Google Spreadsheet.

3.7.11 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Pendistribusian alat makan tidak tercatat dengan baik	P	Memperbaiki alur pengecekan fasilitas RS sebelum pasien KRS.
		D	Kolaborasi Ahli Gizi dengan Pendaftaran IGD, Perawat, CS Pantry, CS Ruangan dan Kasir.
		S	Fasilitas RS resiko hilang karena pasien jika tidak dibuatkan alur yang jelas. Petugas wajib memberikan edukasi untuk meminimalisir kehilangan/kerusakan.
		A	Membuat SPO "Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS". Sosialisasi kepada Unit Terkait

3.8 Profil SDM
3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Bidan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	1	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	0	0	0	0	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	41	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		20	12	8	0
		SMK		2	1	1	0
		S1 Akuntansi		0	0	0	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		D3 Farmasi		0	0	0	0
		SMK		1	0	1	0
		SMA		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	5	3	2	1	0
		D4 Fisioterapi		1	0	1	0
		S1 Profesi Fisioterapi		1	0	1	0
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	25	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0

		SMK		3	3	0	0
19	IRJA	Profesi Ners	25	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		13	12	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		8	5	3	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
26	Neonatalogi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0

		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	16	8	8	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
40	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
48	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
51	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
52	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
53	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
54	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
56	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total				455			

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Januari 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Januari 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Januari 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS-RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025